

(Anatomie : octobre 2024)

Le nerf médian est : (Cocher la réponse juste)

1-Un nerf exclusivement moteur

2-Un nerf exclusivement sensitif

3-Un nerf mixte sensitivomoteur

4-Une branche collatérale du plexus brachial

5-Une branche terminale du plexus brachial

A : 1+5 B : 1+4 C : 2+4 D : 2+5 E : 3+5

▫ Cytologie ▫

Cytologie (Octobre 2024)

1. Quel organe est impliqué dans la modification, le tri et l'expédition des protéines ?

(Cocher la réponse juste)

- A. Réticulum endoplasmique rugueux
- B. Appareil de Golgi
- C. Mitochondrie
- D. Lysosome
- E. Réticulum endoplasmique lisse

B

2. Quel composant du cytosquelette est responsable du mouvement des cils et des flagelles ?

(Cocher la réponse juste)

- A. Microfilaments
- B. Microtubules
- C. Filaments intermédiaires
- D. Centrioles
- E. Actine

B

3. Quel processus cellulaire est principalement responsable de la division du cytoplasme après la mitose ? (Cocher la réponse juste)

- A. Mitose
- B. Cytocinèse
- C. Méiose
- D. Endocytose
- E. Exocytose

B

Cytologie (Décembre 2022)

1. Concernant la mitochondrie : (RF)

- A. La membrane externe laisse passer les molécules de petite taille
- B. Elle comporte son propre ADN et ribosomes
- C. Les membranes interne et externe ne sont jamais en contact
- D. Le nombre de crêtes varie selon l'activité mitochondriale
- E. Les mitochondriopathies sont le résultat d'un déficit dans la chaîne respiratoire

C

2. Les lysosomes :(RJ)

- A. Présentent une double membrane
- B. Sont Dérivés de la membrane de l'appareil de Golgi
- C. Présentent des oligosaccharides sur la face externe
- D. Ont un site de dégradations d'origine endogène uniquement
- E. Sont très nombreux dans les globules rouges

B

Cytologie 2021 (Février 2022)

3- Les mitochondries ont les fonctions suivantes : (RF)

- A) Métabolisme oxydatif
- B) Cétogenèse
- C) Synthèse des hormones stéroïdiennes
- D) Bloquent l'apoptose (mort cellulaire programmée)
- E) Interviennent dans la fertilité masculine et féminine

D

4- Les peroxysomes : (RJ)

- A) Assurent la détoxification cellulaire
- B) Sont composés d'une double membrane
- C) Sont de petite taille dans les cellules hépatiques et rénales
- D) Renferment des hydrolases et des produits de dégradation
- E) Libèrent du H₂O₂ qui n'est pas

A

Cytologie (Décembre 2020)

10- Les peroxysomes : (RF)

- A) Libèrent de la chaleur .
- B) Ont des fonctions anaboliques et cataboliques .
- C) Produisent de l'H₂O₂ .
- D) Assurent la dégradation des acides biliaires .
- E) Peuvent causer l'adrénoleucodystrophie

D

Embryologie (octobre 2024)

1.Qu'est-ce que la capacitation des spermatozoïdes ? (Cocher la réponse juste)

- A. C'est la dernière étape de modification physiologique avant la fécondation
- B. C'est un phénomène qui se déroule dans les tubes séminifères
- C. La capacitation permet la formation d'un sperme riche
- D. La capacitation est une condition préalable à la réaction acrosomique
- E. C'est la première étape avant maturation. A

2.Le follicule secondaire est constitué de ? (Cocher la réponse juste)

- A. Fait d'un ovocyte 2 bloqué en prophase
- B. Fait de cellules folliculaires aplaties
- C. Présence de zone glycoprotique (la zone pellucide) à l'extérieur de l'épithélium folliculaire
- D. Le stroma ovarien se transforme en thèque du follicule
- E. Présence d'une cavité folliculaire (antrum) dans la granulosa D

3.Qu'est-ce que le phénomène de la compaction ? (Cocher la réponse juste)

- A. C'est la formation d'un amas de cellules jointives qu'on appelle la morula
- B. C'est une modification morphologique et fonctionnelle de la morula
- C. La compaction donne uniquement les cellules trophoblastiques
- D. La compaction permet l'apparition exclusivement des cellules du bouton embryonnaire
- E. C'est un phénomène qui se déroule pendant la seconde semaine du développement embryonnaire B

4.Concernant le corps progestatif : (Cocher la réponse juste)

Les cellules de la granulosa deviennent des cellules lutéales

Les cellules de la thèque interne élaborent de la progestérone

Les cellules de la granulosa élaborent de la progestérone

Les capillaires de la thèque interne envahissent la granulosa

Les cellules de la thèque interne sont les cellules les plus volumineuses

A : 1+2+4 B : 1+3+5 C : 1+3+4 D : 2+4+5 E : 3+4+5 C

▫ Anatomie ▫

Anatomie (octobre 2024)

1. Parmi les propositions suivantes indiquez la proposition juste :

1. Le polygone de Willis fait communiquer le territoire artériel carotidien et le système vertébro-basilaire
2. Les territoires droit et gauche des artères carotides internes communiquent entre eux grâce à une artère communicante postérieure
3. La perméabilité du polygone de Willis joue son rôle essentiel de suppléance en cas d'accident vasculaire cérébral
4. Les principales branches collatérales de la carotide interne sont l'artère cérébrale moyenne (ou sylvienne) et l'artère chorodienne antérieure
5. Parmi les branches terminales de la carotide interne on cite l'artère hypophysaire et l'artère ophtalmique

A : 1+2+3 B : 1+3 C : 2+5 D : 2+4+5 E : 2+3+4 B

2. Parmi les propositions suivantes indiquez la proposition juste :

1. Le système postérieur (vertébro-basilaire) assure la vascularisation du tronc cérébral et du cervelet
2. Parmi les branches collatérales des artères vertébrales on cite des rameaux perforants destinés au bulbe et au pont, l'artère cérébelleuse antéro-inférieure
3. Les artères cérébrales postérieures sont des branches terminales du tronc basilaire
4. Les territoires artériels profond et superficiel du cerveau sont indépendants l'un de l'autre
5. L'artère cérébrale antérieure chemine le long de la fissure latérale du cerveau

A : 2+4+5 B : 1+3+5 C : 1+3+4 D : 1+4+5 E : 3+4+5 C

3. Le duodénum et le pancréas : (Cocher la réponse juste)

- A. Le duodénum est seulement sous- mésocolique
- B. La muqueuse duodénale est munie de nombreux plis longitudinaux au niveau de la partie supérieure
- C. La tête du pancréas est effilée
- D. Le canal de Santorini parcourt tout le pancréas selon son grand axe
- E. L'ampoule de Vater s'ouvre dans le bord latéral de D2 E

Anatomie (Février 2023)

1- Cochez la réponse juste :

- 1) Au niveau de l'ampoule rectale, les valvules de Houston sont des plis transversaux
- 2) Le rectum fait suite au sigmoïde au niveau de S1
- 3) La partie pelvienne du rectum est oblique en bas et en avant
- 4) Le rectum est situé en avant de L4, LS et le sacrum
- 5) Colonnes anales de Morgani saillies verticales situées au niveau du canal anal

E

A:1+2+3 B:2+3+5 C:1+4+5 D:3+4+5 E:1+3+5 E

2- Cochez la réponse Juste

- 1) La glande thyroïde est une glande Impaire mixte
- 2) Le fascia thyroïdien est une dépendance de la gaine viscérale du cou
- 3) Le lobe thyroïdien est fixé à la trachée par le ligament médian de Gruber
- 4) La glande thyroïde est plus développée chez l'homme que chez la femme
- 5) La glande thyroïde est innervée par les nerfs vague A

A:2+5 B:4+5 C:3+5 D:1+4 E :3+4

3- Cochez la réponse juste

- 1) Les vaisseaux iliaques internes représentent les rapports latéraux du rectum pelvien
- 2) L'espace retro-rectal contenant les vaisseaux sacres moyens , sympathique sacres et les uretères
- 3) La séreuse péritonéale, recouvre seulement la partie supérieure des faces Antérieure et postérieures du rectum
- 4) Le coccyx est le rapport postérieur du rectum
- 5) Par l'intermédiaire du sphincter externe, le canal est en rapport en avant avec l'urètre chez l'homme D

A:1+3+4

B:1+3+5

C:2+3+5

D:1+4+5

E :2+4+5

4- Cochez la réponse Juste

- A) La glande thyroïde répond à l'aponévrose cervicale moyen engainant le muscle sterno thyroïdien
- B) La pyramide de L'alouette est un prolongement émis du lobe thyroïdien
- C) L'isthme répond aux veines thyroïdiennes antérieures en haut
- D) La face médiale du lobe thyroïdien répond au nerf vague
- E) La glande thyroïde est de surface lisse A

5- Cochez la réponse juste

- 1) Les artères rectales supérieures, sont des branches terminales de l'artère mésentérique inférieure
- 2) Les pédicules lymphatiques rectaux inférieurs se drainent dans les nœuds hypogastriques
- 3) Les veines rectales supérieures sont tributaires du système cave inférieur
- 4) Les pédicules lymphatiques rectaux supérieurs, se drainent dans les nœuds de la chaîne mésentérique inférieure
- 5) Les artères rectales supérieures assurent la quasi-totalité de la l'ampoule rectale C

A:1+2+4 B:3+4+5 C:1+4+5 D:1+2+3 E:2+4+5

6- Cochez la réponse juste

- A) La veine thyroïdienne supérieure se Jette dans le tronc thyro-linguo-facial.
- B) L'artère thyroïdienne moyenne se termine par trois branches.
- C) L'artère thyroïdienne inférieure naît de la carotide externe.
- D) Les veines thyroïdiennes antérieures se Jettent dans la veine Jugulaire interne
- E) Les lymphatiques se drainent latéralement dans les lymphonœuds pré laryngés. A

Anatomie (Décembre 2022)

1. La vessie : (RJ)

- A. La vessie vide est abdomino-pelvienne
- B. La base est mobile
- C. Le col se prolonge par l'ouraque
- D. Les Ostiums Urétéraux sont situés à 1 cm l'ostium urétral
- E. L'artère Vésicale Supérieure est issue de l'artère ombilicale E

2. A Propos de l'innervation du membre pelvien :(RJ)

- A. Chaque nerf spinal est formé par une racine dorsale motrice est une racine ventrale sensitive
- B. Le plexus nerveux se forme à partir des rameaux postérieurs des nerfs spinaux
- C. Les nerfs spinaux émergent par els foramens intervertébraux
- D. Le plexus lombaire innerve les organes génitaux internes
- E. Le nerf sciatique constitue une branche collatérale du plexus sacral C

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste :(RJ)

- A. L'estomac occupe la plus grande partie de la loge sous-phrénique gauche
- B. L'incisure angulaire est juste en arrière de l'origine du tronc coeliaque
- C. La musculeuse de l'estomac est entourée de deux feuillets de péritoine viscéral
- D. La pars flaccida est le ligament hépato-duodénal contenant le pédicule hépatique
- E. L'espace semi-lunaire de Traube est limité par deux lignes courbes et est en rapport avec la face postérieure de A

Anatomie (Février 2022)

1. A propos du trigone fémoral : (RJ)

- A) Est appelé aussi région inguino - fémorale latérale
- B) La base est limitée par le ligament inguinal
- C) Le plancher est limité par le muscle long adducteur bordé par le muscle gracile
- D) L'arcade crurale , est une bandelette fibreuse formée par les fibres inférieures de l'aponévrose des muscles larges de l'abdomen
- E) La paroi externe est formée par le bord interne du muscle pectiné B

2. A propos de la paroi antéro - latérale de l'abdomen : (RJ)

- A) Elle forme à elle seule la majeure partie des parois de l'abdomen
- B) En profondeur , elle s'étend jusqu'au péritoine pariétal inclus
- C) Superficiellement : un cadre squelettique représenté en arrière par les apophyses transverses de la colonne vertébrale dorsale et lombaire
- D) Les repères cutanés sont représentés par le sillon médian antérieur , l'ombilic , en bas par le pli inguinal qui forme la racine de la cuisse
- E) Le muscle oblique externe de l'abdomen est le plus profond de la paroi abdominale

A

A(1.2.3).

B(2.4.5).

C(1.3.5).

D(2.3.5).

E(1.2.4).

(Histologie :octobre 2024)

1. Concernant le tissu endocrinien toutes ces propositions sont justes sauf une.

Indiquer laquelle :

- A. Il peut être composé de quelques amas cellulaires dans un organe
- B. Un tissu endocrine élabore une substance appelée hormone déversée dans un canal excréteur
- C. L'antéhypophyse est une glande endocrine qui agit sur d'autres glandes endocrines
- D. Une cellule endocrine est située à proximité d'une structure vasculaire
- E. Les hormones agissent sur une cellule cible par l'intermédiaire d'un récepteur spécifique

B

2. A propos du glomérule de Malpighi : (Cocher la réponse juste)

Les capillaires glomérulaires sont fenêtrés

La lame basale de la barrière sang/urine est formée d'une lamina densa entourée de deux lamina rara

Les podocytes sont les cellules endothéliales des capillaires glomérulaires

Les pédicelles sont des cellules mésangiales

Les capillaires glomérulaires sont développés entre deux artérioles

A : 1+3+5 B : 1+3+4 C : 2+3+4 D : 2+3+5 E : 1+2+5

E

Histologie (2022)

1. Les hépatocytes :(RF)

- A. Sont riches en peroxysomes
- B. Présentent une surface vasculaire impliquée dans la sécrétion de la bile
- C. Sont séparés de l'endothélium des sinusoides par l'espace de Disse
- D. Contiennent du glycogène
- E. Reposent sur un grillage réticuline

B

Histologie (2021)

2. Concernant le corpuscule de Malpighi du rein , toutes ces propositions sont justes , sauf une laquelle ? (RJ)

- A) Les capillaires sanguins sont de type fenêtré
- B) Le feuillet viscéral de la capsule de Bowmann est formé de podocytes
- C) L'appareil juxta glomérulaire s'identifie au pôle vasculaire du corpuscule de Malpighi
- D) La lame basale des capillaires sanguins est discontinue et elle constitue l'élément principal de la filtration glomérulaire .
- E) Le conjonctif du glomérule associe une matrice conjonctive amorphe et des cellules mésangiales

D

3. La muqueuse colique se caractérise par tous les éléments suivants , sauf un lequel ? (RJ)

- A) L'absence de villosités intestinales
- B) La présence des glandes de Lieberkühn
- C) L'absence d'entérocytes
- D) La présence des cellules caliciformes
- E) La présence de nodules lymphoïdes

C

Histologie (2020)

1. En Immuno - histochimie tous cas anticorps sont à expression cytoplasmique, sauf un lequel ?(RJ)

- A) Desmine
- B) Neurofilament
- C) Vimentine
- D) Cytokératine
- E) CD3

E

2 - Les vraies cordes vocales du larynx: (RF)

- A) Ce sont les cordes vocales inférieures .
- B)Sont tapissées d'épithélium cylindrique simple .
- C) Contiennent des formations lymphoïdes
- D)Contiennent des formations glandulaires .

B

3- La paroi des bronchioles pulmonaires : (RF)

- A) Comporte un épithélium simple cilié .
- B)Comporte des cellules de Clara .
- C) Comporte des fibres musculaires lisses .
- D) Comporte des glandes de type mucineux .
- E) Ne comporte pas du cartilage .

D

4 - Dans le système artériel : (RF)

- A)La média des grosses artères élastiques ne comporte pas de muscle lisse
- B) Les artères musculaires comportent deux limites élastiques.
- C) Les vasa vasorum irriguent
- D) Les artères élastiques sont des vaisseaux de conduction .
- E)l'intima de l'artère élastique comporte une couche muqueuse.

A

Histologie (2019)

5. L'hypophyse : (Cocher la réponse exacte)

- A. Présente une partie antérieure (neurohypophyse) et une partie postérieure (adénohypophyse)
- B. L'adénohypophyse sécrète l'ADH
- C. Le plexus porte artériel vascularise l'adénohypophyse
- D. Contrôle toutes les glandes endocrines
- E. Est d'origine épiblastique uniquement périphériques

C

6. La barrière alvéolo-capillaire au niveau du poumon se compose de: (Cocher la réponse fausse)

- A. L'épithélium alvéolaire
- B. La lame basale de l'épithélium alvéolaire
- C. Le surfactant
- D. L'endothélium vasculaire avec sa lame basale
- E. Les fibres élastiques, les fibres de collagène et les cellules à poussière

E

7. Les canalicules biliaires sont de fins conduits véhiculant la bile et délimités par : (Cocher la réponse exacte)

- A. Un épithélium cylindrique reposant sur une membrane basale
- B. Un épithélium unistratifié cubique reposant sur une membrane basale
- C. Un épithélium endothéliiforme dépourvu de membrane basale D
- D. Une simple dépression en gouttière des parois des cellules hépatiques adjacentes
- E. Une simple dépression en gouttière des parois des cellules endothéliales adjacentes

8. La structure histologique du côlon se caractérise par : (Cocher la réponse fausse)

- A. Une absence totale de villosités intestinales
- B. La présence de follicules lymphoïdes
- C. Des glandes de Lieberkühn spécifiques avec une prédominance en cellules à mucus
- D. L'absence de valvules conniventes
- E. Une absence totale de villosités intestinales et de glandes choriales

E

9. Les glandes sublinguales se caractérisent par les structures suivantes : (Cocher la réponse fausse)

- A. La présence de cellules myo-épithéliales
- B. Une prédominance en cellules à mucus
- C. Une prédominance en cellules à séreuses
- D. Une absence totale de cellules centro-acineuses
- E. La présence de canaux excréteurs C

10. Concernant le lobule hépatique, toutes les propositions suivantes sont justes sauf une laquelle ?

- A. Le lobule hépatique est centré par un vaisseau sanguin
- B. Les espaces portes sont à la périphérie du lobule hépatique
- C. Le Trajet du sang va de la périphérie vers le centre du lobule
- D. Le trajet de la bile produite par les hépatocytes s'effectue vers le centre du lobule
- E. Entre les travées des hépatocytes, se localisent les capillaires sinusoides.

D

11. Parmi les propositions suivantes concernant les cellules épithéliales des vésicules thyroïdiennes, laquelle est fausse ?

- A. Elles Peuvent convertir les iodures en iodes
- B. Elles peuvent catalyser la thyroglobuline pour sécréter des hormones thyroïdienne
- C. Sont contrôlées par la TSH hypothalamique
- D. Elles élaborent secrète la calcitonine
- E. Elles sont d'origine entoblastique C

12. Le bourgeon trachéo-bronchique (diverticule respiratoire) est d'origine : (Cocher la réponse exacte)

- A. Ectoblastique
- B. Entoblastique
- C. Mésoblastique
- D. Épiblastique
- E. Neuro ectoblastique

B

13. Au niveau du parenchyme rénal, le feuillet viscéral de la capsule de BOWMAN :
(Cocher la réponse fausse)

- A. Est le feuillet interne de la capsule de BOWMAN
- B. Est constitué de podocytes
- C. Empêche le passage de grosses molécules
- D. Est une membrane conjonctive
- E. Son altération donne des anomalies dans la composition urinaire D

14. Parmi les propositions suivantes, cochez la proposition fausse :

- A. Les battements des cils aident au transport de l'ovule
- B. Les Mouvements péristaltiques de la trompe aident à l'ascension des spermatozoïdes
- C. Au cours de la période de vie libre, l'œuf subit des divisions
- D. Les échanges materno-embryonnaires se font par transports actifs au cours de la période préimplantatoire
- E. L'œuf fécondé est libre pendant la première semaine de vie D

Histologie (2018)

1. Dans l'appareil génital féminin : (RF)

- A. L'ovaire est formé de deux zones, une corticale, et une périphérique.
- B. La zone corticale est le lieu de la folliculogénèse.
- C. L'épithélium de la trompe de Fallope comporte des cellules ciliées.
- D. L'épithélium endométrial est un épithélium prismatic unistratifié.
- E. L'épithélium vaginal est un épithélium Malpighien non kératinisé. A

2. Les cellules de ITO sont des cellules de : (RJ)

- A. Soutien.
- B. Défense.
- C. Renouvellement
- D. Stockage des lipides.
- E. Synthèse. D

3. Le système vasculaire fonctionnel du lobule hépatique est : (RJ)

- A. Un système vasculaire purement veineux intercalé entre la veine centro-lobulaire et la veine de l'espace porte.
- B. Un système vasculaire artériel provenant de l'artère hépatique.
- C. Un système vasculaire artério-veineux intercalé entre l'artère hépatique et la veine porte.
- D. Un système vasculaire artériel représenté par le réseau capillaire sinusoidal.
- E. Un système vasculaire purement veineux représenté par les capillaires sinusoides intercalés entre l'artère péri-lobulaire et la veine péri-lobulaire .

A

4. Dans le système artériel : (RF)

- A. Le média des grosses artères élastiques ne comporte pas de muscle lisse.
- B. Les artères musculaires comportent à la fois une limitante élastique interne et une limitante élastique externe.
- C. Les artères musculaires ne comportent pas de tissus élastique.
- D. Le tonus des cellules musculaires lisse est régulé par des facteurs sécrétés par l'endothélium et par une innervation venant du système nerveux végétatif.
- E. Les vasa vasorum irriguent les parois des grosses artères. A

5. Le bourgeon trachéo-bronchique (diverticule respiratoire) est d'origine :

- A. Entoblastique.
- B. Ectoblastique.
- C. Mésoblastique.
- D. Epiblastique.
- E. Hypoblastique

A

Immuno (octobre 2024)

1. Les molécules HLA de classe II : (Cocher la proposition juste)

- 1- Sont polymorphes, formées par deux chaînes $\beta 1$ et $\beta 2$.
- 2- Le polymorphisme est porté par le domaine $\alpha 1$ et $\beta 1$ pour les molécules DR, DQ et DP
- 3- Les gènes de la chaîne α et β sont localisés au niveau du chromosome 6
- 4- Présentent le peptide immunogène exogène aux lymphocytes T CD4
- 5- Sont exprimées par les lymphocytes B

A : 1+3

B : 2+3+5

C : 2+4+5

D : 1+2

E : 3+4+5

E

2. L'activation du complément a pour effet(s) biologique (s) possible(s) : (Cocher la proposition juste)

- 1- L'opsonisation des bactéries
- 2- La solubilisation des complexes immuns
- 3- L'induction d'une réaction inflammatoire par libération des anaphylatoxines
- 4- La présentation de l'antigène aux lymphocytes T par le C3b fixé sur la membrane cellulaire
- 5- La lyse des micro-organismes par le phénomène d'ADCC

A : 2+3+4+5

B : 1+2+5

C : 1+2+3

D : 2+3+4

E : 1+2+5

C

α Immuno α

Immuno (2023)

12- Concernant les sélectines : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Durant l'inflammation les E sélectines jouent un rôle important dans le recrutement des leucocytes au niveau du site inflammatoire
- 2) Les P-sélectines sont exprimées à la surface des cellules endothéliales après induction par des allo-anticorps
- 3) Les L-sélectines sont exprimées d'une manière constitutive à la surface des leucocytes
- 4) Les sélectines sont des hétérodimères intra-cytoplasmique composés de 2 chaînes α et β liées de façon covalente
- 5) Les sélectines non aucun rôle dans le homing lymphocytaire

A: 2+4+5 B: 2+5 C: 3+4+5 D: 2+3+4 E:

1+4+5

A

13- Concernant les cytokines pro-inflammatoires : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Ont une action pléiotropique agissant sur plusieurs cibles cellulaires
- 2) Induisent la synthèse des protéines de l'inflammation
- 3) Les principales cytokines pro-inflammatoires sont : IL2, IL6, INF- γ et IL10
- 4) Entraînent une augmentation de la perméabilité vasculaire et une augmentation de l'expression des molécules d'adhésions par les cellules endothéliales
- 5) Inhibent la migration des macrophages et des Polynucléaires neutrophiles ce qui favorise l'élimination de l'agent agresseur

A: 3+4+5 B: 3+5 C: 2+4+5 D: 1+3 E: 1+3+5

B

14-Les cytokines : (Cochez réponse fausse)

- 1) Sont des glycoprotéines de faible poids moléculaire
- 2) Interagissent avec des récepteurs spécifiques au niveau du noyau des cellules immunitaires
- 3) Peuvent être régulées par des antagonistes compétitifs
- 4) Sont synthétisées par les cellules Immunitaires même au repos
- 5) Peuvent agir en synergie pour réaliser Une activité biologique donnée (effet de redondance)

A: 3+4 B: 2+3+5 C: 2+4 D:1+2+5 E: 1+2+4

B

15- la thymus est un organe lymphoïde : (Cochez la réponse fausse)

- 1) primaire
- 2) centrale
- 3) nécessaire a la maturation des lymphocytes B folliculaires et les lymphocytes NK
- 4) libère dans le sang circulant des lymphocytes T mature naïfs double positif exprimant les molécules CD4 et CD8
- 5) constituant un passage oblige des cellules LT aux différents stades de maturation

A: 4 B: 3+4+5 C: 2+4 D:3+4 E: 1+3+4+5

B

16- l'idiotype est : (Cochez la réponse Juste) (2023)

- 1) définie par un ensemble d'épitopes portés par la partie Fc d'une molécule d'Ig
- 2) identique chez tous les individus d'une même espèce
- 3) Le résultat d'une combinaison donnée de gènes codant pour les parties variables des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines
- 4) partagée Par les immunoglobulines d'une même classe chez un individu.
- 5) partagée Par les molécules de la superfamille des immunoglobulines

A: 1+4 B: 2+3+4 C: 2+3+4+5 D:3 E:1+3

D

17-Les régions constantes des chaînes H portent des structures conservées qui assurent diverses fonctions : (Cochez la réponse juste) (2023)

- 1) L'adhérence aux antigènes HLA.
- 2) Le transfert placentaire
- 3) La fixation et l'activation du complément par voie classique.
- 4) Le phénomène d'ADCC pour les cellules NK.

5) La fixation spécifique aux épitopes

A: 1+2+3 B: 2+3+5 C: 2+3+4+5 D: 1+2+3+4 E:

2+3+4

E

18-Le paratope : (Cochez la réponse fausse) (2023)

- 1) Est le site de reconnaissance de l'antigène
- 2) Est constitué des domaines variables des chaînes lourdes des immunoglobulines
- 3) Est le site de liaison spécifique au C1q du complément
- 4) Exprime des déterminants idiotypiques
- 5) N'est pas impliqué dans le passage transplacentaire des immunoglobulines

A : 2+3 B: 2+3+4 c:2+5 D: 3+4 E:

1+3+4+5

A

α Physiologie α

Physiologie (octobre 2024)

1. À propos de la régulation de la pression artérielle : (Cocher la réponse juste)

- A. Le facteur atrial natriurétique (FAN) est un puissant vasoconstricteur
- B. Les volorécepteurs sont des mécanorécepteurs qui répondent aux variations brutales de la PA
- C. Le réflexe ischémique central est mis en jeu lorsque la PAM < 50mmHg
- D. Le système rénine angiotensine baisse la PA par vasodilatation et augmentation de la natriurèse
- E. La régulation de la volémie est le premier mécanisme mis en jeu pour la régulation de la PA

C

2. La loi de Starling stipule que : (Cocher la réponse juste)

- A. La dépense énergétique du myocarde est proportionnelle à la tension de la paroi
- B. La force de contraction des ventricules dépend de la longueur initiale des fibres musculaires
- C. Le débit cardiaque est inversement proportionnel au volume d'éjection systolique
- D. $\Delta W = 8 J / \Delta p = 8 J / \pi r^4$
- E. La contraction de la fibre myocardique est maximale quelle que soit la stimulation

B

3. Les androgènes surrénaliens : (Cocher la réponse fausse) :

- A. Sont des pro-hormones inactives .
- B. Se transforment en hormones actives au niveau des organes cibles
- C. Leur rôle biologique est négligeable chez l'homme adulte
- D. Leur sécrétion est augmentée par l'ACTH hypophysaire
- E. Exercent un rétrocontrôle sur l'ACTH hypophysaire

E

Physiologie (2023)

1- Relation Pression/volume Pulmonaire ; (Cochez la réponse juste)

- A) Le volume d'une Structure élastique ne dépend pas de la pression transmurale
- B) Le volume de relaxation du Poumon est nul
- C) La compliance est la capacité du poumon à faire varier son volume, en fonction de la variation de la pression transmurale pulmonaire
- D) La Compliance a une Valeur constante qui n'évolue pas avec la pression
- E) Une compliance nulle = distensibilité infinie

C

2- Une P_{50} diminuée : (Cochez la réponse juste)

- A) Accompagne une hyperthermie
- B) Est associée à l'excès de 2,3 di phosphoglycérate
- C) Est observée en cas d'alcalose
- D) Traduit une affinité hémoglobine- O_2 abaissée
- E) Survient quand la PCO_2 est augmentée

C

3- Les réserves de CO_2 sont de l'ordre de 120 l au niveau : (Cochez la réponse juste)

- A) Du poumon
- B) Des tissus
- C) Du sang
- D) Des os
- E) De la myoglobine

D

4- Le débit ventilatoire est, chez l'adulte, au repos de : {Cochez la réponse juste)

- A) 0,25 litre/min
- B) 0,5 litre/min
- C) 8 litre/min
- D) 16 litre/min
- E) 26 litre/min

C

5- La durée d'un cycle respiratoire chez le nouveau-né, au repos, est de : (Cochez la réponse juste)

- A) 1 minute
- B) 20 secondes
- C) 10 secondes
- D) 4-5 secondes
- E) 1-1,5 seconde

E

6- La quantité de sodium excrété par le rein, par rapport à la quantité filtrée dans les conditions normales ; de l'ordre de (RJ)

- A) 6.5%
- B) 26%
- C) 6 à 8%
- D) 2%
- E) 0.1 à 1%

E

7- au sommet du poumon : (Cochez la réponse juste)

- A) Les alvéoles sont distendues
- B) La pression pleurale est moins négative qu'au niveau des bases
- C) la perfusion est meilleure qu'au niveau des bases
- D) la ventilation est moins bonne que la perfusion
- E) La ventilation est meilleure qu'au niveau des bases

A

8- la créatinine : (Cochez la réponse fausse)

- A) Est un déchet métabolique
- B) sa production et sa concentration plasmatique sont stables d'un jour à l'autre
- C) dépend de la masse musculaire
- D) Est librement filtrée
- E) Est légèrement réabsorbée

E

9. En cas d'augmentation de la pression artérielle, tous les mécanismes suivants sont observés, sauf un, lequel ? (Cochez la réponse fausse)

- A) L'étirement de la paroi des artéioles afférentes
- B) La sortie de calcium
- C) Une constriction du muscle lisse vasculaire
- D) Une baisse du débit sanguin rénal
- E) Une baisse du débit de filtration glomérulaire

B

10- Le facteur natriurétique auriculaire : (Cochez la réponse juste)

- A) Diminue la pression de filtration glomérulaire
- B) Stimule la sécrétion de rénine
- C) S'oppose aux effets vasoconstricteurs de l'angiotensine II
- D) Augmente le débit sanguin rénal
- E) Exerce un effet de vasoconstriction de l'artériole afférente

C

11- Une des catégories de produits suivants subit une réabsorption au niveau du tube contourné proximal : (Cochez la réponse Juste)

- A) Les oxalates
- B) Les salicylates
- C) Les bicarbonates
- D) L'adrénaline
- E) L'ion H'

C

Physiologie (2022)

1. Le sphincter oesophagien inférieur se relâche sous l'effet des facteurs suivants, sauf un: (RJ)

- A. Les graisses
- B. L'acétylcholine
- C. Les prostaglandines
- D. La nicotine
- E. Le VIP (Vasoactif Intestinal peptide)

B

2. La somatostatine inhibe la sécrétion gastrique acide en agissant sur : (RJ)

- A. Un récepteur H₂ de la cellule bordante
- B. Un récepteur CCKb de la cellule bordante
- C. La cellule ECL ou H à histamine
- D. La cellule de L'antre gastrique
- E. La cellule à sécrétine

C

Physiologie (2021)

1. Le système antéro - latéral ou système extraleminiscal véhicule l'information relative : (RJ)

- A) Au tact protopathique
- B) Au tact épicritique
- C) A la sensibilité proprioceptive
- D) A la sensibilité de la face
- E) A la sensibilité inconsciente

A

2. Au cours du sommeil paradoxal , il est retrouvé tous ces signes sauf un , lequel ? (RJ)

- A) Des mouvements oculaires rapides
- B) Une augmentation de la fréquence respiratoire
- C) Une augmentation de la fréquence cardiaque
- D) Des ondes lentes à l'EEG
- E) Un relâchement musculaire

A

Physiologie (2019)

1. Un rythme cardiaque est dit jonctionnel quand le pacemaker est :(Cochez la réponse exacte)

- A. Le nœud sinusal
- B. Le nœud auriculo-ventriculaire
- C. Le ventricule gauche
- D. Le faisceau de His
- E. Une des branches de Purkinje

B

2. Au cours de la phase d'éjection ventriculaire active : (Cocher la réponse exacte)
- A. Le deuxième bruit du cœur est audible
 - B. La valve mitrale est encore ouverte
 - C. Le Volume ventriculaire est constant
 - D. La pression ventriculaire est augmentée
 - E. La contraction ventriculaire est de type isométrique D
3. Les spasmes à l'origine de migraines vasculaires sont dues à : (Cocher la réponse exacte)
- A. L'histamine
 - B. La bradykinine
 - C. La sérotonine
 - D. Aux prostacyclines
 - E. Aux prostaglandines E C
4. Le vieillissement induit, au niveau du réseau vasculaire : (Cocher la réponse exacte)
- A. Une baisse de la post-charge
 - B. La quiescence du système endothélial
 - C. La stimulation de la biosynthèse de l'oxyde nitrique
 - D. La baisse des B-récepteurs
 - E. L'augmentation du rapport élastine/collagène B
5. Le peptide natriurétique auriculaire (PNA) : (Cocher la réponse fausse)
- A. Est un puissant inhibiteur de la contraction du muscle lisse vasculaire
 - B. Réduit le volume sanguin
 - C. Inhibe la sécrétion de rénine
 - D. Est libéré par une baisse de la pression auriculaire
 - E. Diminue la résistance périphérique totale (RPT) D
6. Parmi les propositions suivantes : (Cocher la réponse exacte)
- A. L'eau représente 60 % du poids corporel chez l'adulte obèse
 - B. On observe les modifications de l'hydratation par la diurèse
 - C. L'eau est répartie de manière homogène au niveau des secteurs liquidiens
 - D. Le secteur interstitiel représente les 2/3 de l'eau extracellulaire
 - E. Le volume intracellulaire représente le 1/3 de l'eau de l'organisme B

Physiologie (2018)

1. La lésion des hémisphères cérébelleux se caractérisent par une : (RJ)
- A. Une ataxie.
 - B. Un nystagmus.
 - C. Une adiadococinésie.
 - D. Des myoclonies du voile.
 - E. Une dysmétrie. C
2. Au cours du sommeil paradoxal, il est retrouvé : (RJ)
- A. Des mouvements oculaires lents.
 - B. Un relâchement des muscles squelettiques.
 - C. Une baisse du rythme cardiaque.
 - D. Des ondes alpha sur le tracé EEG.
 - E. Une respiration lente. B

3. Dans le syndrome de Brown-Sequard, il est retrouvé, sous la lésion : (RJ)
- A. Paralyse contralatérale.
 - B. Syndrome cordonal antérieur homolatéral.
 - C. Perte de la sensibilité épicritique homolatérale.
 - D. Perte de la sensibilité thermo-algique homolatérale.
 - E. Syndrome spino-thalamique homolatérale. C
4. La lésion du faisceau arqué est à l'origine de : (RJ)
- A. Aphasie motrice.
 - B. Aphasie sensorielle,
 - C. Aphasie de conduction,
 - D. Une altération de compréhension du langage.
 - E. Langage peu fluent. C
5. Une altération de la mémoire déclarative peut être due à des lésions, de toutes ces structures : (RF)
- A. L'hippocampe.
 - B. Des noyaux gris centraux,
 - C. Aires frontales.
 - D. Corps mamillaires.
 - E. Lobe temporal médian. B
6. Les réflexes et voies descendantes auditives : (RI)
- A. Protègent l'oreille interne.
 - B. Ciblent les cellules ciliées externes.
 - C. Stimulent le muscle stapédien.
 - D. Stimulent le muscle tenseur du tympan.
 - E. Toutes ces propositions sont justes. E
7. Une des situations suivantes est associée à une baisse de la P_{so} : (RJ)
- A. Acidose.
 - B. Hypercapnie.
 - C. Augmentation du taux de 2,3 DPG,
 - D. Hyperthermie.
 - E. Augmentation de l'affinité hémoglobine-O₂. E
8. La valeur du rapport ventilation/perfusion comprise entre 0 et 1 témoigne de : (RJ)
- A. Situation normale au alvéolaire.
 - B. Effet espace mort alvéolaire.
 - C. Shunt alvéolaire
 - D. Effet shunt alvéolaire.
 - E. Espace mort alvéolaire. D
7. Une des enzymes ou coenzyme suivantes est retrouvée dans le lait maternel : (RJ)
- A. Lipase.
 - B. Co-lipase.
 - C. Cholestérol esterase.
 - D. Phospholipase A₁.
 - E. Phospholipase A₂. C

8. Un des facteurs suivants diminue le débit de **filtration** glomérulaire : (RJ)

- A. Le monoxyde atrial d'azote.
- B. Le facteur atrial natriurétique.
- C. La caféine.
- D. Les méthylxanthines.
- E. Endothéline.

E

9. Le site d'**action** des thiazides, au niveau du néphron est : (RJ)

- A. Le tube contourné proximal.
- B. La branche ascendante de l'anse de Henlé.
- C. Le tube distal.
- D. Le tube collecteur cortical.
- E. Le tube collecteur médullaire.

C

10. L'hyperkaliémie peut être due à : (RF)

- A. Acidose métabolique.
- B. Acidose respiratoire.
- C. Insuffisance rénale.
- D. Insuffisance surrénale.
- E. Paralysie musculaire.

E

11. Les mécanismes physiopathologiques responsables de l'**insuffisance** rénale aiguë d'origine tubulaire sont : (RF)

- A. Lésions de la cellule tubulaire rénale.
- B. Obstruction des tubules rénaux.
- C. Activation du système rénine-angiotensine.
- D. Compressions edémateuse des néphrons.
- E. Augmentation de la synthèse des prostaglandines vasodilatatrices rénales.

E

12. Les signes ECG d'une hypokaliémie sont : (RF)

- A. Affaissement de l'onde T.
- B. Onde T haute, pointue et symétrique.
- C. Augmentation d'amplitude de l'onde U.
- D. Allongement de l'espace QU.
- E. Elargissement des complexes QRS.

B

13. L'hypocalcémie peut être due à : (RF)

- A. Hypoalbuminémie.
- B. Déficit en vit D.
- C. Déficit en calcitonine.
- D. Une pancréatite.
- E. Une hyperparathyroïdie.

E

14. Au cours de la phase **initiale** du choc hypovolémique, les résistances vasculaires systémiques sont : (RJ)

- A. Diminuées alors que le débit cardiaque est augmenté.
- B. Augmentées alors que le débit cardiaque est diminué.
- C. Augmentées avec un débit cardiaque diminué.
- D. Diminuées avec débit cardiaque diminué.
- E. Normales alors que le débit cardiaque est diminué.

B

15. Le principal mécanisme compensateur au cours du choc hypovolémique est : (RJ)

- A. La baisse du débit cardiaque.
- B. L'hyperréactivité adrénargique.
- C. La libération de prostaglandines.
- D. La libération des kinines.
- E. L'activation du facteur déresseur myocardique. B

16. Un choc hypovolémique peut être dû à : (RF)

- A. Un syndrome néphrotique.
- B. Un hémithorax.
- C. Une augmentation de la précharge du ventricule gauche.
- D. Une levée d'obstacle.
- E. Une fracture du bassin. C

17. Les facteurs thrombogènes sont :

- A. Plaque d'athérosclérose.
- B. Insuffisance cardiaque.
- C. Déficit héréditaire en facteurs de la coagulation.
- D. Syndrome des antis phospholipides.
- E. Les réponses A et B sont justes. C

18. L'embolie pulmonaire massive entraîne : (RF)

- A. Augmentation brutale de post charge du VD.
- B. Augmentation du volume diastolique du VD.
- C. Augmentation de la fraction d'éjection du VD.
- D. Diminution de la précharge du VG.
- E. Diminution du débit cardiaque. C

19. La première arme de compensation lors d'un bas débit cardiaque : (RJ)

- A. Stimulation des volorécepteurs.
- B. Stimulation des barorécepteurs.
- C. Stimulation du système rénine angiotensine aldostérone.
- D. Stimulation de la sécrétion de l'endothéline. B
- E. Toutes les réponses justes.

Physiologie (2017)

1/ Une des voies nerveuses suivantes véhicule les sensations proprioceptives et tactiles de l'hémicorps opposé : (1RJ)

- a- La voie pyramidale croisée
- b- La voie pyramidale directe
- c- La voie extra lemniscale
- d- La voie lemniscale
- e- La voie extrapyramidale D

2/ Un tremblement intentionnel associé à une adiadicocinésie est caractéristique d'une lésion de: (1RJ)

- a- Substance noire
- b- Striatum
- c- Pallidum
- d- Cortex pré-moteur
- e- Hémisphères cérébelleux E

3/ L'affinité hémoglobine-oxygène est favorisée par un des facteurs suivants: (1RJ)

- a- L'altitude
- b- L'alcalose
- c- L'augmentation de la P_{CO_2}
- d- L'augmentation du 2,3 diphosphoglycérate
- e- L'hyperthermie

B

4/ Un nombre de Reynolds augmenté est associé à : (1RJ)

- a- Une anémie
- b- Une baisse de la viscosité sanguine
- c- Une baisse de l'hématocrite
- d- Un rétrécissement du vaisseau
- e- Tous ces propositions sont justes

E

5/ Un des agents suivants a un effet vasoconstricteur sur le muscle lisse: (1RJ)

- a- La bradykinine
- b- L'histamine
- c- L'oxyde nitrique
- d- La noradrénaline
- e- L'adénosine

D

6/ Un des événements métaboliques suivants a lieu en période post-prandiale: (1RJ)

- a- Glycogénolyse hépatique
- b- Glycolyse
- c- Augmentation du débit hépatique de glucose
- d- Augmentation de la sécrétion du glucagon
- e- lipolyse

B

7/ La parathormone présente une des actions suivantes: (1RJ)

- a- Stimule la minéralisation osseuse
- b- Inhibe la synthèse de vitamine D
- c- inhibe la réabsorption tubulaire de phosphates
- d- Inhibe la réabsorption tubulaire de calcium
- e- Inhibe la lipolyse

C

8/ Un des facteurs suivants est orexigène : (1RJ)

- a- Leptine
- b- Ghréline
- c- Sérotonine
- d- Cholecystokinine
- e- Insuline

B

9/ Le système à basse pression se caractérise par : (1RJ)

- a- Une résistance hémodynamique forte
- b- Une capacité importante
- c- Sa faible influence par la pesanteur
- d- Son extensibilité faible
- e- La pression qui y règne est d'origine dynamique

D

10/ Les influx sensoriels gustatifs sont acheminés vers les centres supérieurs par l'un des nerfs crâniens suivants : (1RJ)

- a- Le pathétique (IV)
- b- Le trijumeau (V)
- c- Le facial (VII)
- d- Le spinal (XI)
- e- l'hypoglosse (XII)

C

Physiologie (2016)

1. Une des structures nerveuses suivantes est responsable de la planification du mouvement: (1RJ)

- A-Le cortex moteur
- B-Le cortex prémoteur
- C-Les noyaux gris de la base
- D-Le cervelet
- E-Le thalamus

B

2. Quelle est la partie du corps dont les motoneurones corticaux ont la plus grande représentation sur le cortex moteur primaire (aire 4 de Brodmann) ?(1RJ)

- A-L'épaule
- B-Le coude
- C-Les doigts
- D-Le genou
- E-la jambe

C

3. Une des substances suivantes a un effet de désensibilisation des nocicepteurs (1RJ)

- A-La sérotonine
- B-La bradykinine
- C-La prostaglandine E2
- D-La substance P (SP)
- E-La galanine

E

4. Une cécité temporale (hémianopsie) des yeux droit et gauche résulte d'une section du: (1RJ)

- A-Nerf optique de l'œil droit
- B-Chiasma optique
- C-Bandelette optique
- D-corps genouillé latéral
- E-Radiations optiques

B

5. Au cours de la phase d'endormissement, l'EEG met en évidence: (1RJ)

- A-Des ondes en forme de fuseaux
- B-Des ondes Thêta
- C-La raréfaction des ondes Alpha
- D-Des ondes Delta
- E-De larges pointes ondes

D

Physiologie (2015)

1. Parmi les propositions suivantes: (cochez la réponse EXACTE)
 - A- L'eau représente 60 % du poids corporel chez l'adulte obèse
 - B- On évalue les modifications de l'hydratation par la diurèse
 - C- L'eau est répartie de manière homogène au niveau des secteurs liquidiens
 - D- Le secteur interstitiel représente les 2/3 de l'eau extracellulaire
 - E- Le volume intracellulaire représente le 1/3 de l'eau de l'organisme B
2. La force osmotique des liquides extracellulaires : (Cocher la réponse EXACTE)
 - A- Est exprimée en mosm/l de plasma
 - B- Est équivalente à 290 mosm/l de plasma
 - C- Sa formule est $T = \text{natrémie} + \text{azotémie} + \text{glycémie (mmol/l)}$
 - D- Est équivalente à 290 mosm/kg d'eau
 - E- Dépend de la teneur en potassium des liquides extracellulaires D

Anapath et cytologie pathologique

Anapath (octobre 2024)

1. Le stroma tumoral : (Cocher la réponse fausse)

- A. Est un tissu conjonctivo –vasculaire anormal
- B. Joue un rôle de soutien et de nutrition
- C. Est plus développé dans les tumeurs malignes épithéliales
- D. Peut avoir un rôle diagnostique
- E. Peut-être une cible thérapeutique

A

2. Parmi les colorations spéciales suivantes, laquelle est étudiée en lumière polarisée : (Cocher la réponse juste)

- A. Trichrome de Masson
- B. Rouge Sirius
- C. Acide Périodique de Schiff
- D. Rouge Congo
- E. Bleu Alcian

D

3. L'examen clinique d'un enfant de 05 ans retrouve une masse rétro-péritonéale. L'étude microscopique de la masse réséquée retrouve 03 composantes cellulaires : blastémateuse, stromale et épithéliale. Sa sœur présentait le même type de tumeur. Cochez parmi les propositions suivantes la mutation impliquée :

- A. Mutation du gène Rétinoblastome (RB)
- B. Mutation du gène Von Hippel Lindau (VHL)
- C. Mutation du gène Wilms Tumor (WT)
- D. Mutation du gène de la polyposé adénomateuse (APC)
- E. Mutation du gène BRCA1 et BRCA2

C

4. L'étude microscopique d'un revêtement cutané retrouve une collection de macrophages contenant dans leur cytoplasme un pigment coloré en bleu par la coloration de Perl. L'étiologie la plus probable de ce pigment est : (Cocher la réponse juste)

- A. Une accumulation anormale de protéines
- B. Un pigment lipofuscinique
- C. Un traumatisme antérieur responsable d'hémorragies
- D. Des résidus de tatouage
- E. Accumulation normale de mélanine

C

Anapath (2023)

19- Les œdèmes lésionnels : (Cocher la RF)

- A) Sont riches en protéines plasmatiques
- B) Sont dus à une augmentation de la perméabilité endothéliale
- C) Sont la conséquence d'une augmentation de la pression hydrostatique
- D) Surviennent dans la phase algue de l'Inflammation
- E) S'accompagnent d'une congestion active

C

20- Tous ces facteurs favorisent la survenue d'une thrombose sauf un lequel ?

- A) L'exercice physique excessif
- B) La compression vasculaire
- C) Les artérites
- D) Les coagulopathies
- E) L'athérosclérose

A

- 21- Les infarctus rouges : (Cochez la réponse fausse)
 A) S'observent dans le rein
 B) Sont dus à une oblitération artérielle
 C) Sont infiltrés de sang
 D) Ne peuvent être distingués macroscopiquement et microscopique d'un infarctissement
 E) S'observent dans le poumon A
- 22- Les cellules épithéloïdes : (Cochez la réponse fausse)
 A) Ressemblent aux cellules épithéliales
 B) Sont des cellules d'origine histiocytaire
 C) Sont des cellules très activées
 D) Ont une activité sécrétoire importante
 E) Ont une activité phagocytaire élevée E
- 23- Concernant le granulome a corps étrangers : (Cochez la réponse fausse)
 A) Il est extrêmement fréquent
 B) il n'a pas de disposition particulière en follicule
 C) le corps étranger peut être endogène ou exogène
 D) il est plus riche en cellule épithéloïdes qu'en cellules géantes
 E) il peut donner naissances a des pseudotumeurs D
- 24- concernant les lésions cellulaires élémentaires : (Cochez là réponse fausse)
 A) peut trouve une atrophie physiologique cellulaire dans la maladie d'Alzheimer
 B) les RGO peuvent être source de métaplasie cellulaire
 C) l'hypertrophie musculaire est physiologique chez les grands sportif
 D) un excès hormonal peut provoquer une hyperplasie cellulaire
 E) un excès hormonal peut être responsable de lésions de dystrophie A
- 25- parmi les affirmations suivantes concernant l'étude Immun histochimique : (Cochez là réponse fausse)
 A) est basée sur une réaction antigène-anticorps
 B) elle permet l'identification et la localisation de protéines
 C) peut permettre d'identifier une cible thérapeutique
 D) elle peut mettre EN évidence des séquences connues d'ADN ou d'ARN
 E) peut mettre en évidence un virus D
- 26- concernant ces complications, laquelle n'est pas due à l'athérosclérose ?
 A) perte d'élasticité de la paroi artérielle
 B) embolie pulmonaire
 C) la formation d'anévrismes
 D) sténose de la lumière artérielle
 E) obstruction thrombotique de l'artère B

Anapath (2022)

1. L'activité d'une gastrite chronique à *Helicobacter Pylori* est mise en évidence par la présence de: (RJ)

- A. Glandes atrophiques
- B. Lymphocytes
- C. Polynucléaires neutrophiles
- D. Métaplasie intestinale
- E. Mastocytes C

2. Parmi ces colorations, laquelle met en évidence la mucine? (RJ)

- A. Le trichrome de Masson
- B. Le bleu alcian
- C. Le rouge Congo
- D. Les Sels d'argent
- E. Le Perls B

3. Les phénomènes d'adaptation cellulaire sont : (RF)
- A. L'atrophie
 - B. L'hypertrophie
 - C. Les mitoses
 - D. L'hyperplasie
 - E. La métaplasie C
4. La déterision : (RJ)
- A. Est la résorption des tissus nécrosés au cours de l'inflammation
 - B. S'effectue uniquement par mécanisme physiologique
 - C. Permet une bonne cicatrisation même si elle est incomplète
 - D. Se fait dans la circulation sanguine
 - E. Est obligatoirement chirurgicale A
5. Un abcès le distingue d'un phlegmon par : (RJ)
- A. La richesse en polynucléaires neutrophiles
 - B. La Présence de nombreux polynucléaires altérés
 - C. L'aspect bien circonscrit du pus
 - D. L'étendue des thromboses veineuses
 - E. L'intensité de l'œdème C
6. Un des éléments cellulaires suivants participe à la constitution du granulome tuberculoïde, lequel ? (RJ)
- A. Les polynucléaires neutrophiles de type Langhans
 - B. Les cellules géantes multinucléées
 - C. Les mégacaryocytes
 - D. Les mastocytes
 - E. Les lymphoblastes B
7. Toutes ces inflammations sont spécifiques sauf une : (RF)
- A. La tuberculose
 - B. La sarcoïdose
 - C. Le botriomycome
 - D. La lèpre
 - E. La maladie des griffes du chat C
8. Une fragmentation de chromatine correspond à : (RJ)
- A. Une mitose
 - B. Une cytolysse
 - C. Une pycnose
 - D. Une caryolyse
 - E. Une caryorrhexis E
9. L'amylose est : (RJ)
- A. Une accumulation tissulaire de graisse animale
 - B. Une Accumulation anormale de glycogène dans les cellules
 - C. Un dépôt tissulaire interstitiel de protéines anormales
 - D. Un dépôt de complexe immuns
 - E. Un dépôt tissulaire interstitiel de fibrine. C

10. Les mécanismes génétiques intervenant dans la carcinogenèse sont : (RF)

- A. L'expression de gènes appelés oncogènes
- B. La perte d'activité de gènes suppresseurs.
- C. Les anomalies des gènes de réparation de l'ADN
- D. Les télomérases
- E. La méthylation de l'ADN

E

Anapath (2021)

1) Tous ces anticorps permettent de définir l'origine cellulaire d'une tumeur sauf un , lequel ? (RJ)

- A) Pancytokératine
- B) Vimentine
- C) Chromogranine
- D) Her2
- E) Myogénine 18

D

2) Parmi ces anticorps , un seul est à visée double : diagnostique et thérapeutique , lequel ? (RJ)

- A) PS100
- B) Synaptophysine
- C) CD20
- D) Myogénine
- E) TTF1

C

3. Dans une inflammation aiguë virale , tous ces éléments peuvent s'observer sauf un , lequel ? (RJ)

- A) L'œdème
- B) La congestion vasculaire
- C) Les lymphocytes
- D) Les histiocytes
- E) Les polynucléaires

D

4. Le score de Gleason dans le cancer de la prostate est basé sur : (RJ)

- A) La désorganisation architecturale
- B) Le grade histologique le plus élevé
- C) Les atypies cytonucléaires
- D) L'index mitotique
- E) La disparition de l'assise basale

A

5. Le grade nucléolaire de Furhman :

- A) N'est appliqué que pour les carcinomes à cellules claires et carcinomes papillaires
- B) Ne prend pas en compte le type cellulaire
- C) Se base sur les atypies cytonucléaires
- D) A une valeur pronostique
- E) Est évalué sur les zones les plus atypiques

C

6. Le carcinome à cellules claires du rein :

- A) Est d'architecture papillaire
- B) La composante sarcomatoïde est de bon pronostic
- C) Se voit souvent chez l'enfant
- D) Est une tumeur mésoenchymateuse
- E) S'associe à une anomalie du gène VHL dans 60 % des cas

E

Anapath (2020)

1. L'apoptose : (RF)

- A) Est une mort cellulaire accidentelle
- B) Est une mort cellulaire physiologique
- C) Est une mort cellulaire programmée
- D) Touche un groupe de cellules
- E) Est génétiquement déterminée

A

2. La transformation d'un tissu en un autre tissu de morphologie et de fonction différentes correspond à : (RJ)

- A) Une dystrophie
- B) Une hétérotopie
- C) Une métamorphose
- D) Une dégénérescence
- E) Une métaplasie .

E

3. Les anti - oncogènes agissent : (RJ)

- A) En phase M
- B) En phase G1 / S
- C) En phase S
- D) En phase G0 <
- E) En phase G1 .

B

4. Parmi les colorations spéciales suivantes , quelle est celle qui doit être étudiée en lumière polarisée : (RJ)

- A) Trichrome de Masson
- B) Rouge Sirius
- C) Acide Périodique de Schiff
- D) Rouge Congo
- E) Bleu Alcian

D

5. L'étude microscopique d'un revêtement cutané retrouve une collection de macrophages contenant dans leur cytoplasme un pigment coloré en bleu par coloration de Paris. L'étiologie la plus probable de ce pigment est : (RJ)

- A) Une accumulation anormale de protéines
- B) Un pigment lipofuscinique
- C) Un traumatisme antérieur responsable d'hémorragies
- D) Des résidus de tatouage

C

Anapath (2019)

1. L'infarctus rouge se voit dans : (Cocher la réponse exacte)

- A. L'intestin
- B. Le rein
- C. Le cœur
- D. La rate
- E. Aucune de ces réponses

A

2. La **fixation** :(Cocher la réponse fausse)
- A. Permet de conserver la morphologie cellulaire
 - B. Doit être immédiate
 - C. Est indispensable pour un examen extemporané
 - D. Se fait au formol tamponné à 10%
 - E. Nécessite un volume suffisant de fixateur C
3. La biopsie exérèse consiste à: (Cocher la réponse exacte)
- A. Enlever une partie de la lésion
 - B. Faire une micro-biopsie à visée diagnostique
 - C. Faire une résection à visée thérapeutique
 - D. Faire une ponction-biopsie
 - E. Enlever la lésion dans sa totalité à visée diagnostique et thérapeutique E
4. La **fibrose** est dite **mutilante** si :(Cocher la réponse exacte)
- A. L'architecture de l'organe est reconnaissable
 - B. Elle respecte la charpente conjonctive normale
 - C. Elle épaissit la capsule de l'organe
 - D. Détruit l'architecture de l'organe
 - E. Elle est diffusée à tout l'organe D
5. Dans la **congestion** : (Cocher la réponse fausse)
- A. Le poumon cardiaque résulte d'une congestion active
 - B. L'organe est alourdi et rouge à la macroscopie A
 - C. Le ralentissement du drainage sanguin veineux est à l'origine d'une congestion passive
 - D. Le foie cardiaque est la conséquence d'une insuffisance cardiaque droite ou globale
 - E. Les vaisseaux sont dilatés, remplis d'hématies, avec des cellules endothéliales turgescentes
6. La **définition** de la chéloïde correspond à :(Cocher la réponse fausse)
- A. Une cicatrisation excessive
 - B. Une hyperplasie conjonctive
 - C. Une multiplication du nombre de vaisseaux
 - D. Une masse blanchâtre ferme
 - E. Une atteinte surtout dermique C
7. L'œdème **inflammatoire** :(Cocher la réponse exacte)
- 1. Comporte très peu de protéines
 - 2. Permet la dilution des toxines microbiennes
 - 3. Peut favoriser une sclérose ultérieure
 - 4. Se développe à la phase chronique de l'inflammation
 - 5. Permet l'apport de médiateurs chimiques
 - A : 1-5 B : 3-4 C : 4-5 D : 1-2 E : 2-5 E
8. La **détersion** : (Cocher la réponse fausse)
- A. Est l'élimination des éléments étrangers présents dans le foyer inflammatoire
 - B. Peut se faire par phagocytose
 - C. Peut se faire par fistulisation
 - D. Peut se faire par un parage chirurgical
 - E. N'est jamais spontanée E

9. Le grade histopronostic des tumeurs mésoenchymateuses malignes repose sur : (Cocher la réponse juste)

1. Le degré de différenciation tumorale
2. L'activité mitotique
3. La nécrose tumorale
4. La localisation de la tumeur
5. La taille de la tumeur

A : 1-2-5 B: 3-4-5 C : 1-2-3 D : 2-3-4 E : 2-4-5 C

10. Le stroma des cancers a tous les caractères suivants, sauf un lequel ? (Cocher la réponse fautive)

- A. Il est de nature conjonctive
- B. Il est dépourvu de vascularisation
- C. Il appartient à l'organe atteint par la tumeur
- D. Il assure la nutrition du cancer
- E. Il peut être granulomateux

B

11. Parmi les éléments suivants indiquer celui qui définit le carcinome in situ ou intraépithéliale (cocher la réponse exacte)

- A. Épaississement de l'épithélium
- B. Présence d'une hypervascularisation
- C. Réaction inflammatoire péri lésionnelles
- D. Absence de franchissement de la base épithéliales
- E. Érosion en surface

D

12. La métastases (Cocher la réponse fautive)

- A. Peut se révéler cliniquement avant la tumeur primitive
- B. Peut apparaître après l'exérèse de la tumeur
- C. Se développe à distance de la tumeur primitive
- D. Peut avoir plusieurs aspects morphologique identique à la tumeur primitive
- E. Connait par sa malignité

Anapath (2018)

1. La fixation : (RJ)

- A. Est une étape indispensable pour une étude histologique.
- B. Permet de conserver la morphologie tissulaire.
- C. Evite l'autolyse des tissus.
- D. Doit être immédiate.
- E. Est recommandée par l'utilisation de l'alcool tamponné.

E

2. L'examen extemporané : (RJ)

- A. Permet un diagnostic rapide.
- B. Permet un diagnostic faible.
- C. Se fait en per-opératoire.
- D. Se fait à la demande du chirurgien.
- E. Permet d'orienter le geste thérapeutique.

B

3. La stéatose hépatique : (RF).
- A. Est une surcharge des hépatocytes en cholestérol.
 - B. Peut être d'origine alcoolique.
 - C. Peut s'observer dans l'hépatite C.
 - D. S'accompagne d'une hépatomégalie.
 - E. Comporte à l'histologie des vacuoles cytoplasmiques optiquement vides.

A

4. L'hémochromatose : (RF)
- A. Est une maladie autosomique récessive.
 - B. Se caractérise par une accumulation parenchymateuse en fer.
 - C. Peut toucher le pancréas.
 - D. Peut se compliquer d'une sclérose mutilante.
 - E. Est mise en évidence par le PAS.

E

5. L'infarctus hémorragique : (RF)
- A. Peut-être causé par une obstruction artérielle.
 - B. Peut-être causé par une torsion d'un pédicule vasculaire.
 - C. Se rencontre souvent au niveau de l'intestin grêle.
 - D. Peut se voir au niveau du cerveau.
 - E. Est difficile à distinguer d'un infarctus rouge.

A

6. Toutes ces inflammations sont granulomateuses sauf:(RF)
- A. La tuberculose.
 - B. La sarcoïdose.
 - C. La maladie de Crohn.
 - D. L'amibiase rectale.
 - E. La lèpre.

D

7. Ces anomalies nucléaires caractérisent la cellule cancéreuse : (RF)
- A. Noyaux pycnotiques.
 - B. Mitoses tripolaires.
 - C. Noyaux multiples.
 - D. Nucléoles proéminents.
 - E. Membrane nucléaire épiasse.

A

8. L'invasion tumorale est liée : (RF)
- A. A la destruction de la matrice extracellulaire péri-tumorale.
 - B. A la perte des connexions intercellulaires.
 - C. Au développement d'une angiogenèse.
 - D. Au développement d'un tumoral.
 - E. A l'acquisition des E cadhérines par les cellules tumorales.

D

9. Les métastases osseuses : (RF)
- A. Peuvent être révélatrices d'un cancer.
 - B. Sont fréquemment d'origine mammaire.
 - C. Peuvent être lytiques ou condensantes.
 - D. Ne sont jamais uniques.

A

10. Dans la classification p TNM, le stade p TO correspond à : (RJ)

- A. Une tumeur bénigne.
- B. Un carcinome in situ.
- C. Un carcinome limité à la muqueuse.
- D. Une tumeur ayant disparu après traitement néo-adjuvant.
- E. La tumeur primitive non retrouvée à l'étude histologique. E

11. L'athérosclérose est une pathologie artérielle qui touche les artères : (RJ)

- A. Petit calibre.
- B. Moyen calibre.
- C. Gros calibre.
- D. A+B.
- E. B+C. E

12. Les tératomes (RJ) :

- A. Sont des tumeurs du cordon sexuel.
- B. Sont plus fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant.
- C. Sont immatures dans 95% des cas.
- D. Se présentent le plus souvent sous forme de masse solide.
- E. Sont composés de tissus dérivant des différents feuilletts embryologiques.

E

13. Le granulome épithélioïde

- A. Peut-être diffus ou nodulaire.
- B. Se compose d'un agglomérat de cellules histiocytaires souvent bien limité.
- C. La forme diffuse est la forme la plus caractéristique.
- D. Selon son étiologie, il peut être tuberculoïde ou à corps étrangers.
- E. Peut comporter des cellules épithélioïdes et des cellules géantes multinuclées.

C

Anapath (2017)

1/ Le score de Gleason dans le cancer de la prostate : (1RF)

- a- Dépend des sécrétions éosinophiles intra glandulaires
- b- Le groupe 1 (score 6) est de bon pronostic
- c- Obtenu en additionnant les 2 grades histologiques allant de 1 à 5
- d- Le score 4 (2+2) est le score le plus faible
- e- Est un score histopronostique

A: b+c+e , B: b+c , C: b+e, D: c+e, E: a+d E

2/ Le carcinome à cellules claires du rein: (1RJ)

- a- Est d'architecture papillaire
- b- La composante sarcomatoïde est de bon pronostic
- c- Se voit essentiellement chez l'enfant
- d- Est une tumeur mésenchymateuse
- e- S'associe à une anomalie du gène VHL dans 60% des cas

D

3/ Le carcinome urothélial de la vessie: (1RF)

- a- Est le plus fréquent des cancers de vessie
- b- Le tabac est fortement incriminé
- c- L'infiltration du muscle est présente dans le carcinome de bas grade
- d- Peut comporter une différenciation glandulaire
- e- Son pronostic dépend du type et du stade C

4/ Le neuroblastome: (1RF)

- a- Est une tumeur de la corticosurrénale
- b- Est une tumeur maligne
- c- Se développe à partir de la lignée sympathique
- d- Prédomine chez l'enfant
- e- Composé de neuroblastes immature avec disposition parfois en rosettes A

5/ Les tumeurs de l'hypophyse: (1RJ)

- a- Les adénomes représentent la majorité de ces tumeurs
- b- Les tumeurs de l'hypophyse sont des néoplasies d'origine supra chiasmatique
- c- Elles sont dominées par les adénomes hypophysaires développés à partir de la post hypophyse
- d- Les adénomes hypophysaires sont toujours multi sécrétant
- e- La morphologie de la cellule permet de reconnaître le type d'hormone sécrétée

A

6/ Un botryomycome est: (1RJ)

- a- Une tumeur bénigne
- b- Une tumeur embryonnaire
- c- Une tumeur à malignité locale
- d- Une lésion inflammatoire ou dystrophique
- e- Une lésion précancéreuse A

7/ Quelle est parmi ces propositions, celle qui correspond à l'infarctus ? : (1RJ)

- a- Foyer viscéral circonscrit de nécrose ischémique liée à un arrêt brutal de la circulation artérielle
- b- Foyer de nécrose tissulaire liée à une inflammation
- c- Foyer de nécrose associé à un infarctissement
- d- Nécrose tissulaire secondaire à l'obstruction d'une veine de drainage
- e- Foyer hémorragique dû à une rupture vasculaire A

8/ Dans l'adénocarcinome exocrine du pancréas: (1RF)

- a- Les remaniements nécrotico-hémorragiques sont très importants
- b- Le stroma est desmoplastique
- c- Les engainements périnerveux sont fréquents
- d- Le stroma est riche en polynucléaires neutrophiles et éosinophiles
- e- Une dilatation du Wirsung est fréquente E

9/ L'adénocarcinome de la vésicule biliaire: (1RJ)

- a- Est la tumeur maligne la plus fréquente de la vésicule biliaire
- b- Est en général associé à la présence de calculs
- c- Naît le plus souvent au niveau du fond
- d- Est de mauvais pronostic
- e- Toutes ces propositions sont justes

E

10/ La stéatose hépatique est : (1RJ)

- a- Une surcharge des hépatocytes en cholestérol
- b- Une surcharge des hépatocytes en glycogène
- c- Une surcharge des hépatocytes en triglycérides
- d- Toujours macrovacuolaire
- e- Une pathologie héréditaire

C

11/ Le sarcome d'Ewing: (1RF)

- a- Est une prolifération tumorale touchant les petits os
- b- Est une tumeur bien différenciée à petites cellules
- c- Les cellules sont PAS positives
- d- Renferme de larges plages de nécrose
- e- Son âge moyen d'apparition est de 20 ans

12/ Durant le sepsis toutes ces situations sont

B

Anapath (2016)

1. Les lésions suivantes peuvent être observées dans un infarctus du myocarde entre la 24ème et la 48ème heure, sauf une: (1RF)

- A- Nécrose cellulaire
- B- Ondulation des fibres myocardiques
- C- Fragmentation des fibres myocardiques
- D- Infiltrat à polynucléaires
- E- Cicatrice fibreuse

E

2. La plaque d'athérosclérose: (1RF)

- A- Est la première lésion d'athérosclérose à apparaître
- B- Se présente macroscopiquement comme une lésion lenticulaire jaunâtre de 0,5 à 3 cm de diamètre

- C- Reste stable sans aucune évolution
- D- A+C
- E- A+B+C

D

3. Un anévrisme artériel: (1RF)

- A- Est une dilatation focale et permanente d'une artère
- B- Son diamètre est supérieur à une fois et demie le diamètre de l'artère d'amont
- C- Peut être d'origine post traumatique
- D- Peut être associé à une athérosclérose
- E- peut se voir au cours de la maladie de Marfan

C

4. La maladie d'Alzheimer: (1RJ)

- A- Est une maladie dégénérative du système nerveux central
- B- Se caractérise macroscopiquement par une atrophie cérébrale
- C- Se caractérise microscopiquement par des plaques de démyélinisation
- D- A+B
- E- A+B+C

D

5. Les phases de l'inflammation sont: (1RF)

- A- La phase vasculo-exsudative
- B- La phase exsudative
- C- La phase cellulaire
- D- La détersion
- E- La réparation

D

6. Les lymphomes: (1RF)

- A- Sont issus d'une prolifération monoclonale d'origine lymphoïde B, T ou NK
- B- Leur diagnostic est fait uniquement sur la morphologie
- C- Nécessitent une étude immuno-histochimique et parfois biologique moléculaire
- D- Les lymphomes B sont les plus fréquents
- E- Pour le lymphome d'Hodgkin, la présence de cellules de Reed-Stenberg est un

élément clé de diagnostic

B

7. Dans les phénomènes cadavériques microscopiques: (1RF)

- A- La putréfaction est une autolyse où interviennent des microorganismes endogènes et exogènes
- B- Les zones de fibrose résistent à une putréfaction
- C- La transformation adipocireuse (Adipocire) survient en milieu humide et chaud
- D- L'adipocire permet de ralentir la putréfaction.
- E- La momification survient en milieu humide et chaud

E

8. Quel est parmi les fixateurs ci-dessous celui qui est le plus adapté pour les technique de routine et spéciales

en anatomo-pathologie: (1RJ)

- A- Liquide de Bouin
- B- Alcool absolu
- C- Formol tamponné à 10%
- D- Ethanol à 10%
- E- AFA (alcool, formol, acide acétique)

C

9. La coloration de l'Orceine permet de mettre en évidence: (1RJ)

- A- Les fibres de collagènes
- B- Les fibres de réticulines
- C- Les fibres élastiques
- D- La substance amyloïde
- E- La melanine

C

10. Quelle est parmi les colorations histochimiques suivantes celle qui oriente vers un saignement chronique: (1RJ)

- A- Le bleu Alcian
- B- L'Acide périodique de Schiff
- C- Le Fontanae
- D- Le Trichrome de Masson
- E- Le Peris

E

11. Le tableau anatomo-pathologique de l'asphyxie: (1RF)

- A- Se compose de lésions spécifiques
- B- Se compose de lésions congestives et hémorragiques localisées aux principaux viscères, mais surtout à l'appareil respiratoire
- C- Les poumons sont sombres, violacés, volumineux, très congestionnés
- D- Les cavités cardiaques droites sont gorgées de sang, les cavités gauches sont vides
- E- A+B sont justes

A

12. Le tératome: (1RF)

- A- Est une tumeur germinale
- B- Est une mixture tissulaire
- C- Est dit bénin quand il est composé de tissus immatures
- D- Peut-être de siège extra-gonadique
- E- Dans sa forme mono-dermique, il correspond au goitre ovarien

C

13. La mole hydatiforme se caractérise par: (1RF)

- A- Une hyperplasie du trophoblaste
- B- Un aspect macroscopique en « grappe de raisin »
- C- Des villosités chorales oedématisées hydropiques
- D- Des axes villositaires très vascularisés
- E- Un taux de B HCG élevé.

D

14. Le cancer du sein (1RF):

- A- Est dominé par le carcinome lobulaire chez la femme
- B- Est un cancer hormono-dépendant
- C- Est rare chez l'homme
- D- Impose au pathologiste l'étude des facteurs histo-pronostiques
- E- Peut se manifester par une opacité nodulaire bien limitée à la mammographie.

A

15. Parmi les éléments histologiques suivants, lequel est indispensable au diagnostic de maladie cœliaque: (1RJ)

- A- L'atrophie villositaire
- B- L'hyperplasie cryptique
- C- L'augmentation des lymphocytes intra épithéliaux
- D- La majoration de la population lympho-plasmocytaire
- E- L'œdème

C

1- L'apoptose: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Est une mort cellulaire accidentelle, due à une agression endogène.
- B- Est un phénomène physiologique génétiquement déterminé
- C- Permet l'élimination des cellules lésées
- D- Intervient dans le renouvellement des cellules à courte durée de vie
- E- Est une réponse de l'organisme à une agression A

2- L'amylose est: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Une accumulation tissulaire d'amidon
- B- Une accumulation anormale de glycogène dans les cellules
- C- Un dépôt tissulaire interstitiel de protéines anormales
- D- Un dépôt de complexes immuns
- E- Un dépôt tissulaire interstitiel de graisse anormale C

3- L'examen extemporané: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Est réalisé en per opératoire
- B- Permet de déterminer la nature de la lésion
- C- Est effectué sur un prélèvement fixé au formol à 10%
- D- Est pratiqué dans le but d'orienter l'acte chirurgical
- E- La coupe se fait après congélation du prélèvement C

4- Les fibres de collagènes : (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Sont élaborées par le macrophage
- B- Leur renouvellement est constant
- C- Sont dégradées par les collagénases
- D- Sont mises en évidence à l'histologie par la coloration du trichrome
- E- Sont responsables de la rigidité des tissus. A

5- Parmi ces associations laquelle correspond à la mort cellulaire :

- 1) Caryolyse.
- 2) Dégénérescence hydropique
- 3) Carrhyorexis
- 4) Altération des mitochondries
- 5) Pseudo-vacuoles intranucléaires B
- 6) Figures apoptotiques

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

- A- 1-2-3-5 B- 1-3-4-6 C- 2-3-5-6 D- 1-3-5-6 E- 2-4-5-6

6- Un carcinome cantonné à l'épithélium est: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Une dysplasie sévère
- B- Un cancer in situ
- C- Un cancer intra muqueux
- D- Un cancer micro-infiltrant
- E- Un cancer invasif B

7. Une tumeur maligne reproduisant l'épithélium malpighien est un: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Adénocarcinome
- B- Carcinome transitionnel
- C- Carcinome épidermoïde
- D- Carcinome basocellulaire
- E- Carcinosarcome.

C

8- La présence de granulome épithélio-gigantocellulaire doit faire évoquer: (Cocher réponse INEXACTE)

- A- Une maladie de CROHN
- B- La tuberculose
- C- La sarcoïdose
- D- La lèpre
- E- Une réaction à corps étranger

E

9- Tous les anticorps suivants sont exprimés au niveau cytoplasmique sauf un, lequel ?

- A- La cytokératine 7
- B- La cytokeratine 20
- C- La vimentine
- D- La desmine
- E- La myogénine.

E

10- Une tumeur cutanée pigmentée doit faire évoquer tous ces diagnostics sauf un, lequel?

- A- Un naevus
- B- Un angiome
- C- Un mélanome
- D- Un carcinome épidermoïde
- E- Un carcinome basocellulaire.

D

11- Une fois prélevé, le tissu :

- 1) doit être fixé immédiatement dans le formol
- 2) doit être mis dans le sérum
- 3) doit être monté entre lame et lamelle
- 4) subir une inclusion en paraffine
- 5) doit être fixé à l'aide d'un cytospray

Parmi les propositions suivantes cochez la proposition EXACTE

- A- 1+2+3 B- 1+4 C- 1+4+5 D- 1+3 E- 1+5

B

12- Une nécrose de coagulation: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Est une nécrose ischémique.
- B- Est un ramollissement des organes.
- C- Est une lyse tissulaire avec accumulation de pus.
- D- Est une nécrose de la graisse.
- E- Est une lésion réversible après traitement

B

13- Toutes ces lésions sont considérées comme réversibles sauf une. Laquelle ?

- A- Dégénérescence hydropique
- B- Dégénérescence graisseuse
- C- Dégénérescence vacuolaire
- D- Pycnose
- E- Steatose hépatique

D

14-La nécrose ischémique est la conséquence de : (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Oblitération veineuse.
- B- Dépôt fibrinoïde
- C- Inflammation artérielle.
- D- Altération de polynucléaires.
- E- Thrombus artériel.

E

15-La prolifération dans un site étranger nécessite : (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Des molécules d'adhérence
- B- Des facteurs de croissance sécrétés par le milieu cellulaire
- C- Angiogenèse
- D- Une augmentation de l'expression de molécules de classe I
- E- Une production spécifique de facteurs chimiotactiques par l'organe colonisé.

D

α Biochimie α
Biochimie (octobre 2024)

1. Parmi les propositions suivantes concernant les facteurs pouvant entraîner une hyperprotéinémie, indiquez laquelle est juste :

1. La déshydratation extracellulaire
2. L'insuffisance hépatocellulaire
3. Le syndrome néphrotique pur
4. Le myélome
5. Une alimentation riche en protides

C

A : 1+2 B : 1+3+5 C : 1+4 D : 4+5 E : 1+3

2. Le glucagon sécrété en réponse à une hypoglycémie provoque : (Cocher la réponse juste)

1. Une augmentation de la concentration intrahépatocytaire en AMPc
2. Une activation de la glycogène phosphorylase
3. Une augmentation de la concentration intrahépatocytaire en fructose 2,6-diphosphate (fructose 2,6-bisphosphate)
4. Une activation de la triglycéride lipase adipocytaire
5. Une inhibition de la gluconéogenèse

B

A : 1+2+3 B : 1+2+4 C : 1+2+5 D : 1+3+4 E : 1+4+5

3. Parmi les protéines suivantes, quelle proposition correspond à celles qui migrent au niveau des β2-globulines lors de l'électrophorèse des protéines sur agarose à pH = 8,6 ? (Cocher la réponse juste)

1. L'orosomucoïde
2. La transferrine
3. L'haptoglobine
4. La fraction C3 du complément
5. Les immunoglobulines M

D

A : 1+2 B : 1+4 C : 2+3 D : 2+4 E : 3+4

Biochimie (2023)

39- une femme obèse de 54 ans avec un diabète type 1 se présente à la consultation avec une glycémie à 5,8 g/l ; puis est hospitalisée, le lendemain un prélèvement sanguin est réalisé à jeun, le sérum est fortement lactescent ; l'émulsion a été conservée au frais pendant toute la nuit ; il présente un surnageant crémeux la partie inférieure demeure trouble, Cet aspect du sérum serait-il évocateur de : (RJ)

- A) Hypercholestérolémie familiale
- B) Hypertriglycéridémie Majeure Type V
- C) Hypertriglycéridémie Majeure Type IV
- D) Dyslipidémie mixte Type III
- E) Dyslipidémie mixte II-b

B

40- suite a une intervention chirurgical un patient a eu une complication présente par une accumulation d'un liquide d'épanchement au niveau du péritoine due a une rupture du canal lymphatique mésentérique ce liquide sera-t-il : (RJ)

- A)riche en low density lipoproteins
- B) riche en enzyme pancréatique
- C)riche en chylomicron
- D)pauvre en triglycéride
- E)riche en acide lactique

C

41-parmi les suivants concernant le peptide C quel est la fausse affirmations

- A)La production endogène de peptide C est équimolaire a la sécrétion insulinique
- B) Dans le diabète insulino dépendant son taux urinaire est fortement abaisse
- C)Le peptide c est constitutif de la pro insuline et de la pré pro insuline
- D)Son dosage sanguin n'est pas affecte par l'administration d'insuline exogène
- E) Son taux sanguin est abaisse en cas d'insuffisance rénale

E

42- quel signe clinique ou biologique ne peut pas être associe a une cholestase

- A)Steatorrhee
- B)Présence d'une lipoprotéine a au lipidogramme
- C) Selles décoloré
- D)Prurits
- E) Elévation de taux sanguin de sels biliaires

B

43-Parmis les propositions suivants concernant le métabolisme des lipoprotéines lequel est exact

- A)Apo lipoprotéine B48 est principalement synthétisé par le foie
- B)ABC1 est une protéine de transport de TG
- C)LPL est essentiellement localise dans le tissu hépatique
- D)L'apolipoprotéine C III est le principale activateur de la LPL
- E) La LCAT a comme principale substrat le cholestérol des HDL

E

Biochimie (2022)

1.Parmi les protéines suivantes, lesquelles sont synthétisées dans le foie ? (RJ)

- 1. L'albumine
- 2. Le facteur II de la coagulation
- 3. La CRP
- 4. La pro érythropoïétine
- 5. L'angiotensinogène

A: 1,2,3 B: 1,2,3,4 C: 1,2,3,5 D: 1,2,3,4,5 E: 1,3,5 C

2. Quel est le signe biologique spécifique qui confirme le diagnostic de cirrhose hépatique ? (RJ)

- A. Une albuminémie basse
- B. Une bilirubine totale élevée
- C. Des C-ALAT élevées
- D. Un bloc bêta-gamma à l'électrophorèse des protéines sériques
- E. Des phosphatases alcalines élevées

D

3. La galactosémie congénitale : (RF)

- A. Est une enzymopathie
- B. Est de transmission autosomique récessive
- C. Est responsable d'hyperglycémie avec retard mental
- D. Peut être due à un déficit en galactokinase
- E. Est due à un déficit en galactose 1P-uridylyltransférase

C

Biochimie (2021)

1. Parmi les propositions suivantes , laquelle est incompatible avec le diagnostic de diabète insipide central polyurie ? (RJ)

- A) Sodium plasmatique à 152 mmol
- B) Urée plasmatique à 0,59 g / l
- C) Protides totaux à 88 g / l
- D) Osmolalité urinaire à 822 mOsmol / kg après 8 H de restriction hydrique
- E) Perte de poids de 2 % par rapport au poids initial après 8H derestiction hydrique

D

2. L'examen clinique d'un enfant de 5 ans de sexe masculin , montre à la palpation , l'absence de testicule droit au niveau du scrotum . Dans le but de poser un diagnostic différentiel entre cryptorchidie et anorchidie , quel test proposeriez - vous ? (RJ)

- A) Un dosage statique de la testostérone
- B) Un test de stimulation à la β HCGC
- c) Un spermogramme
- D) Un dosage de la FSH et LH
- E) Un test de stimulation au Tamoxifène

A

3. Un enfant de 7 ans présente des hypoglycémies entre les repas , l'examen clinique montre des signes d'hépatomegalie . Un bilan biochimique a été réalisé et qui révèle une hyperlactacidémie et une hyperuricémie . Ces signes sont favorables de quelle perturbation enzymatique : (RJ)

- A) Déficit total en hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase
- B) Déficit en xanthine oxydase
- C) Déficit partiel en hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase
- D) Déficit en glucose 6 phosphate déshydrogenase
- E) Déficit en glucose 6 phosphatase

E

Biochimie (2020)

1. Une des hormones suivantes interagit avec un récepteur à protéine G : (RJ)

- A) L'insuline
- B) L'atriopeptine
- C) L'hormone de croissance
- D) Le glucagon
- E) La prolactine

D

2. Le diabète de type 1 est lié à une diminution de la capacité de cellules bêta du pancréas à produire l'insuline . Si une personne présente un DID oublie ses Injections d'insuline , elle présentera une : (RJ)
- A) Augmentation de la synthèse des acides gras à partir du glucose dans le foie
 - B) Diminution de la conversion des acides gras en corps cétoniques
 - C)Augmentation des stocks de triglycérides dans le tissu adipeux
 - D) Augmentation de la conversion de l'acéto - acétate en acétone
 - E) Aucune réponse exacte D
3. Le syndrome de détresse respiratoire du nourrisson prématuré est lié au déficit pulmonaire en : (RJ)
- A) Gangl oside
 - B) Sphingomyéline C)Prostaglandines
 - D) Cérébroside
 - E) Phosphatidyl – choline E

Biochimie (2019)

1. Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des lipoprotéines, laquelle est exacte:
- A. L'apolipoprotéine B48 est principalement synthétisée par le foie
 - B. La LCA T (lécithine cholestérol acyl transférase) fait partie intégrante de la structure des HDL (lipoprotéines de haute densité)
 - C. La LPL (lipoprotéine lipase) est essentiellement localisée dans le tissu hépatique
 - D. L'apolipoprotéine C-III est le principal activateur de la LPL
 - E. L'HDL-3 est la vraie lipoprotéine anti athérogène B
2. Parmi les propositions suivantes concernant l'hyperlipoprotéïnémie de type IV, laquelle est fausse ?
- A. Le sérum est limpide à jeun
 - B. Une intolérance aux hydrates de carbone peut en être à l'origine
 - C. Une cholestérolémie normale ou peu augmentée
 - D. Une élévation des triglycérides sériques
 - E. Une augmentation des VLDL A
3. Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des corps cétoniques, laquelle est fausse ?
- A. C'est un processus physiologique
 - B. C'est une voie de dérivation du catabolisme des acides gras
 - C. Les corps cétoniques urinaires sont des composés liposolubles
 - D. L'utilisation des corps cétoniques fournit de l'énergie
 - E. La synthèse des corps cétoniques augmente lors des épisodes de carence en glucose intracellulaire C

4. L'hyperparathyroïdie primitive s'accompagne : (Cocher la réponse inexacte).

- A. D'une élévation de l'activité des phosphatases alcalines
- B. De lithiase rénale
- C. D'une hypophosphatémie
- D. D'une élévation de la parathormone sérique
- E. D'une diminution de la concentration urinaire de l'AMP cyclique E

5. Parmi les affirmations suivantes concernant le diagnostic du diabète, laquelle est exacte ?

- A. Le diagnostic de diabète est posé si 2 glycémies à jeun sont retrouvées deux jours différents strictement supérieures à 1,26 g/L
- B. Le diagnostic de diabète chez une femme enceinte (26 semaines d'aménorrhée) est posé si la glycémie 1H après une HGPO (hyperglycémie provoquée par voie orale) est supérieure à 1,80 g/l
- C. Le diagnostic de diabète est posé si une glycémie supérieure à 2 g/l est retrouvée à n'importe quel moment de la journée sans signes cliniques accompagnateurs
- D. Dans l'épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale chez un adulte, 75g de glucose dans 250 ml sont ingérés en 5 min. Les glycémies sont mesurées à T0, à T=+1 heure et à T=+ 2 heures.
- E. La glycémie d'un diabétique deux heures après une épreuve d'HGPO est >à 2g/L

E

6. Au cours de l'infarctus du myocarde, que se passe-t-il dans les cellules myocardiques privées d'oxygène ?(Cocher la réponse exacte).

- A. Le cycle de Krebs est accéléré apportant d'avantage d'électrons pour la synthèse de l'ATP
- B. La pompe à protons en mitochondriale et ralentie ce qui empêche la synthèse de l'ATP par la phosphorylation oxydative
- C. La glycolyse anaérobie est ralentie par la phosphorylation oxydative
- D. La chaîne de transport des électrons
- E. Il y aura un découplage entre chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative

B

7. Parmi les combinaisons suivantes concernant les hormones, laquelle est exacte ?

- 1. Les hormones antéhypophysaires sont déficitaires dans le syndrome de Sheehan
 - 2. L'ADH est un peptide de 9 acides aminés de diabète insipide
 - 3. Le test de restriction hydrique permet de poser le diagnostic
 - 4. L'ocytocine permet la sécrétion lactée par la glande mammaire
 - 5. Dans un hypercorticisme d'origine surrénalienne, le taux d'ACTH plasmatique est élevé
- A :1-2-3 B: 1-2-4 C : 2-3-4 D : 2-3-5 E: 1-3-5 A

8. Parmi les combinaisons suivantes concernant la mucoviscidose, laquelle est exacte ?

- 1. Il y a une surproduction du mucus des voies respiratoires et digestives
- 2. Il y a un déficit génétique de la protéine CFTR
- 3. Les enzymes protéolytiques pancréatiques sont anormales
- 4. La cause majeure de la morbidité et de la mortalité est liée aux problèmes respiratoire
- 5. Elle peut être associée à une hypofertilité chez l'homme

A: 1-2-3 B: 1-2-4 C: 1-2-5 D: 2-4-5 E : 2-3-5 D

1. Du muscle, est utilisable pour recharger la glycémie
2. Libère du glucose-1-phosphate grâce à une phosphorylase phosphorylée
3. Du foie voit sa dégradation (glycogénolyse) stimulée par le glucagon
4. Pour être formé nécessite la présence de glycogène synthétase phosphorylée .
5. Est formé en plus grande quantité lors de l'insulino-sécrétion

10. Parmi les propositions suivantes concernant le coma hépatique, laquelle est inexacte ?

- Biochimie (2018)

2. Une hypoglycémie chez un enfant peut se rencontrer au cours de : (RJ)

- A : 1+2+3+4 B : 1+5 C:2+5 D:2+4 E: 1+2 C

3- Le retard mental observé chez les malades est du au manque de TYR pour les cellules cérébrale.

- A:1,3,4 B: 1,2,4,5 C:1,2,4 D:2,4,5 E:1,4,5 B

4. Les chylomicrons plasmatiques sont des lipoprotéines qui : (RJ)

1. Sont plus riches en cholestérol estérifié qu'en triglycérides.
2. Sont synthétisés par le foie.
3. Contiennent de l'apolipoprotéine B48.
4. Contiennent de l'apolipoprotéine E.
5. Sont transformés par action de lipoprotéine lipase. C

5. Chez les sujets à jeun, quels sont les paramètres utiles au diagnostic d'une hyperlipoprotéinémie ? (RJ)

- 1- Aspect du sérum.
- 2- Concentration sérique du cholestérol total.
- 3- Protéïnémie.
- 4- Triglycéridémie.
- 5- Protéinogramme.

A : 1+2+4+5 B : 3+4+5 C: 1+2+4 D: 2+3+4 E: 2+4+5 C

6. Parmi les éléments suivants, lequel accompagne l'ictère physiologique du nouveau-né ? (RJ)

- A. Urines foncées.
- B. Hyperbilirbinémie libre.
- C. Hyperbilirbinémie conjuguée.
- D. Anémie.
- E. Splénomégalie B

7. Quelles propositions concernant le profil d'une électrophorèse des protéines à PH 8,6 sont exactes : (RJ)

- 1- Un pic monoclonal au niveau des gamma globulines est en faveur d'une maladie Waldenstrom.
- 2- Un dédoublement de la fraction albumine peut être innée acquise.
- 3- Une diminution de la fraction albumine avec un pic en 12 est en faveur du syndrome néphrotique.
- 4- Les sens de migration des protéines se fait de l'albumine vers les gammaglobulines.
- 5- Le RBP ou rétinol binding protein migre au niveau des a 2 globulines.

A : 1,2,3,4 B:1,2,3,5 C:2,3,4,5 D:1,3,5 E: 1,2,3,4,5 B

8.A propos des hyperammoniémies : (RJ)

- 1- Elles peuvent être innées ou acquises.
- 2- Elles se voient au cours des grandes insuffisances hépatiques.
- 3- Elles peuvent se voir en cas de déficit enzymatique de l'une des enzymes de l'uréogénèse.
- 4- Elles s'installent en cas de déficit en glutamine synthétase très représentée dans le cerveau.
- 5- Elles peuvent évoluer vers la cirrhose hépatique.

A : 1,2,3,4,5 B: 2,3,5 C:1,2,3,4 D:1,3,5 E: 2,3,4 B

9. Un calcul bloqué dans la partie supérieure de la voie biliaire entraîne :

- A. Une augmentation de la formation des chylomicones.
- B. Un excès du recyclage des acides biliaires.
- C. Une exagération de l'excrétion des acides biliaires.
- D. Une élévation de la stéatorrhée.
- E. Une augmentation de l'activité de la lipase pancréatique. D

Biochimie (2017)

1/ La phénylcétonurie est une maladie métabolique caractérisée par les signes suivants sauf un, lequel ?

- a- C'est un déficit héréditaire en phénylalanine hydroxylase
- b- A présence de phenylpyruvate dans les urines.
- c- Son traitement consiste en un régime alimentaire sans phénylalanine
- d- Il y a un déficit en tyrosine
- e- Un retard mental s'installe par toxicité cérébrale de la PHE C

2- Le traitement de l'hypercholestérolémie par les statines est basé sur les caractères suivantes : (1R)

- a- C'est une inhibition de la synthèse endogène du cholestérol
- b- Ils stimulent la synthèse des récepteurs b/e
- c- Ils sont indiqués chez tout individu qui a. un taux de ldl-c sup à 1,60g/l
- d- Ils inhibent l'enzyme de formation du mévalonate
- e- Une surveillance hépatique et musculaire doit se faire durant le traitement

D

3/ Quel est l'enzyme dont le déficit est responsable de la galactosémie du nourrisson ?

- a- Galactokinase
- b- Galactose-1-phosphate uridyl transferase
- c- UDP-galactose 4 épimérase
- d- Galactose-1-phosphate pyrophosphorylase
- e- Phosphoglucomutase. B

4/ Un homme de 65 ans ayant une BPCO post tabagique et une insuffisance cardiaque d'origine coronarienne est hospitalisé en urgence pour décompensation cardiaque aiguë. Il est traité par Lasix IV et hospitalisé en cardiologie. Au bout de 4 jours l'état clinique s'est amélioré. Son bilan gazométrique montre: pH: 7.43 HCO₃⁻ : 35 mmol/l pCO₂: 50mmHg. De quel déséquilibre acide base s'agit-il ?

- a- Alcalose respiratoire
- b- Alcalose métabolique
- c- Acidose respiratoire compensée
- d- Acidose métabolique compensée
- e- Acidose mixte C

5/ Quelle est la cause de l'augmentation des bicarbonates chez le patient de la question 75: (1RJ)

- a- C'est la compensation du déséquilibre acide base
- b- C'est la décompensation cardiaque
- c- C'est l'administration de Lasilix
- d- Ce sont les réponses a et c
- e- Aucune réponse juste

A

6/ Un déficit en G6P deshydrogenase s'accompagne des signes suivants sauf un, duquel 'agit-il ?

- a- Une anémie hémolytique
- b- Un déficit en nadph, h
- c- Un déficit en glutathion oxydé dans le globule rouge
- d- Un déficit en haptoglobine sanguine
- e- Un taux de bilirubine indirecte sanguine élevé

D

7/ À propos des examens de surveillance des diabétiques: (1RJ)

- a- L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des 2-3 derniers mois précédant son dosage
- b- La fructosamine ne doit pas être demandée en cas d'insuffisance hépatique
- c- La fructosamine est demandée toutes les 3 semaines
- d- Une micro albuminurie 30 mg/24H doit faire rechercher une rétinopathie
- e- Une glycosurie négative confirme l'absence de diabète

A

8/ À propos la régulation de la glycémie, une seule réponse est fausse; laquelle ?

- a- En cas d'hypoglycémie, les îlots de Langerhans libèrent du glucagon
- b- Le foie stocke du glucose sous forme d'amidon et en relargue en présence de glucagon
- c- Les cellules musculaires absorbent du glucose en présence d'insuline
- d- Le diabète de type 2 est associé à une résistance à l'insuline des cellules cibles de cette hormone
- e- Au niveau cellulaire, le diabète de type 1 est associé à une destruction auto-immune des cellules bêta des îlots de Langerhans .

B

9/ À propos de la molécule d'insuline:(1RF)

- a- Elle est formée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes beta
- b- Son récepteur a une activité tyrosine kinase
- c- Elle stimule l'activation de la lipoprotéine lipase
- d- À jeun, sa sécrétion n'est pas nulle
- e- Elle stimule le transporteur glut-4 des cellules adipeuses

A

Biochimie (2016)

1. L'insuline: (1RJ)

- 1) Favorise le transport intra-adipocytaire du glucose par les transporteurs GLUT-4
- 2) Accélère la glycogénogenèse hépatique
- 3) Active la triglycéride lipase hépatique
- 4) Favorise l'anabolisme protéique dans le muscle
- 5) Inhibe la pénétration cellulaire du glucose

A-1+2+4 B-2+5 C-1+3+5 D- 1+3+4 E-2+4+5

A

2. L'insulinorésistance: (1RJ)

- 1) Précède généralement l'installation du diabète type 2
- 2) Elle se traduit par un hyperinsulinisme compensateur
- 3) Son principal organe est le muscle
- 4) Elle peut être d'ordre génétique ou acquise.
- 5) La glycémie présente des valeurs normales

A-1+2+4+5 B-1+4+5 C- 2+3+4 D- 1+2+3+4 E-1+3+5 D

3. L'hyperglycémie chez un diabétique insulino-dépendant: (1RJ)

- 1) Provient en partie d'une augmentation de la néoglucogenèse hépatique
- 2) Est la conséquence d'un défaut d'entrée de glucose dans les cellules musculaires
- 3) Est due à une élévation du seuil rénal d'élimination du glucose
- 4) Provoque une hyperhydratation du compartiment intra-cellulaire
- 5) Entraîne la glycation non enzymatique des protéines membranaires

A-1+2 B-2+4 C- 2+3+5 D-1+4 E-3+5 A

4. Une cétonémie caractérise: (1RJ)

- 1) L'état de jeun prolonge
- 2) Le diabète insipide
- 3) Le coma diabétique dû à un diabète insulino-dépendant
- 4) L'insuffisance rénale chronique
- 5) Le coma hypoglycémique

A-1+3 B-2+4 C-2+3 D-1+4 E-3+5 A

5. Une hypercholestérolémie est souvent secondaire à: (1RJ)

- 1) Un régime riche en cholestérol et graisses animales
- 2) Un régime riche en hydrates de carbone
- 3) Un alcoolisme chronique
- 4) Une malnutrition
- 5) Un hypothyroïdisme

A-2+3+4 B-2+5 C-1+3+5 D-1+5 E-1+2 D

6. Parmi les glycogénoses suivantes, laquelle vous paraît susceptible de développer une cirrhose hépatique: (1RJ)

- A- Glycogénose de type VI
B- Glycogénose de type IV ou maladie d'Anderson
C- Glycogénose de type II
D- Glycogénose de type I ou maladie de Forbes
E- Malade de Hers

B

7. L'Hyperlipoprotéinémie de type I est caractérisée par (1RJ)

- A- Un sérum à jeun clair
B- Une hyper-triglycéridémie importante
C- Une hypercholestérolémie importante
D- Une augmentation des β -lipoprotéines à l'électrophores
E- Une carence en apoprotéines CII

B

Immunologie

Immunologie (octobre 2024)

Concernant la réaction d'hypersensibilité de type III : (Cocher la proposition juste)

- 1- L'activation du système HLA est impliquée dans la survenue des lésions tissulaires.
- 2- Les bifurcations vasculaires sont fréquemment le siège de dépôts des complexes immuns pathogènes.
- 3- L'endothélium vasculaire glomérulaire est fréquemment le siège de dépôts des complexes immuns pathogènes
- 4- Les allo-anticorps anti HLA sont souvent incriminés dans la formation des CIC. B

A : 1+2 B : 2+3 C : 3+4 D : 1+4 E : 2+4

Les déficits immunitaires combinés sévères DICS sont : (Cocher la proposition juste) :

- 1- De révélation précoces vues les manifestations cliniques patentes
- 2- Une BCGite est souvent rencontrée après vaccination
- 3- Concernant l'immunité cellulaire innée assurée par les macrophage
- 4- Sont soit précoces soit tardifs selon les cellules touchées (T, B, NK)
- 5- Une consanguinité ainsi qu'un défaut génétique prédisposant sont fortement impliqués

A : 1+2+5 B : 1+4 C : 2+3+5 D : 2+3+4 E : 4+5 A

Immunologie (2022)

1. La gammopathie monoclonale dite bénigne est caractérisée par: (RJ)

1. Une douleur osseuse
2. Une VS peu augmentée
3. Un taux pondéral inférieur à 20 g/l s'il s'agit d'IgG
4. Une hyperlymphocytose au myélogramme
5. Une biopsie osseuse normale

A: 1,2,5 B:4 C: 1,3,4 D: 4,5 E 3,5 E

2. Parmi les complications du myélome, lesquelles sont dépendantes de l'Ig monoclonale : (RJ)

1. L'allongement du temps de thrombine
2. L'insuffisance rénale
3. L'ostéolyse
4. L'amylose
5. Les géodes osseuses

A: 1,2,5 B: 4 C: 1,2,4 D: 4,5 E. 5 C

3. Parmi les indications thérapeutiques des gammaglobulines humaines par voie parentérale, on retiendra : (RJ)

1. La maladie de Bruton
2. Les déficits sélectifs en IgA1
3. Les morsures faciales par un chien suspect
4. Les thrombopénies auto-immunes
5. L'hypogammaglobulinémie physiologique et transitoire du nourrisson

A: 1,2,5 B: 3,4 C: 1,3,4 D: 4,5 E: 1,3;5 C

Immunologie (2021)

1. Les pathologies suivantes font partie des hypersensibilités de type II :
 - A) L'anémie hémolytique auto - immune .
 - B) La thrombopénie auto - immune .
 - C) Les alvéolites allergiques extrinsèques :
 - D) Les cytopénies médicamenteuses .
 - E) Le syndrome de Good Pasture . C
2. Les signes suivants peuvent être révélateurs d'un caviion lome multiple : (RF)
 - A) Une protéinurie .
 - B) Un taux des immunoglobulines polyclonales sérique
 - C) Une plasmocytose médullaire supérieure à 10
 - D) Une vitesse de sédimentation très accélérée .
 - E) Une hypercalcémie B
3. Le Syndrome de Wiskott Aldrich : (RF)
 - A) Est transmis par le chromosome 14 .
 - B) Est dû à des mutations du gène codant la protéine WASP (Wiscott aldrich syndrome protéin.
 - C) Touche les lymphocytes , les plaquettes , les monocytes et la peau .
 - D) Se traduit cliniquement par des ecchymoses , pétéchies , épistaxis eczéma et des infections bactériennes récurrentes .
 - E) Le taux des IgM est bas , les IgA sont parfois élevées , les IgG sont dans les normes .A

Immunologie (2020)

1. La définition du stade SIDA Inclut : (RJ)
 - A)Un taux de lymphocytes T CD4 + inférieur à 200 / μ
 - B) Une forte concentration en IFN
 - C) Un taux d'immunoglobulines sériques supérieur à 30 g / l
 - D) Une activité NK très élevée
 - E) Un taux de γ macroglobuline inférieur à 2 mg / A
2. Les Corécepteurs du VIH : (RF)
 - A) Sont représentés par le CXCR4 (fusine) sur les lymphocytes T CD4 +
 - B) Sont aussi représentés par le CCR5 sur les macrophages
 - C) Interagissent avec la glycoprotéine 120 du virus après sa liaison avec la molécule CD4
 - D) Sont des récepteurs des chimiokines permettant la fusion des membranes virale et cellulaire
 - E)Ne sont pas indispensables à l'infection de la cellule par le virus E
3. Dans la maladie de Kahler , les géodes sont : (RJ)
 - A) Réparties préférentiellement sur les os des membres
 - B) Entourées d'une zone condensée
 - C)De contour irrégulier
 - D)Arrondie à limites nettes et à l'emporte pièce
 - E) Aucune de ces propositions n'est juste D

Immunologie (2019)

1. Chez l'enfant, le taux sérique d'IgA atteint normalement le taux de l'adulte vers l'âge de (Cocher la réponse exacte)
 - A. 1 à 6 mois
 - B. 7 à 12 mois
 - C. 1 à 3 ans
 - D. 4 à 5 ans
 - E. Toutes les réponses sont fausses. E
2. Les molécules HLA de classe II : (Cocher la réponse fausse)
 - A. Peuvent être induites sur certaines cellules par l'interféron gamma.
 - B. Sont formées par deux chaînes α et β polymorphes.
 - C. Le polymorphisme est porté par le domaine $\alpha 1$ et $\beta 1$ pour les molécules D
 - D. Les gènes de la chaîne α et β sont localisés au niveau du chromosome 6.
 - E. Sont exprimées par les lymphocytes T après activation. C
3. Concernant la transplantation rénale : (Cocher la réponse fausse)
 - A. Le cross match consiste à faire agir le sérum du receveur avec des cellules du donneur en présence de complément.
 - B. Le rejet hyper aigu est la conséquence de la présence d'allo Anticorps cytotoxiques, préformés chez le receveur et spécifiques du donneur,
 - C. Le dépôt du C1q spécifique au rejet aigu humoral est constamment retrouvé lors des biopsies exploratrices.
 - D. La présence chez le receveur d'IgG préexistants, anti-HLA du donneur contre indique la transplantation.
 - E. L'Allogreffe survient entre des individus génétiquement différents et issus d'une même espèce. C
4. L'activation du complément a pour effets biologiques possibles : (Cocher la réponse fausse)
 - A. L'opsonisation des bactéries.
 - B. La reconnaissance et la fixation de l'épitope
 - C. La solubilisation des complexes immuns.
 - D. La génération de l'inflammation par les anaphylatoxines. B
 - E. La lyse des microorganismes par le complexe d'attaque membranaire.
5. Les cytokines sont : Cocher la réponse fausse
 - A. Des glycoprotéines de haut poids moléculaire.
 - B. De nature protéique ou glycoprotéique synthétisés et sécrétés par de nombreux types de cellules
 - C. Interagissent avec des récepteurs membranaires
 - D. Peuvent s'inhiber entre elles
 - E. Peuvent agir en synergie pour réaliser une activité biologique donnée (effet de redondance) A
6. L'hypersensibilité granulomateuse : (Cocher la réponse fausse)
 - A. Est due à la persistance de l'antigène au sein des macrophages
 - B. Aboutit à la formation de granulomes à cellules épithélioïdes
 - C. Fait intervenir les lymphocytes T helper
 - D. Fait intervenir des cytokines de types TH2: IL4, IL5 et IL13
 - E. Peut-Être l'évolution d'une lésion de type tuberculique D

7. Le lupus érythémateux systémique se caractérise par : (Cocher la réponse juste)
- A. L'absence dans le sérum, de complexes immuns solubles circulants.
 - B. Une forte diminution des IgG polyclonales sériques.
 - C. Peut-être induit par certains médicaments.
 - D. Une forte augmentation des taux sériques du composant C3 et C4
 - E. Implication des mécanismes d'hypersensibilité de type III. E
8. Les auto anticorps anti-muscles lisses sont rencontrés dans : (Cocher la réponse juste)
- A. La cirrhose biliaire primitive
 - B. L'hépatite autoimmune de type I
 - C. L'hépatite autoimmune de type I
 - D. Les Myosites
 - E. Myocardite B
9. Le rejet hyper-aigu de greffe : (Cocher la réponse fausse)
- A. Survient quand le receveur possède des Allo-Acs préformés spécifiques des antigènes greffon
 - B. Se voit suite à des événements immunisants survenant avant la greffe telles les transfusion sanguines, grossesse, transplantation antérieure négatif
 - C. Est évité par une bonne compatibilité ABO et un cross-match
 - D. Est prévenu par la réalisation d'un cross-match entre les leucocytes du receveur et le sérum du donneur en présence du complément
 - E. Son seul traitement est la détransplantation D

Immunologie (2018)

1. Concernant les IgE : (RF)
- 1- Ce sont des complexes protéiques fortement glycosilés.
 - 2- Fixés au niveau mastocytaire, leur demi-vie est de plusieurs · semaines.
 - 3- Leurs demi-vie sérique est d'environ deux jours.
 - 4- Ce sont les principaux effecteurs impliqués lors des états d'hypersensibilités I et II.
 - 5- Leur production est favorisée par l'IL-4 et l'IFNY.
- A : 1+2+4 B: 1+3+4 C:1+4+5 D:4+5 E: 1+5 D
2. L'immunoglobuline A existe : (RF)
- 1- Sous forme de monomère.
 - 2- Sous forme de dimère.
 - 3- Liée à une pièce J.
 - 4- Liée à deux pièces sécrétoires.
 - 5- Avec trois sous-classes, IgA1, IgA2a et IgA2b.
- A : 1+2+4 B : 1+3+4 C:4+5 D:1+4+5 E: 175 C
3. La commutation isotypique : (RF)
- 1- Peut être déficient, par des mutations portant sur le gène du CD40L.
 - 2- Est une caractéristique des réponses immunitaires humorales développées contre les antigènes T indépendants.
 - 3- Une déficience de ce mécanisme est à l'origine du syndrome d'hyper IgM.
 - 4- Il y a changement dans la production de classe des chaînes légères.
 - 5- Chaque clone de lymphocyte B conserve sa spécificité antigénique.
- A : 1+2+4 B: 1+2 C:3+4 D:2+4 E:2+3+5 D

4. Les régions constantes des chaînes H alpha () des immunoglobulines assurent diverses fonctions : (RF)

- 1- La reconnaissance des peptides immunogènes présentés par le CMH.
- 2- La fixation et l'activation du système du complément par la voie
- 3- Le transfert placentaire.
- 4- L'opsonisation par la liaison aux récepteurs du système du complément.
- 5- La reconnaissance et la fixation de l'épitope.

A : 1+2+4 B : 2+3+4+5 C: 1+3+5 D: 1+2+3+4+5 E:2+4+5 D

5. Les principaux effets biologiques de l'activation du complément sont : (RF)

- 1- Induction d'une réaction inflammatoire par libération des anaphylatoxines.
- 2- L'opsonisation des micro-organismes par C3b.
- 3- Permettant fixation aux récepteurs CR1 et CR3 des cellules phagocytaires.
- 4- La solubilisation et le transport des complexes immuns par la liaison aux récepteurs CR1 des lymphocytes B.

5- La présentation de l'antigène aux lymphocytes T, par le C3b.

A : 4+5 B : 2+5 C :3+4 D:3+4+5 E: 1+2+4. A

6. Les molécules HLA de classe I : (RF)

- 1- Sont exprimées par les cellules nucléées de l'organisme.
- 2- Présentent le peptide immunogène exogène aux lymphocytes T CD4.
- 3- La chaîne β (β microglobuline) est intracellulaire.
- 4- La chaîne α est polymorphe.
- 5- Les gènes de la chaîne B ont localisés au niveau du chromosome 6.

A : 1+2+4 B : 2+3 C: 1+2+3 D:1+4+5 E:2+3+5 E

7. Parmi les examens biologique suivants lesquels sont plus évocateurs du lupus érythémateux disséminé : (RF)

- 1- L'hypergammaglobulinémie
- 2- La baisse du complément.
- 3- L'auto-anticorps anti-nucléosome.
- 4- L'auto-anticorps anti-Sm.
- 5- L'auto-anticorps anti-ADN dénaturée.

A : 1+4+5 B: 3+4 C: 3+4+5 D:2+3+4 E:2+4 B

8. Parmi les examens biologiques suivants, indiquer celui ou ceux l'on doit l'on doit demander des arthralgies et des myalgies depuis deux mois : (RJ)

- 1- Recherche d'un composant monoclonal.
- 2- Recherche de Facteur rhumatoïde et des auto-anticorps anti peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP).
- 3- Recherche et identification des auto-anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA).

4- Profil protéique du liquide synovial.

5- Recherche et identification des facteurs anti-nucléaires (FAN).

A : 3+5 B.: 4+5 C:1+2+5 D: 1+3 E: 2+3+5 E

9. Parmi les examens biologiques suivants, lequel est le plus évocateur d'une sclérodermie : (RJ)
- 1- L'hypogammaglobulinémie.
 - 2- La baisse du CH50.
 - 3- La présence d'auto-anticorps anti-SSA.
 - 4- La présence d'auto-anticorps anti-SCL70.
 - 5- La présence d'auto anticorps anti-cardiolipines.
- A: 5 B: 2+3 C: 1+3+4 D: 4 E: 3 D
10. Lesquels de ces auto-anticorps, sont les plus caractéristiques de la maladie de Wegener : (RJ)
- 1- L'auto-anticorps cANCA.
 - 2- L'auto-anticorps anti-protéinase 3 (PR3).
 - 3- L'anti-coagulant circulant.
 - 4- L'auto-anticorps anti-ADN à chaîne simple.
 - 5- L'auto-anticorps anti-myeloperoxydase.
- A : 1+4 B : 1+2 C : 1+2+5 D: 2+3+4 E: 1+5 B
11. Parmi les examens biologiques suivants, indiquer celui ou ceux que l'on doit demander en première intention pour un patient âgé de 60 ans présentant des douleurs osseuses diffuses, une pâleur cutanéo-muqueuse et des infections à répétition : (RJ)
- 1- FNS -VS.
 - 2- Recherche de Facteur rhumatoïde.
 - 3- Electrophorèse des protéines sériques.
 - 4- Profil protéique sérique.
 - 5- Recherche et titrage des auto-anticorps anti CCP.
- A : 3+5 B: 1+ C: 1+3 D: 1+2+5 E: 2+3+4+5 C

Immunologie (2017)

- 1/ La vaccination thérapeutique anti-tumorale est: (1RJ)
- a- Conçue pour stimuler les cellules immunitaires qui ciblent d'une manière non spécifique les antigènes tumoraux
 - b- Associée à une toxicité minimale
 - c- À l'origine de l'activation des cellules T qui protègent les cellules cibles
 - d- À l'origine de la libération de nouveaux antigènes tumoraux qui seront capturés par les cellules présentatrices d'antigènes afin de diminuer sa réponse à de multiples antigènes tumoraux avec le temps, et non seulement celui présenté par la construction vaccinale
 - e- Contre-indiquée dans différentes situations cliniques après l'utilisation des immuno-dulateurs (comme le BCG dans les cancers de la vessie) ou des vaccins cellulaires (Sipuleucel, Provenge® dans les cancers de la prostate)
- E
- 2/ Les Contre-indications d'une vaccination sont: (1RF)
- a- L'hyperthermie
 - b- Les maladies infectieuses aiguës ou subaiguës
 - c- Les maladies chroniques évolutives
 - d- L'inoculation ancienne de gammaglobulines
 - e- Les déficits immunitaires congénitaux ou acquis (chimio ou corticoïdes) surtout pour les vaccins à germes vivants atténués D

3/ Les effets indésirables possibles d'une vaccination sont: (1RJ)

- a- Une réaction générale
- b- Un épisode fébrile du 01er au 03eme jour avec les vaccins vivants, et différée entre le 5ème et le 11 ème jour Avec les vaccins inactivés
- c- Des convulsions hyperthermiques chez l'adulte pouvant être provoquées par des vaccins comme celui de la coqueluche ou de la rougeole
- d- Des arthralgies chez le jeune enfant pouvant être provoquées par des vaccins anti-rubéoleux ou contre l'hépatite B
- e- La parotidite, la réaction méningée pouvant être provoquées par le vaccin anti-ourlien

E

4/ Le rejet aigu cellulaire d'une greffe rénale: (1RJ)

- a- Représente 10% des rejets aigus
- b- À un pic de fréquence entre le 08ème jour à 3ème mois
- c- Est défini par la survenue d'une insuffisance rénale aiguë et des lésions parenchymateuses rénales, secondaires à une réponse immune cellulaire et/ou humorale du receveur dirigée contre les allo-antigènes du donneur
- d- Est caractérisé par une infiltration massive du greffon par des cellules polynucléées
- e- Est lié à l'activation des lymphocytes T CD4* de type Th2 qui jouent un rôle primordial (IL-2, IFN- γ)

B

5/ Au cours de l'infection par le VIH, le stade ARC (Aids Related Complex) se caractérise par : (1RJ)

- a- La survenue d'infections généralisées à type de candidoses
- b- Un taux de lymphocytes T CD4* < 200 éléments/mm³
- c- Une corrélation entre l'émergence des CTL et la diminution de la charge virale
- d- La survenue d'encéphalite due à l'action directe du VIH
- e- La survenue d'un amaigrissement modéré et de sueurs

A

6/ Le diagnostic biologique de l'infection par le VIH repose sur: (1RF)

- a- Des tests de dépistage par techniques immuno-enzymatiques de type ELISA
- b- Le dosage de l'antigène P24
- c- Un test de confirmation par le western blot
- d- La PCR qui n'est indiquée que pour les nouveau-nés de mère séropositive
- e- La positivité de deux tests ELISA et un test western blot

D

7/ Le syndrome IPEX / mutation du gène FOXP3: (1RF)

- a- Le FOXP3 est un facteur de transcription qui assure la différenciation des lymphocytes T régulateurs (Treg CD8+ CD25+)
- b- Se révèle par un bloc auriculo ventriculaire à la naissance
- c- C'est un Déficit quantitatif et/ou qualitatif des T cytotoxiques
- d- C'est une anomalie de tolérance périphérique des lymphocytes T
- e- Est de transmission autosomale récessive

E

8/ Parmi les examens biologiques suivants, lequel est le plus évocateur du lupus érythémateux aigu disséminé: (1RJ)

- a- L'hypergammaglobulinémie
- b- La baisse du complément
- c- La présence d'auto anticorps anti-Histone
- d- La présence d'auto anticorps anti-Sm
- e- La présence d'un anticoagulant circulant E

9/ Interleukine-2: (1RF)

- a- Est un facteur de croissance des lymphocytes T CD4*
- b- Est un facteur de croissance des lymphocytes T CD8+
- c- Est un facteur de croissance des lymphocytes B C
- d- Active l'expansion clonale des LT cytotoxiques (CTL) aux activités à médiation cellulaire
- e- Agit par le biais d'un récepteur trimérique α, β, γ exprimé par les lymphocytes T

10/ Les patients atteints de déficits immunitaires primitifs (DIP): (1RF)

- a- Atteignent rarement l'âge adulte
- b- Peuvent Présenter une susceptibilité accrue à développer des pathologies auto-immunes
- c- Peuvent Présenter une susceptibilité accrue aux infections mycosiques
- d- Peuvent Présenter une susceptibilité accrue à développer des pathologies tumorales
- e- Nécessitent souvent une étude génétique par séquençage génique pour confirmer le DIP évoqué A

Immunologie (2016)

1. L'atopie se caractérise par:(1RF)

- A-L'intervention d'un facteur de l'environnement et une prédisposition génétique
- B-L'implication de l'IL-4 et de l'IL-13 dans l'orientation du système immunitaire vers la synthèse des IgE
- C-Un déséquilibre lymphocytaire TH0 en faveur de la population TH1
- D-L'implication de cellules effectrices telles que le mastocyte, le basophile ainsi que la cellule dendritique C
- E- Une phase retardée où l'éosinophile constitue l'effecteur le plus important

2. Parmi les tests suivants, indiquer ceux qui permettent l'identification du ou des pneumallergènes en cause lors d'un phénomène atopique (1RJ)

- A-Le dosage des IgE totales
- B-Les tests cutanés et dosages des IgE spécifiques circulantes
- C-La recherche d'éosinophiles dans les sécrétions nasales
- D-Les dosages des IgE spécifiques circulantes par la technique RIST
- E- Les tests Cutanés avec des mélanges multi-allergéniques B

3. L'histamine est un médiateur: (1RF)

- A-Préforme et stocke dans les granules des mastocytes
- B-Induisant la contraction des fibres musculaires lisse
- C-Augmentant la perméabilité vasculaire
- D-Dont la libération est inhibée par les antihistaminiques
- E- Pouvant être libérée par les mastocytes sous l'action des anaphylatoxines C3 et C5a

D

4. La désensibilisation:(1RJ)

- A-Consiste en l'injection des doses décroissantes et contrôlées de allergène suspecte, afin d'obtenir des anticorps bloquants de type IgG4
- B-Consiste en injection de doses croissantes et contrôlées de l'allergène suspecté, afin d'obtenir des anticorps bloquants de type IgG4
- C-Consiste en l'injection de doses croissantes et contrôlées de l'allergène suspecté, afin d'inhiber la libération d'histamine
- D-Est une éviction de l'allergène
- E- Est un traitement symptomatique de la crise d'asthme afin de provoquer un état de tolérance

B

5. Dans les états d'hypersensibilité de type II, on peut classer:(1RJ)

- A-Les leucopénies auto-immunes
- B-La glomérulonéphrite lupique
- C-Les maladies hémolytiques fébriles
- D-Les alio-immunisation pré-transfusionnelles
- E- Le syndrome de Good Pasture

E

6. Quelles sont, parmi les propositions suivantes, celles qui permettant d'expliquer le rôle des IgE dans l'allergie:(1RJ)

- A-Leur présence à la surface des épithéliums sous la forme sécrétoire.
- B-Leur synthèse par des plasmocytes muqueux à IgA
- C- Des propriétés activatrices du complément par voie classique par les complexes immuns à IgE.
- D-La présence de récepteurs de haute affinité sur les mastocytes et les basophiles.
- E- Des prophètes opsonisantes via le RFce de type 1.

D

7. L'hypersensibilité allergique de contact: (1RJ)

- A-Est une réaction localisée au niveau du derme et l'hypoderme.
- B- Implique exclusivement des molécules de type hapténique
- C- Fait intervenir des lymphocytes TCD8+ mémoires spécifiques de l'allergène causal.
- D- Met en jeu comme principale cellule présentatrice d'antigène la cellule de Langerhans du foie
- E- Est également appelée hypersensibilité cutanée à basophiles.

B

8. Les maladies suivantes s'accompagnent d'un état d'hypersensibilité retardée: (1RF)

- A-La tuberculose.
- B-Le syndrome de Good Pasture.
- C-La leishmaniose
- D-La sarcoïdose.
- E- Diabète de type I.

B

9. Une réaction d'hypersensible de type retardée est d'origine de:(1RJ)

- A-L'eczéma atopique du nourrisson et de l'enfant
- B-La glomérulonéphrite lupique membrano-prolérative
- C-Maladie auto-immune systémique
- D-La pneumoallergique extrinsèque des éleveurs d'oiseaux
- E- La lésion casseuse d'une tuberculose extra-pulmonaire

E

10 Les contre indications d'une vaccination sont: (RF)

- A- Hyperthermie et les maladies infectieuses aiguës ou subaiguës
- B- Maladies chroniques évolutives
- C- Inoculation récente de gammaglobulines
- D- Femmes enceintes
- E- Patients hémodialysés

E

11. Les indications possibles des immunosuppresseurs sont: (1RF)

- A- A titre préventif comme en curatif, après transplantation d'organes (rein, cœur, foie, poumons, pancréas)
- B- Certains syndromes néphrotiques
- C- Formes sévères de certaines maladies auto-immunes.
- D- Formes sévères de dermatite atopique de l'adulte
- E- Asthme allergique sévère

E

12. Les contre indications d'une plasmaphérèse sont: (1RF)

- A- Infection non contrôlée
- B- Paraplégie
- C- Troubles du rythme non contrôlés
- D- Menace ou présence d'une nécrose myocardique récente
- E- Femme enceinte

B

13. Rejet hyper-aigu d'une greffe rénale (RF)

- A- Survient quand le receveur possède des Allo-Anticorps préformés spécifiques de l'antigène du greffon
- B- Les allo- Anticorps apparaissent suite à des événements immunisants survenant après la greffe
- C- Le seul traitement de ce type de rejet est la détransplantation.
- D- Un cross-match ou Test de compatibilité avant la greffe peut prévenir le rejet hyper-aigu
- E- Un cross-match positif est une contre-indication formelle de la greffe

B

Immunologie (2015)

1. Les anticorps ou immunoglobulines sont produits par les : (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Plasmocytes en collaboration avec les lymphocytes T auxiliaires TH2
- B- Plasmocytes en collaboration avec les macrophages et lymphocytes B
- C- Plasmocytes en collaboration avec les lymphocytes auxiliaires lymphocytes T CD4+
- D- Plasmocytes en collaboration avec les lymphocytes T cytotoxiques CD8*
- E- Plasmocytes et lymphocytes B en collaboration avec les lymphocytes T auxiliaires TH1

AC

2. Parmi les tests suivants, indiquer ceux qui permettent l'identification du ou des pneumallergènes en cause lors d'un phénomène atopique : (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Dosage des IgE totales
- B- Recherche d'éosinophiles dans les sécrétions nasales
- C- Tests cutanés
- D- Dosages des IgE spécifiques fixés sur les mastocytes
- E- Test de dégranulation des basophiles humains in vivo

C

3. Les maladies suivantes s'accompagnent d'un état d'hypersensibilité retardée : (Cocher la réponse INEXACTE)

A-La tuberculose

B-La polyarthrite rhumatoïde à un stade initial

C-La leishmaniose

D-La lèpre

E-La dermatite de contact

B

4. L'hypersensibilité de contact: (Cocher la réponse INEXACTE)

A-Est une réaction épidermique.

B-Fait intervenir les IgE spécifique de l'allergène en cause

C-Se traduit cliniquement par un eczéma avec des lésions érythémateuses au point de contact avec l'allergène

D-Implique des molécules de type hapténique couplées avec des protéines autologues

E-Met en jeu comme principale cellule présentatrice d'antigène la cellule de Langerhans

B

5. Dans la maladie de Waldenström: (Cocher la réponse INEXACTE)

A-On peut retrouver cliniquement des adénopathies et une splénomégalie

B-L'hyperviscosité sanguine est en rapport avec une forte concentration et le poids moléculaire du composant monoclonal

C-Le myelogramme montre une infiltration lympho-plasmocytaire

D-La présence de manifestations auto-immune à type d'une anémie hémolytique auto-immune est probable

E-On retrouve une production en quantité importante d'une IgM monoclonale monomérique

E

6. Le cross match (CXM) pré-transplantation par techniques de microlymphocytotoxicité: (Cocher la réponse INEXACTE)

A-A pour objectif de dépister les seuls anticorps anti-HLA responsables du rejet hyper-aigu

B-Ne détecte que les allo-anticorps anti-HLA d'isotype IgG

C-Peut être positif en dehors de toute allo-immunisation active anti-HLA

D-Peut se faire avec ou sans agent réducteur (diethylthiotheitol) pour distinguer l'isotype de l'anticorps

B

E-Peut être réalisé dans certains cas avec des lymphocytes totaux ou des lymphocytes T du receveur pour détecter des auto-anticorps

7. Les cellules tueuses naturelles ou cellules Naturel Killer (NK): (Cocher la réponse EXACTE)

A-Expriment parfois la molécule CD3

B-Représentent la sous- population majoritaire des lymphocytes

C-Nécessitent pour exercer leur activité lytique la reconnaissance du complexe CMH II peptide

D-Sont impliquées dans la destruction des cellules tumorales

E-Collaborent avec les lymphocytes B pour éliminer les antigènes thymo-indépendants

D

8. L'immunité humorale spécifique joue un rôle important, si non certain, dans les infections suivantes: (Cocher la réponse INEXACTE)
- A-Tétanos
 - B-Tuberculose extra-pulmonaire
 - C-Cholera
 - D-Typhoïde, méningite à méningocoque
 - E-Diphtérie B
9. Les déficits immunitaires combinés sévères (DICS): (Cocher la réponse INEXACTE)
- A-Sont à transmission autosomale dominant
 - B-Touchent les lymphocytes T et/ou les lymphocytes B et/ou les lymphocytes Naturel Killer déterminant le phénotype
 - C-Doivent bénéficier dans la majorité des cas d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques
 - D-S'accompagnent d'une très grande sensibilité aux infections virales et mycosiques, souvent mortelle
 - E-Constituent une contre-indication majeure pour les vaccinations par germes atténués. A
10. Les maladies auto-immunes sont : (Cocher la réponse INEXACTE)
- A-Secondaires à l'action d'autoanticorps naturels d'isotypes IgG polypécifiques
 - B-Rencontrées beaucoup plus chez les sujets de sexe féminin
 - C-Dues à une rupture de la tolérance vis-à-vis des constituants du soi
 - D-Des affections inflammatoires chroniques localisées ou systémiques
 - E-D'étiologie multifactorielle impliquant des facteurs environnementaux, hormonaux et génétiques A
11. Les cellules présentatrices d'antigène : (Indiquer la réponse INEXACTE)
- A-Sont représentées par les macrophages, les lymphocytes B et les cellules dendritiques
 - B-Se développent dans la moelle osseuse à partir de la cellule souche hématopoïétique pluripotente CD34+
 - C-Les cellules dendritiques sont appelées cellules voilées au niveau des canaux lymphatiques efférents
 - D-Sont les seules cellules qui expriment constitutivement les molécules HLA de classe II
 - E-Les cellules dendritiques sont dites immatures lorsqu'elles sont spécialisées dans la capture antigénique D
12. Dans la cytométrie en flux, l'utilisation d'anticorps spécifiques permet l'immunomarquage des différentes sous-populations lymphocytaires selon leurs marqueurs spécifiques : (Indiquer la réponse INEXACTE)
- A-CD56 et CD16 pour les cellules NK
 - B-CD14 pour les monocytes
 - C-CD18 pour les lymphocytes B
 - D-CD19, CD20 et CD21 pour les lymphocytes B,
 - E-CD3 et CD4 pour les lymphocytes T auxiliaires B

13. L'hypersensibilité de type II: (Indiquer la réponse INEXACTE)

A-Fait intervenir les anticorps d'isotypes IgM et IgG

B- Les lymphocytes NK participent dans les mécanismes lésionnels via leurs récepteurs FCY R III (CD16)

C- La maladie hémolytique du nouveau-né implique des anticorps d'isotype TM anti-antigène

D- Lors de la maladie hémolytique du nouveau-né, le test de Coombs indirect permet la mise en évidence des anticorps anti-D dans le sérum de la mère

C

E- Le rejet hyper-aigu est due à des d'allo anticorps cytotoxiques préformés chez le receveur

14. L'haptène: (Indiquer la réponse INEXACTE)

A- Est une substance de faible poids moléculaire (< 1000 Dalton)

B- Peut être constitué d'une mosaïque d'épitopes

C- Acquiert une immunogénecité lorsqu'il est associé à une protéine carrier

D- Est une substance non immunogène mais antigénique

E- Son association a une protéine porteuse peut déclencher une réaction d'hypersensibilité de type IV

B

Microbiologie
Microbiologie (octobre 2024)

1. Toutes les entérobactéries sont résistantes naturellement à la : (Cocher la réponse juste)

- A. Amoxicilline
- B. Cefotaxime
- C. Vancomycine
- D. Colistine
- E. Aminoglycoside C

2. La vaccination : (Cocher la réponse juste)

- A. Crée une immunité passive
- B. Suscite une immunité non protectrice
- C. Est un moyen d'immunisation artificielle
- D. Consiste à l'injection des anticorps spécifiques de l'agent pathogène
- E. Développe chez le sujet une immunité à médiation cellulaire uniquement C

3. Un antibiotique peut produire : (Cocher la réponse juste)

- A. Un mécanisme de résistance seulement en diminuant la perméabilité par modification des porines
- B. Un mécanisme de résistance seulement en diminuant la perméabilité par un système efflux
- C. Un mécanisme de résistance seulement par inactivation enzymatique de l'antibiotique
- D. Un mécanisme de résistance seulement par modification de la cible
- E. Toutes les réponses sont fausses E

4. La pénicilline G est un antibiotique : (Cocher la réponse juste)

- A. Active sur les BGN et sur les souches productrices de pénicillinases
- B. Inactive sur les BGN et sur les souches productrices de pénicillinases
- C. Active sur les CGP et sur les souches productrices de pénicillinases
- D. Inactive sur les CGP et sur les souches productrices de pénicillinases
- E. Active sur les CGN et sur les souches productrices de pénicillinases B

5. Les facteurs favorisant l'échappement des virus aux mécanismes de défense de l'hôte sont : (Cocher la réponse juste)

- A. La souche virale et la porte d'entrée du virus
- B. L'inoculum viral et la porte d'entrée du virus
- C. La variabilité génétique des épitopes et la latence du virus
- D. Le type de souche et l'inoculum viral
- E. La sénescence immunitaire et la latence du virus C

MicroBio (2023)

46- Streptococcus pneumoniae (cocher la réponse juste)

- A. est un cocci à gram négatif.
- B. peut être responsable de pneumonie et d'otite
- C. est bêta-hémolytique sur gélose au sang
- D. est résistant à l'optochine
- E. est une bactérie non exigeante. B

47. Neisseriagonorrhoeae:RJ

- A) est responsable de la blennorragie
- B) Est une bactérie aéroanaérobie facultative AAF
- C) Cultive sur milieu ordinaire
- D) Est un bacille Gram positif
- E) Est oxydase négative

A

48- Pseudomonas aeruginosa : (Cocher la réponse Juste)

- A) Est un Cocci Gram positif
- B) Est une bactérie pathogène spécifique
- C) Est incapable de produire du biofilm
- D) Est naturellement sensible à la vancomycine
- E) Est souvent impliquée dans les Infections associées aux soins

E

49) Le choléra : (Cocher la réponse juste)

- A) Est causé par une bactérie Gram positif microaérophile.
- B) Est suspecté devant une diarrhée glairrosanglante.
- C) Est une maladie à transmission hydrique engendrant une diarrhée aqueuse
- D) Est causée par V.cholerae séro groupe O4,
- E) Touche uniquement l'enfant de moins de 2 ans.

C

50- Legionellapneumophila: (Cochez la réponse Juste)

- A) Est responsable de la fièvre de Pontiac
- B) N'a pas la capacité de produire un biofilm
- C) Est une bactérie microaérophile
- D) Est l'agent de la tularémie
- E) Est une bactérie non exigeante de culture aisée

A

MicroBio (2022)

1. La présence de bacille à Gram négatif isolé d'un liquide articulaire d'un enfant drépanocytaire évoque: (RJ)

- A. Le staphylococcus aureus
- B. La kingella kingae
- C. La klebsiella pneumoniae
- D. La salmonella sp
- E. Le pseudomonas aeruginosa

D

MicroBio (2021)

1. L'Espèce avec une résistance naturelle au Céfotaxime est : (RJ)

- A) Proteus mirabilis
- B) Enterococcus faecalis
- C) Morganella morganii
- D) Streptococcus pneumoniae
- E) Staphylococcus aureus

B

2. Cette espèce bactérienne est pathogène stricte :

- A) Acinetobacter baumannii
- B) Chlamydia trachomatis
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D) Streptococcus pneumoniae
- E) Streptococcus agalactiae

D

3. La présence d'un risque de rubéole congénitale est associée à ce profil
 A) Absence des IgG antirubéoliques avant 20 S. A (semaine aménorrhée)
 B) Présence des IgG antirubéoliques avant la grossesse
 C) Absence des IgG antirubéoliques après 20 S.
 D) Test d'avidité des IgG supérieur à 70 % avant 20 S. A
 E) Test d'avidité des IgG inférieur à 30 % avant 20 S.A A
4. Pour faire le diagnostic bactériologique d'un cas clinique suspect de légionellose , il faut , en priorité : (RJ)
 A) Prescrire dans l'immédiat une antibiothérapie bactéricide
 B) Effectuer des prélèvements chez le patient et mise en culture sur milieu BCYE .
 C) Effectuer des prélèvements dans une alimentation en eau chaude
 D) Faire un séro - diagnostic de la légionellose .
 E) Rechercher l'antigène urinaire à l'aide d'un test immuno - chromatographique Op E
5. A propos de *Listeria monocytogenes* : (RJ)
 A) C'est un Bacille à Gram positif , responsable de méningites et de septicémies
 B) C'est une bactérie commensale de l'oropharynx
 C) Le diagnostic sérologique est spécifique de la listériose
 D) Une bactérie pathogène dont le réservoir de germes est strictement humain
 E) Est sensible aux céphalosporines de 3ème génération A
6. Parmi les espèces bactériennes suivantes , laquelle est une bactérie à pouvoir pathogène non spécifique ? (RJ)
 A) *Legionella pneumophila*
 B) *Staphylococcus aureus*
 C) *Salmonella typhi*
 D) *Treponema pallidum*
 E) *Mycobacterium tuberculosis* B

MicroBio (2020)

- 1 - Les antibiotiques ayant une bonne concentration au niveau des méni et efficaces pour le traitement des méningites purulentes sont : (RJ) .
 A) Aminosides .
 B) Glycopeptides .
 C) Céphalosporines 3G .
 D) Macrolides .
 E) Fluoroquinolones . C
- 2 - La présence d'un bacille à Gram négatif dans un LCR pratiqué chez un nouveau - né hospitalisé depuis 04 jours vous oriente vers l'étiologie bactérienne suivante : (RJ) .
 A) *Staphylococcus aureus* .
 B) *Escherichia coli* .
 C) *Pseudomonas aeruginosa* .. D) *Haemophilus influenzae* .
 E) *Chlamydia trachomatis* . B

3. L'Infection nosocomiale se transmet le plus souvent par : (RJ)

- A) Voie aéro - portée
- B) Vole manu - portée
- C) L'intermédiaire d'instruments mat stérilisés
- D) L'intermédiaire d'une eau souillée
- E) Toutes ces propositions sont justes

B

4. L'Infection nosocomiale se transmet le plus souvent par : (RJ)

- A) Voie aéro - portée
- B) Vole manu - portée
- C) L'intermédiaire d'instruments mat stérilisés
- D) IL'intermédiaire d'une eau souillée
- E) Toutes ces propositions sont justes

C

MicroBio (2019)

5. A Propos de Neisseria meningitidis :(Cocher la réponse fausse)

- A. Se présente en coloration de Gram sous forme de diplocoques Gram négatif
- B. Possède une cytochrome-oxydase (test de diagnostic)
- C. Le sérotype A prédomine ces dernières années au détriment du B qui se fait rare
- D. Culture positive sur gélose au sang cuit
- E. Est sensible à l'ampicilline

C

6. Au cours d'une méningite d'origine virale (entérovirus), le LCR a habituellement les caractères suivants :(Cocher la réponse juste)

- A. Liquide d'aspect clair
- B. Réaction cellulaire lymphocytaire
- C. Hyperprotéinorachie
- D. Hypoglycorachie
- E. Présence d'antigènes solubles (agglutination au latex)

D

7. A propos de Listeria monocytogenes (Cocher la réponse juste)

- 1. Peut être responsable de méningo-encéphalite
- 2. Peut être responsable d'infections materno-foetales
- 3. Est sensible à l'action d'une céphalosporine de 3ème génération
- 4. Est sensible à l'action d'une quinolone
- 5. Elle peut être évitée par vaccination

A:1-2 B:2-3 C:3-4 D:3-5 E:1-5

A

8. Les patients atteints de déficits immunitaires primitifs (DIP): (Cocher la réponse fausse)

- A. Atteignent parfois l'âge adulte.
- B. Ont une susceptibilité accrue à développer des pathologies auto-immunes.
- C. Peuvent présenter une susceptibilité accrue aux infections mycosiques.
- D. Ont une susceptibilité accrue à développer des pathologies tumorales.
- E. Nécessitent souvent une étude génétique en première intention afin de typer le D suspecté.

A

9. A Propos de Salmonella typhi: (Cocher la réponse fausse)

- A. Son isolement au laboratoire se fait principalement par coproculture
- B. Son réservoir est strictement humain
- C. Les porteurs sains jouent un rôle dans la dissémination de la maladie
- D. Bacille à Gram négatif H₂S+ D
- E. Est souvent sensible au chloramphénicol, ampicilline et co-trimoxazo

10. A Propos de Vibrio cholerae : (Cocher la réponse fausse)

- A. Le prélèvement de selle est d'aspect eau de riz
- B. Les Vibrio cholerae, 01 et 0139, producteurs de toxines sont responsables d'épidémies
- C. Son isolement au laboratoire se fait sur milieu gélose au sang frais
- D. Est un Bacille à Gram négatif Oxydase positive
- E. La réhydratation du patient est primordial par rapport l'antibiothérapie

C

11. A propos de la Concentration Minimale d'Inhibition (CMI) d'un antibiotique (ATB) :
(Cocher la réponse fausse)

- A. Exprime la puissance d'un antibiotique
- B. Elle peut être calculée pour chaque type d'ATB vis-à-vis de chaque famille de bactéries
- C. Elle peut être mesurée simplement par E-test
- D. Sa mesure nécessite des techniques complexes
- E. La CMI d'un ATB vis-à-vis d'un germe donné est stable dans le temps et dans l'espace

A: 1-2 B:1-3 C: 2-3 D:3-4 E:4-5 E

12. La listériose neuro-méningée : (Cocher la réponse juste) .

- 1. Ne survient que chez le sujet immunodéprimé
- 2. Est fréquemment isolée en Algérie
- 3. Elle touche l'homme et l'animal (bovins)
- 4. Est causée par un Bacille à Gram positif
- 5. Est la présentation habituelle de la listériose de la femme enceinte

A: 1-2 B: 2-3 C: 1-3 D: 3-4 E: 2-5 D

13. La résistance des bactéries aux antibiotiques :(Cocher la réponse fausse)

- A. Est variable en fonction des bactéries
- B. Est variable en fonction des antibiotiques
- C. N'est pas en relation avec l'information génétique de la bactérie
- D. Peut être due à une ou des mutations spontanées
- E. Peut être favorisée par une antibiothérapie à large spectre C

14. Les glycopeptides : (Cocher la réponse fausse)

- A. Sont souvent actifs sur les MRSA(Staphylococcus Aureus Résistant Méricilline)
- B. Ont un spectre large
- C. Ont un temps de demi-vie court
- D. Incluent Teicoplanine
- E. Sont d'usage strictement hospitalier B

15. Les Papillomavirus impliqués dans le développement d'un cancer du col utérin

(Cocher la réponse fausse)

- A. Sont des virus à ADN bicaténaire enveloppés
- B. Est un facteur obligatoire et suffisant dans le développement d'un cancer
- C. Sont à l'origine d'une lésion anatomo-pathologique (CCU) appelée koïlocyte
- D. Sont associés au faible statut socio-économique des patientes
- E. Le cancer du col utérin peut être prévenu par la vaccination

A

MicroBio (2018)

1. Les règles de prescription d'un ATB doivent tenir compte : (RJ)

- A. De l'isolement en culture de la bactérie pathogène.
- B. Du délai de réponse du laboratoire pour les résultats de l'antibiogramme et CMI.
- C. De la pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) de l'antibiotique choisi.
- D. De l'urgence clinique.
- E. Toutes ces réponses sont exactes.

E

2. La bactérie (bacille à Gram négatif non fermentaire) multi-résistante aux antibiotiques à l'origine d'infections nosocomiales rencontrées fréquemment dans les services de réanimation est : (RJ)

- A. *Klébsiellapneumoniae*.
- B. *E.coli* BLSE.
- C. *Acinetobacterbaumannii*.
- D. *Pseudomonas aeruginosa*.
- E. *Q*taphylococcusaures MRSA+.

C

3. Parmi ces vaccinations, quelle est celle qui est recommandée aux personnes travaillant en contact avec les usées ? (RJ)

- A. *Haemophilus influenzae*.
- B. Hépatite B.
- C. Hépatite A.
- D. BCG.
- E. Grippe.

C

4. Dans la liste suivante, quels sont les vaccins contre-indiqués chez la femme enceinte : (RJ)

- 1- Vaccin anti-hépatite A.
- 2- Vaccin anti-poliomyelitique injectable.
- 3- Vaccin contre la rubéole.
- 4- Vaccin contre la rougeole.
- 5- Vaccin anti-grippal.

A : 1+2 B:2+3 C:3+4 D:4+5 E: 1+5

C

5. Les espèces bactériennes classées bacilles à Gram plus sont : (RJ)

- 1- *Haemophilus influenzae*.
- 2- *Corynebacterium diphtheriae*.
- 3- *Listeria monocytogenes*.
- 4- *Clostridium tetani*.
- 5- *Accinetobacterbaumannii*.

A : 1+2+3 B:1+4+2 C:2+3+4 D:4+1+5 E: 3+4+5

C

6. Concernant la leptospirose intéro-hémorragique : (RJ)

- 1- La voie de contamination habituelle est muqueuse ou cutanée.
- 2- Parmi les symptômes et les signes clinique habituels figurent l'hépatomégalie.
- 3- On note comme anomalie de la lignée blanche, une hyperleucocytose à lymphocytes.
- 4- Le diagnostic repose sur l'hémoculture sur gélose ordinaire et sur la réaction de Martin

et Petit (MAT)

5- Le traitement antibiotique de choix est la pénicilline G.

A : 1+2 B: 2+3 C: 3+4 D: 4+5 E: 1+5 E

7. Ces virus sont transmis par voie cutanée : (RJ)

- 1- Epstein Barr virus.
- 2- Herpes simplex virus.
- 3- Polymavirus.
- 4- Varicelle Zona virus.
- 5- Virus de la rubéole.

A: 5 B : 2+4 C: 3 D: 1+2+4 E: 1+2 B

8. Dans la croissance bactérienne, le temps de génération : (RJ)

- 1- Est toujours de vingt minutes (20mn).
- 2- Est le temps nécessaire à trois dédoublements.
- 3- Varie avec la courbe de croissance.
- 4- Dépend du milieu de culture.
- 5- Dépend de l'espèce bactérienne.

A : 1+3+2 B : 2+3+4 C: 1+3+4 D: 1+2+5 E: 3+4+5 E

9. La bêtalactamase à spectre étendu (BLSE) est une enzyme : (RF) :

- A. Produite essentiellement par les antibiotiques de la famille des Béta-lactamines ?
- B. Dont le support génétique est plasmidique.
- C. Qui confère une résistance à l'imipénème.
- D. Qui confère une résistance à toutes les Béta-lactamines à l'exception.
- E. Qui confère une résistance aux Céphalosporines de 3 ème génération.

C

10. La Vancomycine est un antibiotique : (RF)

- 1- Appartient à la famille des glycopeptides.
- 2- A spectre d'activité prescrit de préférence sur bactéries Bacille à Gram négatif.
- 3- Inactif sur Staphylococcus aureus.
- 4- A usage principalement en milieu hospitalier.
- 5- Doit être prescrit avec les précautions d'usage chez les patients . insuffisants rénaux.

A: 1+2 B: 2+3 C: 3+4 D: 4+5 E: 1+4+3 B

11. Parmi ces propositions : (RF)

- A. Les Streptocoques du groupe A sont généralement sensibles à la pénicilline G.
- B. Les Proteus sont généralement résistants à la colistine.
- C. Listeria monocytogenes sont généralement sensibles aux céphalosporines.
- D. Les Salmonelles sont généralement sensibles aux aminopénicillines.
- E. Les Staphylocoques « méti R » sont généralement sensibles aux : glycopeptides.

C

12/ Au cours d'une méningite nosocomiale (d'inoculation) à *Acinetobacter baumannii*, le LCR a habituellement les caractères suivants: (1RJ)

- a- Aspect trouble
- b- Présence de coccobacilles à Gram négatif ou de bacille à Gram négatif
- c- Réaction cellulaire lymphocytaire
- d- Hyperglycorachie
- e- Présence d'antigènes capsulaires solubles (agglutination au latex)

A: a+b / B: b+c / C: a+d / D: a+e / E: b+e

A

13/ Les agents microbiens à l'origine de méningites purulentes d'origine communautaire rencontrées fréquemment en Algérie sont: (1RJ)

- a- *Streptococcus pneumoniae*
- b- *S. aureus*
- c- *Listeria monocytogenes*
- d- *Klebsiella pneumoniae*
- e- *Neisseria meningitidis*

A: a+b / B: b+c / C: a+d / D: a+e / E: b+e

D

14/ La toxine tétanique a les propriétés, sauf une, laquelle ? : (1RF)

- a- Apyrogène
- b- Antigénique
- c- Protéique
- d- Neurotrope
- e- Thermostable

E

15/ L'antibiotique de choix dans le traitement d'infections à germes anaérobies dues à *Bacteroides* est: (1RJ)

- a- La streptomycine
- b- La colimycine
- c- Les tétracyclines
- d- L'ampicilline
- e- Le métronidazole

E

16/ Le prélèvement d'urines fait partie des prélèvements pratiqués pour la détection du virus dans: (1RJ)

- a- La grippe
- b- L'infection à cytomegalovirus
- c- L'infection à rotavirus
- d- L'infection à Virus R.S. (Respiratoire syncytial)
- e- La légionellose

A: a+b / B: b+c / C: a+d / D: a+e / E: b+e

E

17/ Classer la bactérie selon sa morphologie en coloration de Gram correspondante: (1RJ)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- <i>Streptococcus pneumoniae</i> | a- bacille à Gram positif sporulé |
| 2- <i>Clostridium tetanii</i> | b- diplocoque Gram positif en forme de bougie ou lunette |
| 3- <i>Neisseria meningitidis</i> | c- bacille Gram négatif |
| 4- <i>Staphylococcus aureus</i> | d- coco-bacille à Gram négatif |
| 5- <i>E.coli</i> | |

A: 1+a / B: 2+a / C: 3+d / D: 4+b / E: 5+d

B

18 Parmi les vaccinations suivantes, citez celle qui est obligatoire pour tout travailleur hospitalier en contact avec des malades ? : (1RJ)

- a- Grippe
- b- Variole
- c- Tuberculose
- d- Hépatite B
- e- Tétanos

D

19/ Un antibiotique a prouvé son efficacité dans le traitement des infections nosocomiales à A.baumannii multi-résistant : lequel ? : (1RJ)

- a- Imipenem
- b- Cefotaxime
- c- Colistine
- d- Gentamicine
- e-Ciprofloxacin

A

20/ L'Epstein Bar Virus possède les caractéristiques suivantes : (1RF)

- a- Appartient à la famille des Herpes virus
- b- Virus à ADN
- c- Se multiplie dans le cytoplasme
- d- Souvent responsable d'infection récidivante ou persistante
- e- Doué d'une potentialité oncogène

C

21/ Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui ne s'applique pas aux plasmides : (1RF)

- a- Composés d'ADN bicaténaire
- b- Porteurs de gènes de résistance
- c-Leur transfert se fait par conjugaison bactérienne
- d- Toujours intégré au chromosome bactérien
- e- Doué d'une réplication indépendante

D

MicroBio (2016)

1. Parmi les propositions concernant Bordetella pertussis, laquelle est juste ?

- A-C'est un Bacille à Gram négatif
- B-Le prélèvement à visée diagnostique se fait par aspiration naso-pharyngée
- C-Les sujets atteints en Algérie par cette bactérie sont le plus souvent des nourrissons
- D-L'antibiotique de référence actif sur cette bactérie est la pénicilline G
- E- Toutes ces réponses sont exactes

E

2. Legionella pneumophila : (1RJ)

- 1. Il s'agit d'un bacille à Gram négatif
- 2. C'est une bactérie vivant en milieu liquide
- 3. Une basse température favorise son développement
- 4. Ce microorganisme est de type pathogène opportuniste
- 5. Sa culture au laboratoire s'effectue aisément en routine

A-1+2 B-2+3 C-3+4 D-4+5 E-1+5

A

E- La vaccination anti rougeoleuse est un bon moyen de prevention

9. La meilleure méthode de stérilisation du matériel médico-chirurgical réutilisable est: (1RJ)
- A-Chaleur sèche (poupinel)
 - B-Chaleur humide (autoclave)
 - C-Gaz (oxyde d'éthylène)
 - D-Eau de javel
 - E- La pasteurisation

B

MicroBio (2015)

1. Les bactéries considérées comme étant nosocomiales sont :

- 1) Haemophilus influenzae
- 2) SARM
- 3) Pénicilline +
- 4) Neisseria meningitidis
- 5) Streptococcus pneumoniae à sensibilité diminuée à la Pénicilline (souche SDP)
- 6) Entérobactéries BLSE +

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

A-1+2 B-2+3 C-3+5 D-1+3 E-2+5

E

2. Les agents microbiens à l'origine des infections nosocomiales rencontrées fréquemment dans les services hospitaliers du CHU de Blida sont :

- 1) Pseudomonas aeruginosa
- 2) S. aureus
- 3) E.coli
- 4) Klebsiella pneumoniae
- 5) Acinetobacter baumannii

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

A-1+2 B-2+3 C-3+5 D-1+5 E-2+4

D

3. Le principal facteur de risque de l'infection urinaire nosocomiale en chirurgie est l'existence chez le patient: (Cocher la proposition EXACTE)

- A-d'une sonde urétrale
- B-d'un diabète
- C-d'une lithiase urétérale
- D-d'une hospitalisation prolongée
- E- d'un bas niveau d'hygiène dans le service d'hospitalisation

A

4. Dans une pneumopathie d'origine nosocomiale précoce, les principaux germes isolés sont :

- 1) Haemophilus
- 2) anaerobics
- 3) Pseudomonas aeruginosa.
- 4) S. aureus MRSA +
- 5) Pneumocoque

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

A-1+2 B-2+3 C-3+5 D-1+5 E-2+5

C

5. Parmi les antibiotiques suivants, un seul reste actif sur Staphylococcus aureus MRSA +, lequel?
A-Gentamicine
B-Oxacilline
C-Céfotaxime
D-Vancomycine
E-Ampicilline D
6. Streptococcus pneumoniae : (Cocher la proposition EXACTE)
A-est un diplocoque encapsulé à Gram négatif
B-donne une hémolyse verdâtre (alpha) sur gélose au sang
C-n'est pas incriminé dans les infections respiratoires d'origine nosocomiale
D-peut résister aux pénicillines par production d'une pénicillinase
E-est régulièrement sensible aux pénicillines B
7. Listeria monocytogenes présente une résistance naturelle à la: (Cocher la proposition EXACTE)
A-Pénicilline
B-Céfotaxime
C-Gentamicine
D-Ampicilline
E-Sulfamethoxazol-trimethoprim B
8. Le streptocoque présente une résistance à : (Cocher la proposition EXACTE)
A-Pénicilline naturelle
B-Gentamicine
C-Spiramicine
D-Erythromycine
E-Céfotaxime B
9. L'infection nosocomiale se transmet le plus souvent par: (Cocher la proposition EXACTE)
A-Voie aéro-portée
B-Voie manu-portée
C-L'intermédiaire d'instruments mal stérilisés
D-L'intermédiaire d'une eau souillée
E-Toutes ces propositions sont justes BC
10. Parmi les prélèvements suivants, quel est celui qui permet le plus souvent le diagnostic bactériologique d'une septicémie : (Cocher la proposition EXACTE)
A-LCR
B-Coproculture
C-Hémoculture
D-Urines
E-Prélèvements périphériques C

11. Les objectifs du Réseau Algérien de Surveillance de la Résistance des Bactéries aux Antibiotiques AARN sont en priorité d'assurer une fonction: (Cocher la proposition EXACTE)

- A-De veille épidémiologique concernant la résistance aux antibiotiques
- B-D'alerte rapide par le recueil des données de l'antibiogramme et des CMI
- C-D'analyse et de diffusion des résultats aux cliniciens
- D-Primordiale dans la stratégie des CLIN au sein des hôpitaux
- E- Toutes ces réponses sont exactes E

12. La résistance bactérienne aux carbapénèmes (production de carbapénémases) est un mécanisme de résistance qui concerne principalement les bactéries suivantes :

- 1) Enterococcus
- 2) SARM
- 3) Streptococcus pneumoniae à sensibilité diminuée à la Pénicilline (souche SDP)
- 4) Acinetobacter
- 5) Pseudomonas

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

- A-1+2 B-2+3 C-3+4 D-5+2 E-4+5 D

13. Le contrôle de l'émergence et la diffusion de la résistance bactérienne aux antibiotiques nécessite : :(Cocher la proposition EXACTE)

- A-Une prescription rationnelle des antibiotiques
- B-Des mesures d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains
- C-La connaissance de l'épidémiologie de la résistance bactérienne locale
- D-Une formation continue du personnel soignant
- E- Toutes ces réponses sont exactes E

14. Les Bêta-lactamines sont des antibiotiques

- 1) Agissent sur les souches d'Acétobacter productrices de bêta-lactamase à spectre élargi (BLSE)
- 2) A spectre étroit
- 3) Agissent sur la paroi bactérienne
- 4) Agissent sur les bactéries à Gram négatif et positif
- 5) Sont toujours d'origine naturelle C

▣ Parasitologie ▣

Parasito (octobre 2024)

1. Parmi les propositions suivantes concernant les amibes parasites du tube digestif de l'homme, une est fausse. Indiquez laquelle :

- A. Sont des protozoaires se déplaçant à l'aide des pseudopodes appartenant aux genres : Entameba, Endolimax et Pseudolimax
- B. Entameba histolytica est spécifiquement humaine et est la seule amibe du colon pathogène pour l'homme dont la distinction entre elle et les amibes non pathogènes du genre Endolimax et Pseudolimax repose sur la structure microscopique du noyau
- C. Entameba gingivalis est une amibe de la bouche se présentant uniquement sous forme végétative, capable d'ingérer les hématies et les globules blancs
- D. Dientameba fragilis est une amibe se présentant uniquement sous forme végétative
- E. Entameba histolytica est une amibe du colon responsable d'amebose infestation et d'amebose maladie

A

2. Parmi les propositions suivantes concernant la leishmaniose cutanée retrouvée en Algérie, laquelle est exacte : (Cochez la réponse juste)

- 1-Elle peut guérir spontanément en laissant une cicatrice indélébile et inesthétique
- 2-La leishmaniose cutanée à *Leishmania major* est une forme clinique pouvant se manifester par des lésions ulcérocrouteuses siégeant aux niveaux des parties découvertes du corps
- 3-La leishmaniose cutanée sporadique (du Nord) à *Leishmania infantum* MON-24 est une zoonose dont le réservoir animal est le rongeur
- 4-La leishmaniose cutanée sèche à *Leishmania killicki* est une zoonose dont le réservoir animal est le chien
- 5-Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite sous sa forme amastigote à l'examen des frottis cutanés colorés, ou sous sa forme promastigote en culture des sérosités cutanées ou de l'ADN parasitaire aux niveaux des prélèvements cutanés

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 3+4+5 D : 1+2+5 E : 1+3+4 D

3. Pour une algérienne enceinte de retour du Gabon, ayant un accès palustre à *Plasmodium falciparum* confirmé (parasitémie modérée), sans aucun signe de gravité et ne vomissant pas, la prise en charge consistera en : (Cochez la réponse juste)

- 1- Une administration rapide de traitement spécifique per os.
- 2- Un traitement en ambulatoire avec un contrôle clinique et parasitologique à J3, J7 et J28 après le début du traitement.
- 3- Un traitement en milieu hospitalier avec un contrôle clinique et parasitologique à J3, J7 et J28 après le début du traitement.
- 4- Une interruption médicale de la grossesse.
- 5- Abstention thérapeutique.

A : 1+2 B : 2+4 C : 1+3 D : 3+4 E : 5 C

4. Parmi les propositions suivantes concernant les poux, une est fausse. Indiquez laquelle :
- A. Leur diagnostic est assuré par la mise en évidence de l'ectoparasite adulte et/ou ses lentes ; et leur traitement repose sur le traitement du sujet atteint, de son entourage ainsi que le traitement des vêtements et de la literie
 - B. La phthiriose est une ectoparasitose cosmopolite due au "Phthirius pubis » dont le traitement du ou des partenaire(s) sexuel(s) n'est pas indispensable
 - C. La pédiculose de la tête due au "Pediculus humanus capitis" touche essentiellement les enfants d'âge scolaire et se traduit sur le plan clinique par un prurit violent du cuir chevelu à prédominance rétro-auriculaire et/ou occipitale
 - D. La pédiculose corporelle due au "Pediculus humanus corporis" se traduit sur le plan clinique par un prurit corporel violent et dont la contamination est assurée par les vêtements et/ou la literie contaminés
 - E. La phthiriose est sexuellement transmissible se manifestant essentiellement par un prurit violent de la région pubienne

B

5. La pneumocystose est une mycose opportuniste : (Cochez la réponse juste)

- 1-Anthroponotique due à un champignon atypique « Pneumocystis jirovecii » contractée par voie aérienne.
- 2-Due à une réactivation d'un foyer pulmonaire latent lors d'une immunodépression.
- 3-Qui se traduit sur le plan clinique chez un adulte immunodéprimé par : une fièvre, une toux sèche et une dyspnée d'intensité croissante.
- 4-Dont la transmission interhumaine est possible et sa prise en charge nécessite l'isolement des malades des sujets réceptifs (immunodéprimés).
- 5-Au cours de laquelle le champignon est recherché essentiellement dans le liquide de Lavage Bronchio-Alvéolaire (LBA) par un examen direct et en culture sur les milieux usuels de mycologie.

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 1+3+4 D : 1+2+5 E : 3+4+5 C

Parasitologie (2023)

33- au cours de l'amœbose maladie :(Cochez ta réponse juste)

- A) Amœbose hépatique est due à l'entamoebahistolytica type minuta , ce traduit sur le plan clinique par une hépatomégalie douloureuse et fébrile
- B) Amœbose hépatique est une forme clinique extra intestinal dont le diagnostic est essentiellement coproparasitologique
- C) Amœbose intestinal aiguë est une forme clinique intestinale dont le diagnostic assure essentiellement par la recherche d'anticorps spécifique dans le sérum
- D) Amœbose intestinal aiguë Amœbose intestinale aiguë due à Entamæbahistolytica type histolytica, se traduit sur le plan clinique par un syndrome dysentérique associant : des épreintes , des tenesmes et des crachats rectaux glairo-sanglants
- E) le traitement fait appel uniquement aux antiamibiens de contact

D

34-la conduite à tenir chez une femme enceinte non immunisée pour la toxoplasmose consiste a : (Cochez la réponse juste)

- 1)un dernier contrôle sérologique négatif le jour de l'accouchement permet d'écarter le risque de toxoplasmose congénitale pour l'enfant.
- 2) Mettre des gants pour jardiner et bien se laver les mains ensuite.
- 3) prescrire UNE surveillance sérologique mensuelle pendant toute la durée de la grossesse
- 4) Ne pas consommer de crudités crus mal lavées ou de la viande saignante insuffisamment cuite.
- 5)Eviter tout contact direct avec un chat parasité car il constitue un facteur de risque principal d'acquisition de la toxoplasmose.

A: 1+2+3 B:2+3+4 C:3+4+5 D: 1+2+4 E:2+3+5 B

35- Chez les femmes enceintes qui s'infectent par *Toxoplasma gondii* pendant la grossesse, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte : (Cochez la réponse fausse)

- A) La toxoplasmose congénitale est grave en cas de contamination maternelle en début de grossesse
- B) Le risque de passage du parasite au fœtus est minimum en début de grossesse
- C) La gravité de l'atteinte fœtale augmente avec l'âge de la grossesse
- D) Le risque de passage du parasite au fœtus augmente avec l'âge de la grossesse
- C
- E) En cas de contamination maternelle tardive survenue au cours du troisième trimestre de la grossesse, la toxoplasmose congénitale est le plus souvent asymptomatique (infra clinique, latente)

36- La reprise évolutive (réactivation) d'une toxoplasmose latente peut se voir en cas: (Cochez la réponse Juste)

- A) D'une greffe de moelle osseuse à un receveur séropositif Pour la toxoplasmose en pré greffe
- B) D'un simple contact des mains avec de la viande crue Parasitée
- C) D'un contact avec la litière d'un chat parasité
- D) D'une hygiène insuffisante des mains après un contact avec du sol contenant des Oocystes sporulés
- E) D'une transplantation cardiaque provenant d'un donneur séropositif pour la toxoplasmose à un receveur séronégatif pour la toxoplasmose en pré greffe

E

37- Un accès palustre survenu chez un voyageur non immunisé ayant séjourné en zone d'endémie palustre, est évoqué devant toutes ces situations suivants sauf une, laquelle.

- A) Une fièvre au retour de zone d'endémie palustre
- B) Une Chimio prophylaxie antipaludique non adaptée au pays visite
- C) Une adénopathie
- D) La non prise de Chimio prophylaxie antipaludique
- E) Une thrombopénie précoce

C

38- À propos des cestodes parasites de l'homme, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte : (Cochez la réponse fausse)

- A) *Taenia saginata* est un ver nu responsable de téniasis et/ou de cysticercose
- B) *Taenia solium* est un ver armé qui peut être responsable de téniasis et/ou de cysticercose
- C) *Taenia saginata* est responsable d'une cestodose intestinale dont le diagnostic est assuré essentiellement par un scotch test anal « test de Graham » qui met en évidence des embryophores caractéristiques au niveau de la marge anale
- D) *Taenia saginata* est un ver solitaire dont la larve est « *Cysticercus bovis* »
- E) Les anneaux gravides sont éliminés passivement au moment de la défécation pour *taenia solium* et activement en dehors de la défécation pour *taenia saginata*

A

Parasitologie (2022)

1. Les dermatophytes : (R)

- A. Peuvent être responsables d'onyxis avec un périonyxis
- B. Peuvent être responsables de sycosis qui sont des atteintes des cheveux
- C. Sont responsables essentiellement des atteintes profondes
- D. Leur diagnostic est assuré par la recherche des anticorps spécifiques dans le sérum
- E. Sont responsables essentiellement des atteintes superficielles

E

Parasitologie (2021)

1 La cryptococcose est une mycose :

- 1 Opportuniste due à une levure encapsulée « *Cryptococcus neoformans* » se manifestant essentiellement par un syndrome dysentérique
- 2) Opportuniste due à une levure encapsulée « *Cryptococcus neoformans* » qui a un neurotropisme, se manifestant essentiellement par une atteinte neuro-méningée grave
- 3) Dont la recherche d'antigène circulant « glucuronoxylomannane » est plus rentable au diagnostic que celle des anticorps une levure encapsulée « *Cryptococcus neoformans* », se
- 4) Opportuniste due traduisant sur le plan biologique par une anémie hémolytique
- 5) Qui touche surtout les sujets infectés par le VIH ayant un taux de CD4 inférieur à 100 éléments / mm³

A(1.3.5). B(2.3.5). C(1.4.5). D(3.4.5) . E(1.2.3.4.5)

B

2. La pneumocystose humaine est une mycose opportuniste : (R)

- A. Qui se traduit essentiellement sur le plan clinique par un syndrome neuro-méningé grave
- B. Due à un champignon atypique spécifique à l'homme (*pneumocystis jirovecii*).
- C. Qui peut se traduire sur le plan clinique chez un adulte immunodéprimé par la triade classique associant: une fièvre, une toux sèche et une dyspnée d'intensité croissante.
- D) Dont la transmission interhumaine est possible .
- E) Qui touche essentiellement les sujets infectés par le VIH ayant un taux de CD4 inférieur à 200 éléments/mm³

A(1.2.5). B(1.3.4). C(1.4.5) D.(1.2.3.4.5) E.(2.3.4.5)

E

Parasitologie (2020)

1. Le diagnostic de *Tania saginata* se fait le plus souvent par : (RJ)

A) La présence d'œufs du parasite dans les selles

B) La présence d'œufs du parasite sur un scotch test La présence d'anneaux trouvés dans les selles

D) La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles

E) La vue du scolex du *tænia* D

2. La bilharziose *Schistosoma* urogénitale est une parasitose : (RF)

A) Anthropologique retrouvée en Algérie .

B) Due à *Schistosoma hæmatobium* .

C) Dont le diagnostic pendant la phase de migration larvaire repose sur la recherche des œufs à éperon terminal au niveau des urines .

D) Se traduit sur le plan clinique essentiellement par une hématurie .

E) Contractée par voie transcutanée active . C

3. La distomatose à *Fasciola hepatica* est une trématodose : (RJ)

A) Qui se manifeste cliniquement par une hépatite toxique - infectieuse au cours de la phase d'invasion

B) Contactée par voie transcutanée.

C) Caractérisée par une hyper éosinophilie sanguine évoluant en dents de scie

D) Dont le diagnostic est coproparasitologique pendant la phase d'invasion par la mise en évidence des œufs operculés au niveau des selles

E) Non retrouvée en Algérie . A

4. A propos des pédiculoses : (RF)

A) Sont des ectoparasitoses prurigineuses , contagieuses et cosmopolites B) La pédiculose de la tête touche surtout les enfants entraînant un prurit du cuir chevelu à prédominance rétro auriculaire et / ou occipitale

C) La phthiriose due au *Phthirus pubis* est une infection sexuellement transmissible .

D)La pédiculose corporelle due au *Pediculus capitis* touche essentiellement E sujets sans domicile fixe (SDF).

E) leur diagnostic est assuré par la mise en évidence directe de l'ectoparasite cause

D

5. Les parasitoses secondaires à une transmission transcutanée sont : (RF)

A)La distomatose

B) La nécatorose

C) L'ankylostomiase

D) L'anguillulose

E) La bilharziose A

Parasitologie (2019)

1. L'amébose intestinale aiguë : (Cocher la réponse fausse)

- A. Est due à *Entamoeba histolytica* type *histolytica*
- B. Se traduit sur le plan clinique par un syndrome dysentérique associant des empreintes , des ténésmes et des crachats rectaux glairo-sanglants
- C. Est constamment fébrile
- D. Est traitée par l'association d'un antiamibien diffusible (tissulaire) et un antiamibien de contact
- E. Est de diagnostic coproparasitologique par la mise en évidence du parasite au niveau des selles

C

2. La trichomonose à *Trichomonas vaginalis* : (Cocher la réponse fausse)

- A. Est une parasitose urogénitale cosmopolite
- B. Atteint exclusivement les femmes mariées et le traitement simultané du ou des partenaires sexuels est indispensable
- C. Est une anthroponose
- D. Est une maladie sexuellement transmissible
- E. Est due à un flagellé urogénital

B

3. *Plasmodium falciparum* est l'espèce plasmodiale : (Cocher la réponse exacte)

- A. Qui donne des hypnozoïtes
- B. Responsable de la fièvre tierce bénigne
- C. Transmise à la suite à une piqûre infectante de phlébotome femelle
- D. Responsable de la fièvre quarte
- E. La plus redoutable responsable du neuropaludisme

E

4. La contamination humaine par *Toxoplasma gondii* peut se faire par : (Cocher la réponse fausse)

- A. L'absorption de l'eau de boisson contenant des oocystes non sporulés
- B. L'ingestion de la viande crue ou mal cuite contenant des kystes
- C. Un passage trans-placentaire des tachyzoïtes
- D. L'ingestion des fruits et des légumes crus mal lavés contenant des oocystes sporulés
- E. La greffe d'organes parasités

A

5. La prophylaxie chez une gestante séronégative pour la toxoplasmose repose sur : (Cocher la réponse exacte)

- A. Un contrôle sérologique semestriel
- B. Une éviction du contact direct avec le chat
- C. Un lavage minutieux des crudités et une consommation de viande bien cuite
- D. Un traitement par la Spiramycine (Rovamycine®)
- E. Une chimio prophylaxie par Bactrim

C

6. La giardiose est une parasitose : (Cocher la réponse exacte)

- A. Strictement tropicale
- B. Due au un flagellé intestinal "*Giardia intestinalis*", touchant exclusivement les enf
- C. Qui n'entraîne jamais une atrophie villositaire
- D. Non retrouvée en Algérie
- E. Qui peut être responsable d'un retard staturo-pondéral chez l'enfant

E

7. L'oxyurose est une helminthes :(Cocher la réponse fausse)
- A. Cosmopolite Particulièrement fréquente chez les enfants
 - B. Qui peut être responsable d'une vulvite chez la fillette
 - C. Dont le diagnostic est fait essentiellement par un scotch test anal
 - D. Anthropozoonotique se manifestant essentiellement par un prurit anal nocturne
 - E. Contagieuse liée aux mains sales D

8. L'hydatidose est une parasitose : (Cocher la réponse exacte)
- A. Non retrouvée en Algérie
 - B. Dont la contamination humaine se fait par la consommation des viscères hydatiformes
 - C. Dont le diagnostic repose essentiellement sur la recherche de scolex et de crochets dans les liquides de ponction des kystes hydatiques
 - D. Qui fait intervenir le mouton comme un hôte définitif
 - E. Qui fait intervenir l'homme comme un hôte intermédiaire accidentel E

9. La schistosomiose urogénitale est une parasitose : (Cocher la réponse fausse)
- A. Anthroponotique due à un trématode du genre Schistosoma
 - B. Dont le diagnostic pendant la phase de migration larvaire repose sur la recherche des oeufs caractéristiques-au niveau des urines
 - C. Retrouvée en Algérie
 - D. Qui se traduit essentiellement sur le plan clinique par une hématurie
 - E. Contractée par voie transcutanée active B

10. La distomatose à Fasciola hepatica est une trématode : (Cocher la réponse exacte)
- A. Contactée par voie transcutanée
 - B. Caractérisée par une hyper éosinophilie sanguine évoluant en dents de scie
 - C. Dont le diagnostic est coproparasitologique pendant la phase d'invasion par la mise en évidence des œufs operculés au niveau des selles
 - D. Qui se manifeste cliniquement au cours de la phase d'invasion par une hépatite toxico-infectieuse
 - E. Non retrouvée en Algérie D

Parasitologie (2018)

1. L'amoebiose intestinale aiguë : (RF)
- A. Est due à Entamoeba histolytica type histolytica.
 - B. Se traduit par un syndrome dysentérique associant des épreintes, des ténésmes et des crachats rectaux glairo-sanglants.
 - C. Est constamment fébrile.
 - D. Est traitée par l'association d'un antiamibien diffusible et un antiamibien de contact.
 - E. Est diagnostiquée essentiellement par la recherche du parasite au niveau des selles, C
2. La trichomonose à trichomonas vaginalis : (RF)
- A. Est une parasitose urogénitale cosmopolite.
 - B. Atteint exclusivement les femmes mariées et le traitement simultané du ou des partenaires sexuels n'est pas indispensable.
 - C. Est une anthroponose.
 - D. Est une maladie sexuellement transmissible.
 - E. Est due à un flagellé urogénital. B

3. Plasmodium falciparum : (RJ)

- A. Est l'espèce la plus redoutable responsable du neuropaludisme.
- B. Est responsable de la fièvre tierce bénigne.
- C. Est responsable de la fièvre quarte,
- D. Est une espèce qui donne des hypnozoïtes
- E. Est transmis suite à une piqûre infectante de phlébotome femelle. A

4. La contamination humaine par Toxoplasma gondii peut se faire par : (RF)

- A. L'ingestion des fruits et légumes crus mal contenant des oocystes sporulés.
- B. Un passage trans-placentaire des tachyzoïtes.
- C. L'ingestion de la viande crue ou mal cuite contenant des kystes.
- D. La greffe d'organes parasité. E
- E. L'absorption de l'eau de boissons contenant des oocystes non sporulés.

5. La prophylaxie chez une gestante séronégative pour toxoplasmose repose sur : (RJ)

- A. Un contrôle sérologique hebdomadaire.
- B. Une éviction du contact direct avec le chat.
- C. Un lavage des crudités et une consommation de la viande bien cuite.
- D. Une chimio prophylaxie par le Bacirim.
- E. Un traitement par la Spiramycine (Rovamycine®). C

6. La giardiose : (RJ)

- A. Est une parasitose due au Giardia intestinalis touchant exclusivement les enfants.
- B. Est une parasitose strictement tropicale.
- C. Peut être responsable d'un retard staturo-pondéral chez l'enfant.
- D. N'entraîne jamais une atrophie villositaire.
- E. Est une parasitose non retrouvée en Algérie. C

7. L'oxyurose : (RF)

- A. Est une parasitose cosmopolite particulièrement fréquente chez les enfants.
- B. Est une anthropozoonose caractérisée par un prurit anal diurne.
- C. Peut être responsable de vulvite chez la fillette.
- D. Est diagnostiquée essentiellement par un scotch test anal.
- E. Est une maladie contagieuse liée aux mains sales. B

8. L'hydatidose est une parasitose : (RJ)

- A. Non retrouvée en Algérie.
- B. Dont la contamination humaine se fait par la consommation de viscères hydatifères.
- C. Dont l'homme est hôte intermédiaire accidentel.
- D. Dont le diagnostic se fait par la recherche de scolex et de crochets dans les liquides de ponction des kystes hydatiques.
- E. Dont le mouton est l'hôte définitif. C

9. La bilharziose urogénitale est une parasitose : (RF)

- A. Anthroponotique due à un parasite du genre Schistosoma.
- B. Retrouvée en Algérie.
- C. Dont le diagnostic pendant la phase de migration larvaire repose sur la recherche des œufs caractéristiques au niveau des urines.
- D. Dont la clinique se manifeste essentiellement par une hématurie.
- E. Contractée par voie transcutanée. C

10. La distomatose à *Fasciola hepatica* : (RJ)

- A. Se manifeste par une hépatite toxi-infectieuse au cours de la phase d'invasion.
- B. Est contractée par voie transcutanée.
- C. Est caractérisée par une hyperéosinophilie sanguine évoluant en dents de scie.
- D. Est diagnostiquée à la phase d'invasion par la mise en évidence des œufs caractéristiques au niveau des selles.
- E. Est une parasitose non retrouvée en Algérie.

A

Parasitologie (2017)

1/ Au cours du taeniasis à *Taenia saginata* : (1RJ)

- a- Le parasite effectue une migration sanguine avant de s'installer dans l'intestin grêle
- b- Le diagnostic repose sur la découverte des anneaux du parasite dans les selles du malade
- c- La parasitologie des selles est fortement indiquée
- d- Le praziquantel agit sur le ver adulte uniquement
- e- La contamination de l'homme se fait par le biais des œufs

C

2/ Parmi les signes cliniques de l'oxyurose : (1RJ)

- a- L'urticaire
- b- Le prurit anal nocturne
- c- Les vomissements en jet
- d- Douleurs abdominales diffuses
- e- Fièvre en plateau

B

3/ En Algérie la schistosomiase se distingue par : (1RJ)

- a- L'agent pathogène est *Schistosoma intercalatum*
- b- La contamination de l'homme se fait strictement par voie transcutanée
- c- L'hôte intermédiaire est une plante aquatique
- d- Le granulome bilharzien correspond au dépôt important des larves libérées
- e- Le traitement repose sur le Niclosamide

C

4/ Au cours du diagnostic de certitude de la schistosomiase urinaire on demande au malade d'uriner après effort pour : (1RJ)

- Éliminer les cristaux d'oxalates urinaires
- Détacher les éperons de la vessie
- Récolter une meilleure diurèse
- d- Activer la libération des larves

- e- Toutes les propositions sont incorrectes

B

5/ La transmission de l'échinococcose hydatique vers l'homme se fait par : (1RJ)

- a- Le biais des mains contaminées par les œufs du parasite
- b- L'ingestion de la larve invaginée dans la viande mal cuite
- c- L'ingestion du miracidium
- d- Le contact avec le chien parasite
- e- L'ingestion des viscères contaminés du mouton

D

6/ La fasciolose en Algérie est caractérisée par ce qui suit : (1RJ)

- a- *Limnea truncatula* est l'hôte intermédiaire
- b- L'homme se contamine par l'ingestion du miracidium
- c- Le diagnostic de certitude repose sur la sérologie
- d- L'hyperéosinophilie en dents de scie est évocatrice
- e- Le traitement est le Bactrim fort

A

7/ Parmi les aspects cliniques des candidoses vous connaissez (1RJ)

- a- Le muguet
- b- La chylite
- c- Le Favus
- d- Le kerion de Celse
- e- Les teignes microsporiques A

8/ Parmi les mycoses opportunistes au cours du SIDA on connaît: (1RJ)

- a- L'aspergillose
- b- La cryptococcose
- c- La scabiose
- d- La trypanosomiase
- e- La dracunculose B

9/ L'onyxis à Candida sp est décrit comme suit (1RJ)

- a- Une atteinte de la partie proximale de l'ongle accompagnée d'une inflammation du pourtour
- b- Une décoloration de l'ongle avec un épaissement de son pourtour
- c- Un décollement du lit de l'ongle associé à une hyperkératose
- d- Une atteinte des ongles palmaires exclusive avec du pus A
- e- Une décoloration progressive de l'ongle avec atteinte de la partie distale en premier

10/ L'Oxyurose est une parasitose hautement contagieuse car (1RJ)

- a- Les oeufs sont embryonnés à la ponte
- b- Le parasite effectue une migration extra intestinale avec une libération massive des oeufs
- c- Les adultes sont vivipares, et libèrent les larves dans l'intestin grêle
- d- La transmission du parasite se fait par le biais des mains contaminées par les larves
- e- La recherche des anticorps spécifiques est très utile A

Parasitologie (2016)

1. Au cours de L'amibiennose: (1RJ)

- a- L'invasion tissulaire des amibes est à l'origine de la pseudotumeur touche particulièrement le foie
- b- La sérologie parasitaire est positive
- c- La biopsie tissulaire confirme le diagnostic par l'observation des kystes amibiens.
- d- La fièvre et la diarrhée chronique orientent le diagnostic A

2. Les amibes libres: (1RJ)

- a- Se retrouvent particulièrement chez les immunodéprimés.
- b- Sont dues à Naegleria acanthamoeba sp
- c- Seul le genre Acanthamoeba sp est thermophile.
- d- Le traitement repose sur l'injection de pentamidine.
- e- Toutes les propositions sont incorrectes. B

3. Au cours du traitement de la leishmaniose viscérale: (1RJ)

- a- Le Glucantime reste le traitement de choix dans les zones endémiques.
- b- L'Amphotéricine B n'est pas préconisée en cas de résistance aux dérivés antimonies.
- c- Le même schéma thérapeutique est appliqué pour la leishmaniose cutanée
- d- Chez l'immunodéprimé particulièrement le traitement repose sur la Rovamycine
- e- L'immunodéprimé le traitement par l'Amphotéricine B est inefficace. A

4. Devant une suspicion de Paludisme vous demandez: (1RJ)

a-Un frottis de moelle osseuse.

b-Un frottis sanguin à la recherche des espèces plasmodiales et une goutte épaisse.

c-Une recherche sérologique d'antigène spécifique

d-Une biopsie tissulaire à la recherche des parasites.

E-Une hémoculture

B

5. L'onyxis à Candida sp est décrit comme suit:(1RJ)

a-Une atteinte de la partie proximale de l'ongle accompagnée d'une inflammation du pourtour

b-Une décoloration de l'ongle avec un épaississement de son pourtour.

c-Un décollement du lit de l'ongle associe à une hyperkératose.

d-Une atteinte des ongles palmaires exclusive avec du pus.

E-Une leuconychie isolée

A

6. L'alopécie observée au cours des teignes est due à : (1RJ)

a-L'invasion des spores fongiques du follicule pileux.

b-L'extension centrifuge des dermatophytes.

c-La pénétration des levures l'ostium folliculaire

d-La pénétration des filaments mycéliens des squames vers les poils.

E-L'invasion des arthrospores le follicule pileux.

AC

7.L'image en Halo c'est: (1RJ)

a-La pénétration alvéolaire des spores

b-L'image en TDM de l'hémorragie pulmonaire locale associée à la pénétration des filaments

c-La truffe aspergillaire

d-Le croissant gazeux de l'aspergilome

e-L'image radiologique de la vessie calcifiée par la schistosomiase

B

8. Le diagnostic du pityriasis versicolor (1RJ)

a-Repose sur le scotch-test cutané

b-Est confirmé par la mise en évidence de spores fongiques groupées en grappe de raisin

c-N'est possible que par la sérologie

d-La culture reste le seul moyen du diagnostic

e-Les propositions A et B sont justes

E

9. Au cours des mycoses profondes :(1RJ)

a-La fièvre persiste et ne cède pas aux antibiotiques

b-Les levures sont les agents pathogènes les plus rencontrés

c-Le traitement repose le plus sur Amphotericine B mais aussi l'echinocandine et Le voriconazole, selon le cas

d-La culture mycologique du liquide biologique est utile

e-Toutes ces propositions sont justes

E

10. La pneumocystose: (1RJ)

- A- Est une pneumopathie interstitielle qui se manifeste par une fièvre, une toux sèche et une dyspnée d'intensité croissante
- b- L'agent pathogène est un champignon recherché dans le LBA par culture uniquement
- c- Sa prise en charge ne nécessite pas l'isolement des malades des sujets réceptifs.
- d- Est due à une réactivation d'un foyer pulmonaire latent lors d'une immunodépression
- e- Pneumocystis quilliermondi est l'agent responsable

A

Parasitologie (2015)

1. L'amibiase (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Est une anthroponose liée au péril fécal
- b- Peut être contactée par voie vénérienne
- c- Se caractérise par un ictère franc
- d- Le traitement est efficace en dose unique sur une seule journée
- e- Toutes les propositions sont fausses

AE

2. Au cours du diagnostic de la leishmaniose viscérale, le prélèvement se fait au niveau : (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Des ganglions
- b- De la moelle osseuse
- c- De la rate
- d- Du foie
- e- Toutes les réponses sont fausses

ABCDE

3. Trichomonas vaginalis: (Cocher la réponse EXACTE)

- a. Est un protozoaire appartenant à la classe des rhizopodes
- b. Se présente sous forme kystique et végétative
- c. Se présente sous forme végétative uniquement
- d. Fréquent chez les sujets présentant un déficit immunitaire.
- e. Se traite facilement par un traitement local de fluvermal

C

4. Au cours du paludisme : (Cocher la réponse EXACTE)

- a. La fièvre tierce maligne est due à une coagulation des globules rouges parasités
- b. La fièvre tierce bénigne traduit la libération des parasites des hypnozoïtes
- c. La fièvre tierce maligne est due à Plasmodium vivax
- d. L'éclatement des schizontes est à l'origine de la fièvre bénigne
- e. La phase intra hépatique du cycle parasitaire de Plasmodium entraîne des signes cliniques et biologiques hépatiques

D

5. Dans le kyste hydatique : (Cocher la réponse EXACTE)

- a. Le diagnostic est basé sur la mise en évidence directe du parasite par ponction du kyste hydatique à visée diagnostique
- b. Le diagnostic est basé sur la sérologie par la recherche d'anticorps spécifiques
- c. L'homme se contamine en ingérant de la viande contenant de la larve hydatique
- d. Le traitement est essentiellement médical
- e. Toutes les réponses sont justes

B

6. Au cours du diagnostic parasitologique de la schistosomiase urinaire on demande au malade d'uriner après effort pour: (Cocher la réponse EXACTE)

- a. Eliminer les cristaux d'oxalates urinaires
- b. Détacher les éperons de la vessie
- c. Une sédimentation améliorée des hématies
- d. Pour activer la libération des larves
- e. Toutes les propositions sont justes B

7. La perlèche se caractérise par : (Cocher la réponse EXACTE)

- a. La présence de lésions buccales douloureuses en extension vers le palais et la face interne de la joue
- b. La présence de lésions érythémateuse dues à des champignons filamenteux
- c. La présence de levures d'aspect blanchâtre observé sur la langue
- d. Une fissuration des commissures labiales
- e. Une coloration noirâtre de la langue D

8. L'image en halo est observée au cours de: (Cocher la réponse EXACTE)

- a. L'aspergillose invasive.
- b. L'aspergillome
- c. L'aspergillose broncho-pulmonaire invasive
- d. La sporotrichose
- e. L'hydatidose pulmonaire C

9. Le favus est une teigne du cuir chevelu dont l'agent pathogène appartient au genre: (Cocher la réponse EXACTE)

- a. Trichophyton
- b. Microsporum
- c. Trichosporon
- d. Epidermophyton
- e. Mycétome D

10. Le traitement curatif de la pneumocystose repose sur : (Cocher la réponse EXACTE)

- a-Fluconazole
- b-Albendazole
- c-Bactrim
- d-Voriconazole
- e-Flagyl C

11. L'aspergillose pulmonaire invasive est retrouvée chez les : (Cocher la réponse EXACTE)

- a. Diabétiques
- b. Neutropéniques
- c. Nourissons
- d. Vieillards
- e. Toutes les réponses sont justes BE

12. Au cours des candidoses: (Cocher la réponse EXACTE)

- a. La perlèche est fréquente chez les grands fumeurs
- b. Le diagnostic de certitude des candidoses superficielles repose sur la sérologie
- c. L'examen direct permet de mettre en évidence les spores en grappe de raisin
- d. Le muguet est fréquent chez les nourrissons
- e. Toutes les réponses sont fausses

D

13. Dans la cryptococcose l'examen direct permet de mettre en évidence: (Cocher la réponse EXACTE)

- a. De nombreuses levures associés éventuellement à du pseudomycelium
- b. Des levures encapsulées après test à l'encre de Chines
- c. Des levures en cigare
- d. Des filaments mycéliens siphonnés
- e. Des arthrospores

B

14. L'agent pathogène du pityriasis versicolor (Cocher la réponse juste) :

- a. Candida albicans
- b. Trichophyton mentagrophytes
- c. Actinomadura
- d. Malassezia Sp
- e. Sporothrix Schenckii

D

Pharmaco
Pharmacologie (octobre 2024)

1. de la nicotine à forte dose au niveau de la jonction neuromusculaire a pour effet :
(Cocher la réponse juste)
- A. Un blocage passif des sites récepteurs cholinergiques pré-synaptiques
 - B. L'activation de la synthèse de neurotransmetteurs par apport accru de précurseurs
 - C. Une dépolarisation permanente de la membrane post-synaptique
 - D. Une libération accrue de neurotransmetteurs, d'où une dépolarisation plus importante
 - E. Une augmentation de l'entrée de Ca^{++} et donc la libération de beaucoup de transmetteurs
- C
2. L'intoxication par l'Amanita Muscaria donne les signes suivants sauf un. Indiquer lequel :
- A. Le myosis
 - B. La diarrhée
 - C. Les nausées et vomissements
 - D. La sudation
 - E. L'hyperkaliémie
- E
3. Les effets indésirables des médicaments de type A : (Cocher la réponse juste)
- A. Sont rares mais mortels
 - B. Sont dose-dépendants
 - C. Nécessitent l'arrêt définitif du médicament chez le patient
 - D. Ne sont pas détectés dans les essais pré cliniques et cliniques
 - E. Surviennent après une prise chronique du médicament
- B
4. Les myorelaxants curarisants sont indiqués dans les situations suivantes sauf une. Indiquez laquelle :
- A. Les interventions chirurgicales pour éviter une anesthésie trop profonde
 - B. L'intubation endotrachéale
 - C. L'ulcère gastrique
 - D. Le traitement du tétanos
 - E. Chez les patients en ventilation artificielle contrôlée.
- C

Pharmacologie (2022)

1. Le phénomène de redistribution : (RJ)
- A. Intéresse les substances hydrosolubles
 - B. Est égal au rapport de la quantité administrée sur la concentration plasmatique
 - C. Peut conduire à une baisse de l'effet du médicament
 - D. Aucun médicament n'échappe à cet effet
 - E. Correspond à l'élimination totale d'un médicament après métabolisme hépatique
- C
2. Les substances qui peuvent traverser les membranes cellulaires doivent-être : (RJ)
- A. Hydrosolubles et ionisées
 - B. Liposolubles et non ionisées
 - C. Liposolubles
 - D. Ionisées
 - E. Toutes ces propositions sont fausses
- B

3. Une des réactions suivantes fait partie des réactions de métabolisme de phase deux (II) : (RJ)

- A. L'hydrolyse
- B. L'acétylation
- C. Décarboxylation
- D. La réduction
- E. L'oxydation B

4. L'Apnée respiratoire sous succinylcholine résulte d'un déficit enzymatique : (RJ)

- A. Hémoglobine réductase
- B. Choline Transférase
- C. Glucose-6-phosphate déshydrogénase
- D. Cholinestérase
- E. N.Acétyl-transférase hépatique D

Pharmacologie (2021)

1. Dans la dépendance physique aux médicaments , le malade présente : (RJ)

- A) Un syndrome de sevrage en cas d'arrêt du médicament ,
- B) Une sensation de bien - être sans augmenter les doses
- C) Une bonne condition physique
- D) Une dépendance psychique uniquement
- E) De bonnes relations avec son entourage A

2. Les médicaments sympatholytiques sont indiqués dans les pathologies suivantes sauf une . Dites laquelle : (RJ)

- A) Hypertension artérielle
- B) Cardiopathies ischémiques
- C)Phéochromocytome
- D)Glaucome
- E)Choc anaphylactique E

3. La myorelaxation pharmacologique curarisante est indiquée pour :

- A) Permettre un acte opératoire
- B) Faciliter l'intubation endotrachéale
- C) Diminuer les convulsions lors d'un électrochoc
- D) Bloquer la transmission au niveau de la jonction neuromusculaire
- E)Traiter les contractures lors d'affections ostéo - articulaires E

4. Un des médicaments suivants n'est pas un inducteur enzymatique : (RJ)

- A) Rifampicine
- B) Phénobarbital
- C) Griséofulvine
- D) Tolbutamide
- E) Phénylbutazone . D

Pharmacologie (2020)

1. Les effets indésirables des médicaments de type A : (RJ)

A) Sont dose dépendants

B) Sont rares mais mortels

C) Nécessitent l'arrêt définitif du médicament chez le patient

D) Ne sont pas détectés dans les essais pré cliniques et cliniques .

E) Surviennent après une prise chronique du médicament .

A

2. L'intoxication par l'Amanita Muscaria donne les signes suivants , sau lequel ? : (RJ)

A) La mydriase

B) Le myosis

C) La diarrhée

D) Les nausées et vomissements

E) La sudation

A

3, Les myorelaxants curarisants sont indiqués dans les ((situations)). sauf une , laquelle ? : (RJ)

A) Les crises d'asthme

B) Les interventions chirurgicales pour éviter une anesthésie trop profonde

C) L'intubation endotrachéale

D) Le traitement du tétanos

E) Chez les patients en ventilation artificielle contrôlée .

A

Pharmacologie (2019)

1. L'activation du système parasympathique donne l'un des effets suivants.(Cocher la réponse exacte)

A. Une mydriase

B. Une augmentation des sécrétions digestives

C. Un relâchement des parois digestives et une contraction des sphincters

D. Une rétention d'urines

E. Une accélération du rythme cardiaque

B

2. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?

A. Le salbutamol est un antagoniste des récepteurs Bêta 2 utilisé dans la crise d'asthme

B. L'isoprénaline est utilisée dans les troubles de conduction cardiaque sévères.

C. La pseudoéphédrine est souvent présente dans les médicaments pour le rhume pour son effet décongestionnant nasal.

D. Les amphétamines stimulent la vigilance et diminuent le besoin de sommeil et l'appétit

E. Les amphétamines sont des stupéfiants souvent utilisés dans le dopage.

A

3. La dépendance psychique se manifeste par : (Cocher la réponse exacte)

A. Une Tendance Parfois À Augmenter Les Doses

B. Une Tendance À Ne Pas Augmenter Les Doses

C. Une détérioration physique de la personne

D. Des problèmes judiciaires

E. Aucune réponse n'est juste

A

4. Un des effets indésirables suivants est imprévisible, lequel ?
- A. Une hypoglycémie sous insuline
 - B. Un choc anaphylactique sous pénicillines des corticoïdes
 - C. Une insuffisance surrénalienne à l'arrêt brutal
 - D. Une bradycardie sous bêta bloquants
 - E. Une Chute de la pression artérielle sous antihypertenseurs B
5. Les effets indésirables des médicaments de type B : (Cocher la réponse exacte)
- A. Sont dose dépendants
 - B. Sont fréquents mortels
 - C. Sont rares mais dans les essais précliniques et cliniques
 - D. Sont toujours détectés
 - E. Surviennent après une prise chronique du médicament C
6. Les effets indésirables médicamenteux : (Cocher la réponse exacte)
- A. Sont voulus
 - B. Sont tous évitables
 - C. Sont pour la plupart immunoallergiques
 - D. Sont tous déclarés à la pharmacovigilance
 - E. Toutes ces réponses sont fausses E
7. Le diazépam: (Cocher la réponse fausse)
- A. Est un myorelaxant non curarisant
 - B. Est indiqué dans les convulsions
 - C. Agit au niveau des récepteurs GABA de type B
 - D. Est connu pour ses propriétés anxiolytiques, sédatives et antiépileptiques
 - E. Est indiqué dans le traitement du delirium tremens C

Pharmacologie (2018)

1. Les médicaments sympatholytiques sont indiqués dans les pathologies suivantes : (RF)
- A. Hypertension artérielle,
 - B. Cardiopathies ischémiques,
 - C. Pheochromocytome.
 - D. Glaucome. E
 - E. Choc anaphylactique.
2. Quel est parmi les médicaments suivants celui qui a une sélectivité beta1:(RJ)
- A. Nadolol.
 - B. Metoprolol,
 - C. Timolol.
 - D. Propranolol,
 - E. Pindolol. B
3. La biodisponibilité d'un médicament dépend des facteurs suivants : (RF)
- A. Premier passage hépatique.
 - B. Dose administrée.
 - C. La voie d'administration.
 - D. Masse lipidique corporelle.
 - E. La motricité gastro-intestinale. D

4. Les parasympholytiques ont les effets suivants : (RF)
- A. Mydriase.
 - B. Bronchodilatation.
 - C. Bouche sèche.
 - D. Encombrement bronchique.
 - E. Tachycardie. D
5. La guanéthidine et l'adrénaline interagissent par une interaction de type : (RJ)
- A. Antagonisme non compétitif.
 - B. Antagonisme compétitif.
 - C. Potentialisation.
 - D. Effet additif.
 - E. Aucune de ces propositions n'est juste. C
6. En pharmacocinétique, le terme compartiment : (RJ)
- A. Désigne nécessairement le volume extracellulaire dans lequel se distribue le médicament.
 - B. Désigne le lieu d'action du médicament.
 - C. Désigne la surface corporelle.
 - D. Est un concept permettant de mieux simuler le devenir des médicaments.
 - E. Désigne l'étendue de la d'absorption des médicaments. D
7. La myorelaxation pharmacologique curarisante est indiquée pour : (RF)
- A. Permettre un acte opératoire.
 - B. Faciliter l'intubation endotrachéale.
 - C. Diminuer les convulsions lors d'un électrochoc.
 - D. Bloquer la transmission au niveau de la jonction neuromusculaire.
 - E. Traiter les contractures lors d'affections ostéo-articulaires. E
8. Un des médicaments suivants n'est pas inducteur enzymatique : (RJ)
- A. Rifampicine.
 - B. Phénobarbital.
 - C. Griseofulvine.
 - D. Tolbutamide.
 - E. Phénylbutazone. D
9. Une des réactions suivantes fait partie des réactions de métabolisme de phase deux (II) : (RJ)
- A. Hydrolyse.
 - B. Acétylation.
 - C. Décarboxylation.
 - D. Réduction.
 - E. Oxydation. B
10. Les curarisants ont les effets autonomes suivants : (RJ)
- A. Gallamine bloque les ganglions autonomes avec libération légère d'histamine.
 - B. Tubocurarine bloque les ganglions autonomes avec libération modérée d'histamine.
 - C. Pancuronium stimule les récepteurs muscariniques cardiaques.
 - D. Vécuronium bloque les ganglions autonomes sans libération d'histamine.
 - E. Atracurium libère de l'histamine et bloque les ganglions autonomes. B

Pharmacologie (2017)

1/ L'administration par voie parentérale implique les qualités suivantes des solutés injectables, sauf une, laquelle ?

- a- Stérilité
- b- Limpidité
- c- Apyrogénicité
- d- Liposolubilité avec PH voisin de la neutralité
- e- Isotonicité avec le plasma

D

2/ Les propositions suivantes peuvent être des causes d'effets secondaires des médicaments, sauf une, laquelle ?

- a- Le surdosage
- b- La thérapeutique inadaptée
- c- La polythérapie
- d- La présentation pharmaceutique des médicaments
- e- Certain déficit enzymatique

D

3/ Les interactions médicamenteuses de type pharmacocinétique s'expliquent par les propositions suivantes sauf une, laquelle ?

- a- Les modifications du PH gastrique
- b- Le coefficient de partage lipide/eau
- c- La compétition pour la liaison aux protéines plasmatiques
- d- La compétition pour la sécrétion tubulaire active
- e- Les modifications du PH urinaire

D

4/ La myorelaxation pharmacologique curarisante est indiquée dans les cas suivants sauf un, lequel ?

- a- Permettre un acte opératoire
- b- Faciliter l'intubation endotrachéale
- c- Diminuer les convulsions lors d'un électrochoc
- d- Faciliter la transmission au niveau de la jonction neuromusculaire
- e- Traiter les contractions musculaires non pathologiques

D

5/ La plus longue durée de cycloplégie est obtenue sous : (1RJ)

- a- Homatropine
- b- Scopolamine
- c- Atropine
- d- Cyclopentolate
- e- Tropicamide

C

6/ Dans les contractures à point de départ douloureux, on peut utiliser : (1RF)

- a- Diazepam
- b- Tubocurarine
- c- Baclofène
- d- Dantrolène
- e- Propositions a, c et d

B

7/ Les parasympathomimétiques indirectes ont les effets suivants sauf un, lequel?

- a- Contraction du muscle ciliaire, contraction du détrusor avec vasodilatation
- b- Contraction du muscle bronchique et sécrétion des glandes bronchiques
- c- Contraction du trigone, érection et arrêt vagal
- d- Contraction du muscle sphinctérien de l'iris avec sécrétion glandulaire
- e- Bloc auriculo-ventriculaire avec vasodilatation des vaisseaux sanguins C

8/ Les effets pharmacologiques des anticholinestérasiques sont marqués aux niveaux des organes suivants sauf un, lequel?

- a- Oculaire
- b- Cardio-vasculaire
- c- Gastro-intestinal
- d- Muscle squelettique
- e- Glandes endocrines D

9/ Les substances acides sont :

- a- Plus ionisées en milieu acide
- b- Moins ionisées en milieu basique
- c- Ionisées en milieu acide
- d- ionisées en milieu basiques
- e- Plus ionisées en milieu acide qu'en milieu basique D

10/ Le complexe Acétylcholine-récepteur est stabilisé par la liaison de Van Der Waals grâce à : (1RJ)

- a- L'ammonium quaternaire
- b- La chaîne linéaire à deux carbones
- c- La fonction ester
- d- Le groupe carboxyl
- e- Aucune de ces fonctions E

Pharmacologie (2016)

1. Un volume de distribution grand signifie que: (1RJ)

- A- La concentration plasmatique du médicament est petite
- B- La concentration tissulaire de ce médicament est petite
- C- La concentration plasmatique de ce médicament est grande
- D- La concentration plasmatique du médicament est égale à la dose administrée
- E- Toutes ces propositions sont fausses A

2. Une des réactions suivantes est sous contrôle génétique. Dites laquelle.

- A- L'hydroxylation
- B- L'acétylation
- C- La réduction
- D- La décarboxylation B
- E- La conjugaison

3. Dans l'antagonisme compétitif, la courbe de l'agoniste: (1RJ)

- A- Est divergente avec le même effet maximal
- B- Est parallèle avec le même effet maximal
- C- Est déplacée à gauche avec une baisse de l'effet maximal
- D- Est déplacée à droite avec le même effet maximal D
- E- Est divergente avec baisse de l'effet maximal

4. Le volume apparent de distribution des médicaments: (1RF)
- A-Est un volume virtuel
 - B-Est proportionnel a la quantité administrée
 - C-Peut-être plus grand que le volume de l'organisme
 - D-Peut-être plus petit que le volume de l'organisme E
 - E- Est inversement proportionnel à la quantité administrée
- 5 Las parasympathomimétiques sont indiqués dans les situations suivantes, sauf une. Laquelle ?
- A-Glaucome a angle ouvert
 - B-pleus paralytique
 - C-Myasthénie
 - D-Maladie de parkinson D
 - E- Aucune de ces propositions n'est juste
6. Un des médicaments suivants n'est pas inducteur enzymatique. Lequel?
- A-Rifampicine
 - B-Phenobarbital
 - C-Griseofulvine
 - D-Tolbutamide D
 - E- Phenylbutazone
7. Les curarisants ont les effets autonomes suivants :(1RJ)
- A-Gallamine bloque les ganglions autonomes avec libération légère d'histamine
 - B-Tubocurarine bloque les ganglions autonomes avec libération modérée d'histamine
 - C-Pancuronium stimule les récepteurs muscariniques cardiaques
 - D-Vecuronium bloque les ganglions autonomes sans libération d'histamine
 - B
 - E- Atracurium libère de l'histamine et bloque les ganglions autonomes
8. L'anémie hémolytique sous chloramphénicol est due à un déficit enzymatique en:
- A-Hemoglobine réductase
 - B-Cholinetransferase
 - C-Glucose 6 phosphodéshydrogenase
 - D-Cholinesterase C
 - E- N Acetyl-transferase hépatique
10. Une proposition est fausse concernant la Phenylephrine. Laquelle?
- A-Stimule directement le récepteur alpha
 - B-Ce n'est pas un dérivé catecholamine
 - C-Elle est inactivée par la catéchol-o-méthyl-transferase
 - D-C'est une substance mydriatique efficace C
 - E- C'est un médicament élévateur de la pression artérielle
11. La plus courte durée de mydriase est obtenue sous: (1RJ)
- A-Atropine
 - B-Scopolamine
 - C-Homatropine
 - D-Cyclopentolate E
 - E- Tropicamide

Pharmacologie (2015)

1. Une des réactions suivantes ne fait pas partie des réactions de métabolisme de phase (1). Laquelle ?
A-Hydrolyse
B-Acétylation
C-Décarboxylation
D-Réduction
E-Oxydation B
2. Le médicament qui réunit en même temps des effets stabilisant de membrane et une double affinité pour les récepteurs bêta 1 et bêta 2 est: (Cocher la réponse EXACTE)
A-Acébutolol
B-Métoprolol
C-Aténolol
D-Propranolol
E-Nadolol D
3. En pharmacocinétique, le terme compartiment: (Cocher la réponse EXACTE)
A-Désigne nécessairement le volume extracellulaire dans lequel se distribue le médicament
B-Désigne le lieu d'action du médicament
C-Désigne la surface corporelle
D-Est un concept permettant de mieux simuler le devenir des médicaments
E-Désigne l'étendue de la surface d'absorption des médicaments. D
4. Les substances qui peuvent traverser les membranes cellulaires doivent être : (Cocher la réponse EXACTE)
A-Hydrosolubles et ionisées
B-Liposolubles et non ionisées
C-Liposolubles et ionisées
D-Hydrosoluble et non ionisées
E-Toutes ces propositions sont fausses B
5. la myorelaxation pharmacologique curarisante, est indiquée pour: (Cocher la réponse INEXACTE)
A-Permettre un acte opératoire
B-Faciliter l'intubation endotrachiale
C-Diminuer les convulsions lors d'un électrochoc
D-Bloquer la transmission au niveau de la jonction neuromusculaire
E-Traiter les contractures lors d'affections ostéo-articulaires E
6. Un des médicaments suivants n'est pas inducteur enzymatique. Lequel ?
A-Rifampicine
B-Phénobarbital
C-Griseofulvine
D-Tolbutamide
E-Phenylbutazone D

7. Les curarisants ont les effets autonomes suivants : (Cocher la réponse EXACTE)
- A-Gallamine bloque les ganglions autonomes avec libération légère d'histamine
 - B-Tubocurarine bloque les ganglions autonomes avec libération modérée d'histamine
 - C-Pancuronium stimule les récepteurs muscariniques cardiaques
 - D-Vécuronium bloque les ganglions autonomes sans libération d'histamine
 - E-Atracurium libère de l'histamine et bloque les ganglions autonomes BD
8. La biodisponibilité d'un médicament dépend des facteurs suivants sauf un. Lequel?
- A-Premier passage hépatique
 - B-Dose administrée
 - C-La voie d'administration
 - D-Masse lipidique corporelle
 - E-La motricité gastro-intestinale D
9. Quel est parmi ces médicaments celui qui a une activité agoniste partielle: (Cocher la réponse EXACTE)
- A-Aténolol
 - B-Métoprolol
 - C-Acébutolol
 - D-Propranolol
 - E-Timolol C
10. Une proposition est fausse concernant la Phényléphrine. Laquelle ?
- A-Stimule directement le récepteur alpha
 - B-Ce n'est pas un dérivé catécholamine
 - C-Elle est inactivée par la catéchol-o-méthyl-transferase
 - D-C'est une substance mydriatique efficace C
 - E-C'est un médicament élévateur de la pression artérielle
11. La plus courte durée de mydriase est obtenue sous : (Cocher la réponse EXACTE)
- A-Atropine
 - B-Scopolamine
 - C-Homatropine
 - D-Cyclopentolate E
 - E-Tropicamide
12. La plus longue durée de cycloplégie est obtenue sous : (Cocher la réponse EXACTE)
- A-Atropine
 - B-Scopolamine
 - C-Homatropine
 - D-Cyclopentolate AE
 - E-Tropicamide
13. L'apnée respiratoire sous succinylcholine résulte d'un déficit enzymatique en: (Cocher la réponse EXACTE)
- A-Hémoglobine réductase
 - B-Cholinestérase
 - C-Glucose 6 phosphodéshydrogenase AD
 - D-Cholinestérase
 - E-N.Acétyl-transferase hépatique

14. La polynévrite sous isoniazide est due à un déficit enzymatique en: (Cocher la réponse EXACTE)

A-Hémoglobine réductase

B-Cholinetransférase

C-Clucose 6 phosphodéshydrogénase

D-Cholinesterase

E- N.Acetyl-transférase hépatique

E

1. Le diagnostic de certitude de l'intoxication au CO repose sur : (une réponse juste)

- A. Une augmentation des taux de créatine kinase
- B. Un taux de carboxyhémoglobine artériel > 5% chez les non-fumeurs
- C. Une acidose lactique
- D. Le scanner cérébral
- E. L'IRM cérébral

B

2. Un patient recevant 03 litres d'oxygène par voie nasale présente la gazométrie suivante : (Cocher la réponse juste)

Ph = 7.09

HCO₃⁻ = 08 mEq/l

Pa o₂ = 98 mmHg

PaCO₂ = 15 mmHG

Excès de bases = -12

C

3. Parmi les propositions suivantes indiquez celle qui correspond au profil gazométrique du patient :

- A. Alcalose respiratoire
- B. Acidose respiratoire aiguë
- C. Acidose métabolique
- D. Alcalose métabolique
- E. Acidose respiratoire chronique

C

4. Une rétention proportionnée d'eau et du sodium est à l'origine d'une : (Cochez la réponse juste)

- A. Hyperhydratation extracellulaire
- B. Hyperhydratation globale
- C. Hyperhydratation intracellulaire
- D. Déshydratation extracellulaire
- E. Aucune de ces réponses

A

5. Le choc hypovolémique (relatif) distributif est caractérisé par : (Cochez la ou les réponses justes)

Une altération de la redistribution des débits régionaux

Une augmentation de l'extraction tissulaire en oxygène.

Une augmentation de la perméabilité capillaire

Une vasodilatation périphérique

Responsable d'une hypovolémie

A : 1+2 B : 2+3 C : 1+4 D : 2+5 E : 4+5 E

PhysioPath (2022)

1. Le réflexe myotatique inverse : (RJ)

- A. Est un réflexe monosynaptique
- B. Se traduit par une extension de la jambe sur la cuisse
- C. Est mis en oeuvre par la simulation au bord externe de la plante du pied
- D. Sollicite les récepteurs tendineux de Golgi
- E. Est accompagné par un écartement en éventail des gros orteils

D

2. L'incoordination motrice avec tremblement, dysmétrie et hypermétrie caractérisent : (RJ)

- A. Les lésions du spinocervelet
- B. Les lésions du cervelet médian
- C. Le syndrome paravermien
- D. L'atteinte de la boucle dentato-rubro-olivo cérébelleuse
- E. Les lésions du néocervelet

C

3. La lésion des noyaux sous-thalamiques se traduit par : (RJ)

- A. Une akinésie
- B. Des mouvements brusques du gesticulations (hémiballisme)
- C. Des mouvements rapides, continus et incontrôlables
- D. Une impossibilité de maintenir la posture
- E. Un tremblement intentionnel

B

4. Un choc hypovolémique peut être dû à : (RF)

- A. Un syndrome néphrotique
- B. Un hémithorax
- C. Une augmentation de la précharge du ventricule gauche
- D. Une levée d'obstacle
- E. Une fracture du bassin

C

5. Parmi les étiologies de l'hypertension portale intrahépatique : (RF)

- A. les cirrhose
- B. La fibrose hépatique congénitale
- C. L'hyperplasie nodulaire régénérative
- D. Le syndrome de BUDD CHIARI
- E. La sclérose hépato portale

D

6. Parmi les causes de l'alcalose métabolique : (RF)

- A. Les apports massifs d'alcalins
- B. La destruction massive osseuse
- C. Les pertes digestives d'acides
- D. Les pertes rénales d'acides
- E. Le défaut d'élimination de phosphates

E

7. L'état de choc par hémorragie digestive : (RJ)

- 1. Est la manifestation la plus grave d'une hémorragie digestive
- 2. Le pronostic vital est mis en jeu
- 3. Se manifeste quand la perte sanguine est entre 750 et 1500 ml
- 4. Peut-être révélateur d'une hémorragie digestivo cataclysmique
- 5. Peut-être dû à une rupture de varices oesophagiennes

A: 1,2,4,5 B: 1,3,5 C:2,3,4 D:1,2,3,4 E:3,4,5

A

PhysioPath (2021)

1. Les signes ECG d'une hyperkaliémie sont : (RF)

- A) Onde T haute , pointue et symétrique .
- B) Un affaissement de l'onde T
- C) Des anomalies de la conduction auriculaire
- D) Des anomalies de la conduction intraventriculaire
- E)Une tachycardie ventriculaire

B

2. Les déterminants majeurs de la pression artérielle sont :
- A) Le débit cardiaque
 - B) Les résistances périphériques totales
 - C) La fréquence cardiaque
 - D) Le volume d'éjection systolique
 - E) La fréquence respiratoire E
3. L'hypernatrémie traduit un trouble de l'hydratation, lequel : (RJ)
- A) Une hyperhydratation extracellulaire
 - B) Une déshydratation intracellulaire
 - C) Une hyperhydratation intracellulaire
 - D) Une déshydratation extracellulaire
 - E) Un état d'hydratation normale A

PhysioPath (2020)

1. Le facteur de stimulation de la sécrétion de rénine est : (RJ)
- A) L'atriopéptine
 - B) Le facteur natriurétique auriculaire
 - C) L'angiotensine.
 - D) Les β - mimétiques
 - E) L'augmentation du flux potassique D
2. La prostaglandine E2 exerce l'action biologique suivante : (RJ)
- A) Abaisse le débit de filtration glomérulaire
 - B) Augmente la perméabilité vasculaire
 - C) Stimule la lipolyse
 - D) Induit le relâchement des muscles intestinaux et utérin
 - E) Provoque la contraction des muscles bronchiques et vasculaires B
3. La baisse du volume du liquide extracellulaire entraîne une : (RJ)
- A) Baisse de la sécrétion de l'arginine - vasopressine
 - B) Natriurèse
 - C) Antidiurèse
 - D) Baisse de l'osmolarité du liquide extracellulaire
 - E) Augmentation du volume sanguin efficace C
4. Le Fibroblast Growth Factor - 23 (FGF - 23) : (RJ)
- A) Est une hormone principalement sécrétée par le tissu adipeux
 - B) A une action phosphaturiante tubulaire proximale
 - C) Stimule la sécrétion de calcitriol
 - D) Sa sécrétion est inhibée par les phosphates
 - E) Se lie au récepteur sensible au calcium (CaSR) B
5. L'élimination urinaire de potassium est stimulée par : (RF)
- A) L'hyperkaliémie .
 - B) L'aldostérone .
 - C) Un pH alcalin
 - D) Un pH acide .
 - E) Un débit urinaire élevé . D

6. Les signes ECG d'une hypokaliémie sont : (RF)
- A) Affaïssement de l'onde T
 - B) Onde T haute , pointue et symétrique
 - C) Augmentation d'amplitude de l'onde
 - D) Allongement de l'espace QU
 - E) Elargissement des complexes QRS . B
7. Le principal mécanisme compensateur au cours du choc hypovolémie est : (RJ)
- A) La baisse du débit cardiaque
 - B)L'hyperréactivité adrénergique
 - C) La libération de prostaglandines
 - D) La libération des kinines.
 - E) L'activation du facteur dépresseur myocardique B
8. L'insuffisance rénale aiguë est définie par une : (RF)
- A)Diminution brutale de la filtration glomérulaire
 - B)Augmentation de la créatinine plasmatique .
 - C) Augmentation de l'urée sanguine
 - D)Anurie
 - E)Anémie E
9. Chez un sujet diabétique , Indiquer le signe biologique qui caractérise précocement l'atteinte glomérulaire : (RJ)
- A) Diminution de la clairance de la créatinine
 - B) Présence de germes dans les urines
 - C)Hématurie
 - D)Micro albuminurie
 - E) Augmentation des leucocytes plasmatiques A

PhysioPath (2019)

1. L'hypernatrémie traduit quel trouble de l'hydratation :(Cochez la réponse exacte)
- A. Une hyperhydratation extracellulaire
 - B. Une déshydratation intracellulaire
 - C. Une hyperhydratation intracellulaire
 - D. Une déshydratation extracellulaire
 - E. Un État d'hydratation normale B
2. L'embolie pulmonaire massive provoque :(Cocher la réponse fausse)
- A. Un état de choc
 - B. Diminution de la Précharge du VG
 - C. Augmentation de la Précharge du VD
 - D. Diminution de la contractilité du VG
 - E. Augmentation de la fréquence cardiaque D
3. L'insuffisance rénale aiguë organique est due : (Cocher la réponse fausse)
- A. Ischémie rénale
 - B. Baisse prolongée du flux sanguin rénal
 - C. Aboutit à la nécrose des cellules tubulaires
 - D. Parenchyme rénale intacte
 - E. L'anurie accompagne souvent les formes sévères
- A: 1-2-3 B: 2-3-4 C: 3-4-5 D: 1-2-4 E: 2-4-5 E

4. Parmi les rôles du magnésium dans l'organisme : (Cocher la réponse fausse)
- A. Le gradient de magnésium joue un rôle très important dans l'excitabilité neuromusculaire
 - B. Il bloque la libération de l'acétylcholine
 - C. Il a un effet anticoagulant sur l'hémostase
 - D. Il intervient dans les réactions enzymatiques comme cofacteur
 - E. Il a un effet curarisant C
5. Le syndrome de Pickwick de l'obésité correspond à : (Cocher la réponse exacte)
- 1. Hypoventilation alvéolaire
 - 2. Hypercapnie chronique avec hypoxémie
 - 3. Hyperventilation alvéolaire
 - 4. Insuffisance cardiaque gauche
 - 5. Insuffisance cardiaque droite
- A : 1-2-3 B: 2-3-4 C : 3-4-5 D: 1-2-5 E: 2-4-5 D
6. Une plaie splénique profonde de plus de 01cm, sans atteinte hilare, sera classée selon AAST (American Association of Traumatology) : (Cocher la réponse exacte)
- A. Grade I
 - B. Grade II
 - C. Grade III
 - D. Grade VI
 - E. Grade V C

PhysioPath (2018)

1. Un des facteurs suivants diminue le débit de filtration glomérulaire : (RJ)
- A. Le monoxyde atrial d'azote.
 - B. Le facteur atrial natriurétique.
 - C. La caféine.
 - D. Les méthylxanthines.
 - E. Endothéline. E
2. Le site d'action des thiazides, au niveau du néphron est : (RJ)
- A. Le tube contourné proximal.
 - B. La branche ascendante de l'anse de Henlé.
 - C. Le tube distal.
 - D. Le tube collecteur cortical.
 - E. Le tube collecteur médullaire. C
3. L'hyperkaliémie peut être due à : (RF)
- A. Acidose métabolique.
 - B. Acidose respiratoire.
 - C. Insuffisance rénale.
 - D. Insuffisance surrénale.
 - E. Paralysie musculaire. E
4. Les mécanismes physiopathologiques responsables de l'insuffisance rénale aigue d'origine tubulaire sont : (RF)
- A. Lésions de la cellule tubulaire rénale.
 - B. Obstruction des tubules rénaux.
 - C. Activation du système rénine-angiotensine.
 - D. Compressions edémateuse des néphrons.
 - E. Augmentation de la synthèse des prostaglandines vasodilatatrices rénales.

5. Les signes ECG d'une hypokaliémie sont : (RF)
- A. Affaissement de l'onde T.
 - B. Onde T haute, pointue et symétrique.
 - C. Augmentation d'amplitude de l'onde U.
 - D. Allongement de l'espace QU.
 - E. Elargissement des complexes QRS. B
6. L'hypocalcémie peut être due à : (RF)
- A. Hypoalbuminémie.
 - B. Déficit en vit D.
 - C. Déficit en calcitonine.
 - D. Une pancréatite.
 - E. Une hyperparathyroïdie. E
7. Au cours de la phase initiale du choc hypovolémique, les résistances vasculaires systémiques sont : (RJ)
- A. Diminuées alors que le débit cardiaque est augmenté.
 - B. Augmentées alors que le débit cardiaque est diminué.
 - C. Augmentées avec un débit cardiaque diminué.
 - D. Diminuées avec débit cardiaque diminué.
 - E. Normales alors que le débit cardiaque est diminué. B
8. Le principal mécanisme compensateur au cours du choc hypovolémique est : (RJ)
- A. La baisse du débit cardiaque.
 - B. L'hyperréactivité adrénergique.
 - C. La libération de prostaglandines.
 - D. La libération des kinines.
 - E. L'activation du facteur dépresseur myocardique. B
9. Un choc hypovolémique peut être dû à : (RF)
- A. Un syndrome néphrotique.
 - B. Un hémithorax.
 - C. Une augmentation de la précharge du ventricule gauche.
 - D. Une levée d'obstacle.
 - E. Une fracture du bassin. C
10. Les facteurs thrombogènes sont :
- A. Plaque d'athérosclérose.
 - B. Insuffisance cardiaque.
 - C. Déficit héréditaire en facteurs de la coagulation.
 - D. Syndrome des antis phospholipides.
 - E. Les réponses A et B sont justes. C
11. L'embolie pulmonaire massive entraîne : (RF)
- A. Augmentation brutale de post charge du VD.
 - B. Augmentation du volume diastolique du VD.
 - C. Augmentation de la fraction d'éjection du VD.
 - D. Diminution de la précharge du VG.
 - E. Diminution du débit cardiaque. C

12. La première arme de compensation lors d'un bas débit cardiaque : (RJ)

- A. Stimulation des volorécepteurs.
- B. Stimulation des barorécepteurs.
- C. Stimulation du système rénine angiotensine aldostérone.
- D. Stimulation de la sécrétion de l'endothéline.
- E. Toutes les réponses justes.

B

PhysioPath (2017)

1/ Durant le sepsis toutes ces situation sont juste sauf une: (1RF)

- a- Rupture de l'équilibre entre les systèmes anti-inflammatoires et pro inflammatoires
- b- Présence d'une infection documentée
- c- Présence isolé d'un syndrome inflammatoire à réponse systémique
- d- Une CIVD peut la compliqué
- e- On peut avoir de l'hypothermie

C

2/ Le sepsis sévère peut engendrer : (1RF)

- a- Une oligurie
 - b- Une coagulopathie
 - c- Un choc cardiovasculaire
 - d- Une insuffisance respiratoire
 - e- Aucune anomalie d'organe
- A: a+b+c / B: a+e / C: a+b+d / D: c + e / E: c+d+e

D

3/ La résistance vasculaire périphérique : (1RF)

- a- Correspond à la force qui s'oppose au flux sanguin dans les vaisseaux
- b- Dépend du tonus de la musculature lisse artérielle
- c- Inversement proportionnelle à la quatrième puissance du rayon du vaisseau
- d- Directement proportionnelle avec la viscosité du sang et la longueur du vaisseau
- e- Dépend du niveau de sécrétion des catécholamines

B

4/ L'effet espace mort correspond: (1RJ)

- a- Zone non ventilée bien perfusée
- b- Zone bien perfusée et bien ventilée
- c- Diminution du rapport ventilation / perfusion
- d- Zone bien ventilée non perfusée
- e- Zone non ventilée non perfusée

D

5/ Dans la physiopathologie de l'insuffisance respiratoire aiguë on retrouve : (1RF)

- a- Une diminution de la Pao₂ (altitude...)
- b- Une défaillance de la fonction ventilatoire : hypoventilation alvéolaire
- c- Une défaillance de l'échangeur: barrière alvéolocapillaire
- d- Une diminution du transporteur d'oxygène (hémoglobine) en cas d'anémie
- e- Atteinte de la jonction neuromusculaire (myasthénie)

E

6/ L'obésité: (1RF)

- a- Traduit une obésité MORBIDE si IMC>40kg/m²
- b- Peut résulter d'un déséquilibre entre apports et dépenses énergétiques
- c- Peut entraîner des complications ostéo-articulaires
- d- Il n'existe pas de prédisposition génétique
- e- Peut résulter d'une résistance à la leptine

D

7/ l'hypoglycémie : (1RF)

- a- Peut évoluer vers le décès en l'absence de traitement urgent
- b- Son traitement doit être instauré en urgence et repose sur l'administration de sucre
- c- Peut être provoqué par un effort physique intense chez un patient diabétique
- d- Est définie par une baisse importante de la glycémie et nécessite l'insulinothérapie en urgence
- e- Peut provoquer des convulsions et un coma

D

8/ Parmi ces propositions, lesquelles peuvent entraîner une acidose métabolique: (1RJ)

- a- Perte intestinale de bases
- b- Ingestion excessive d'acide
- c- Hyperaldostéronisme et hypercorticisme
- d- Diminution d'élimination urinaire d'acide
- e- Vomissements importants

A: a+b+c / B: a+e / C: a+b+d / D: b+e / E: c+d+e

C

9/ Sur le plan physiopathologique, les ictères: (1RF)

- a- Pré hépatiques sont à bilirubine libre
- b- Post hépatiques sont des ictères hémolytiques
- c- Post hépatiques sont des ictères à bilirubine conjuguée
- d- Hépatiques peuvent-être dus à une anomalie de conjugaison de la bilirubine
- e- Hépatiques peuvent-être dus à une anomalie d'excrétion de la bilirubine conjuguée

B

10- L'œdème aigu du poumon hémodynamique est caractérisé par ? : (1RJ)

- a- Pression capillaire pulmonaire(PCP) augmenté
- b- Lésion de la membrane alvéolo-capillaire
- c- Présence d'effet shunt
- d- Une PaO2 diminuée avec shunt vrai
- e- Une PaO2 diminuée et PaCO2 diminuée ou augmentée

A: a+b+c / B: a+c+e / C: b+d+e / D: b+e / E: c+d+e

B

11/ Un recueil d'urines de 24H montre chez un individu une excrétion de créatinine bien inférieure à la normale.

Ceci peut être lié à quelle proposition parmi les suivantes :

- a- Une diminution de l'apport alimentaire de créatine
- b- Une insuffisance rénale
- c- Une masse musculaire supérieure à la normale résultant d'un gain de poids
- d- Un déficit génétique en enzyme qui convertit la créatine phosphate en créatinine
- e- Les propositions b et d sont exactes

E

PhysioPath (2016)

1. Une alcalose métabolique peut être due a: (1RJ)

- 1) L'administration de spironolactones
- 2) Des vomissements
- 3) Une diarrhée toxi-infectieuse
- 4) La ventilation d'une insuffisante respiratoire chronique décompensée
- 5) L'administration de furosemide

A- 1+3+5 B-1+2+3+5 C-2+3+4 D-2+4+5 E-3+4+5

D

- 1) Diarrhée chronique
- 2) Vomissements
- 3) Insuffisance rénale chronique
- 4) Administration de spironolactone (Aldactone)
- 5) Etat de choc

3. Parmi les désordres biologiques suivants que l'on observe dans le coma acido cétosique, un seul est exact. Lequel?

B

1. Le principal mécanisme compensateur au cours du choc hypovolémique est : (Cocher la réponse EXACTE)

A

D

DB

5. Un pH artériel à 7,20 avec un taux de bicarbonates à 32 $\mu\text{mol/l}$ et une PaCO_2 de 50 mmHg, correspond à: (Cocher la réponse EXACTE)
- A- Acidose métabolique
 - B- Acidose mixte
 - C- Alcalose métabolique
 - D- Acidose respiratoire
 - E- Alcalose respiratoire D
6. Lors d'une acidocétose diabétique, l'hyperventilation est due à: (Cocher la réponse EXACTE)
- A- L'insuffisance respiratoire
 - B- L'acidose respiratoire
 - C- L'effet shunt
 - D- L'acidose métabolique
 - E- La cétonurie D
7. Une natrémie de 128 mmol/l traduit: (Cocher la réponse EXACTE)
- A- Une hyperhydratation intracellulaire
 - B- Une hyperhydratation extracellulaire
 - C- Une déshydratation intracellulaire
 - D- Une déshydratation extracellulaire
 - E- Une hyperhydratation globale D
8. La survenue d'une thrombose veineuse peut être en rapport avec: (Cocher la réponse INEXACTE)
- A- Un déficit en antithrombine III
 - B- Un déficit en protéine
 - C- Un excès en protéine C
 - D- Une résistance à la protéine C
 - E- Un déficit en facteurs fibrinolytiques C
9. Quel état respiratoire et métabolique vous indiquent les valeurs suivantes? $\text{PaCO}_2 = 51$ mmHg (6,8 kPa), pH 7,55, $\text{HCO}_3^- 27$ mmol/l? (Cocher la réponse EXACTE)
- A- Acidose ventilatoire compensée
 - B- Alcalose ventilatoire compensée
 - C- Alcalose respiratoire non compensée
 - D- Alcalose métabolique compensée
 - E- Alcalose métabolique non compensée E
10. Le trou anionique:
- 1) Se calcule à partir de la formule: $(\text{Na} + \text{K}) - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$
 - 2) Se calcule à partir de la formule $(\text{Na}) - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$
 - 3) Est augmenté dans certaines acidoses respiratoires
 - 4) Représente les anions indosés du plasma
 - 5) L'excès plasmatique d'acide faible peut l'augmenter
- Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE
- A- 1+2+3 B- 2+3+5 C- 2+3+4 D- 1+3+5 E- 3+4+5 D

11. L'ADH:

- 1) Entraîne une concentration des urines
- 2) A son site d'action principal au niveau du tube contourné proximal
- 3) A son site d'action principal au niveau du tube collecteur
- 4) Est sécrété par la neurohypophyse
- 5) Entraîne une baisse de clairance de l'eau libre

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

A- 1+2+3 B-1+2+3+4 C-1+2+3+5 D-1+3+4+5 E-2+3+4 D

12. Un malade en insuffisance cardiaque globale a des œdèmes des membres inférieurs. Sa natrémie est de 128 mmol/l:

- 1) Le patient présente une hyperhydratation extracellulaire et intracellulaire
- 2) Le patient présente une hyperhydratation extracellulaire et une déshydratation intracellulaire
- 3) Le traitement doit comporter une restriction sodée avec apports liquidiens libres
- 4) Le traitement doit comporter une restriction hydrique associée à un régime normosodé
- 5) Le traitement doit comporter une restriction hydrique et sodée

Parmi les propositions suivantes cocher la proposition EXACTE

A- 1+4+5 B-1+5 C-2+5 D-4+5 E-3+4+5 B

13. La réabsorption rénale des bicarbonates:

- 1) A lieu au niveau proximal
- 2) Se fait grâce à une enzyme plasmatique appelée anhydrase carbonique
- 3) Entraîne la formation d'ion H^+ aussi réabsorbés
- 4) 90 % des bicarbonates filtrés sont réabsorbés.
- 5) Peut-être inhibée par l'acétazolamide D

❏ Radiologie ❏

(Radio : octobre 2024)

1. Quel est l'examen radiologique indiqué dans le cadre de l'urgence en cas de suspicion d'un AVC ? (Cocher la réponse juste)

- A. Anglo-scanner cérébral.
- B. IRM cérébrale.
- C. Scanner cérébral sans injection de produit de contraste.
- D. Angiographie cérébrale.
- E. Radiographie du crâne incidence de Blondeau

2. Un hématome sous dural aigu se présente au scanner comme : (Cocher la réponse juste)

- A. Collection biconcave hyperdense
- B. Collection biconcave hypodense
- C. Collection en croissant hypodense
- D. Collection en croissant hyperdense
- E. Le plus souvent hyperdense quand il arrive à sa phase chronique

3. Lorsque les vaisseaux pulmonaires restent visibles au travers d'une opacité sur une radiographie de face : (Cocher la réponse juste)

- A. C'est une masse médiastinale pathologique
- B. C'est une grosse artère pulmonaire
- C. C'est le signe de convergence hilair
- D. C'est le signe de la silhouette
- E. Les réponses A et C sont justes

4. Chez un polytraumatisé, les signes du choc hypovolémique retrouvés au scanner abdomino- pelvien injecté, sont : (Cocher la réponse fausse)

- A. Petite aorte
- B. Spasme des artères viscérales
- C. Rehaussement accentué de la rate et des surrénales
- D. Dilatation de la veine cave inférieure
- E. Intestins de choc

Radiologie (2022)

1. En IRM cérébrale, quelle est la séquence la plus sensible dans la détection des hémorragies intracrâniennes: (RJ)

- A. La séquence T2*
- B. La séquence de diffusion
- C. La séquence en pondération T2 FLAIR
- D. La séquence T1 avec saturation de la graisse
- E. La séquence T1 avec injection de gadolinium

A

2. La visibilité des vaisseaux pulmonaires au travers d'une opacité sur une radiographie de face témoigne :(RJ)

- A. D'une masse médiastinale pathologique
- B. D'une grosse artère pulmonaire
- C. D'un signe de convergence hilair
- D. D'un signe de la silhouette
- E. Les réponses A et C sont justes

E

3. Les signes précoces d'un AVC ischémique sur un sont : (RF)

- A. L'effacement du noyau lenticulaire
- B. Le signe de Delta
- C. La dédifférenciation substance blanche-substance grise
- D. L'effacement du ruban insulaire
- E. L'hyperdensité spontanée d'un vaisseau intracrânien

B

Radiologie (2021)

1. Quel est l'examen radiologique indiqué dans le cadre de l'urgence en cas de suspicion d'un AVC ? (RJ)

- A) Angio - scanner cérébral
- B) IRM cérébrale
- C) Scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- D) Angiographie cérébrale
- E) Radiographie du crâne Pavil

C

2. En IRM , quelle est la séquence la plus sensible dans la détection des AVC ischémiques ? (RJ)

- A) Séquence en pondération T2
- B) Séquence de diffusion avec
- C) Séquence T1 avec injection de gadolinium
- D) Séquence T2
- E) Toutes les réponses sont justes

B

3. Un hématome sous dural aigu se présente au scanner comme : (RJ)

- A) Une collection biconcave hyperdense
- B) Une collection biconcave hypodense
- C) Une collection en croissant hypodense
- D) Une collection en croissant hyperdense
- E) Le plus souvent hyperdense quand il arrive à sa phase chronique

D

Radiologie (2020)

1. Parmi les examens complémentaires suivants , lequel n'expose pas médecin aux radiations ionisantes ? (RJ)

- A) Coronarographie
- B) Artériographie
- C) Echographie
- D) Cathétérisme cardiaque
- E) Transit gastroduodéal

C

2. La tomodensitométrie (TDM) est un examen : (RF) A) De première ligne en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte

- B) De première intention en pédiatrie
- C) De choix dans le cadre de l'urgence
- D) Très performant en pathologie utérine et annexielle
- E) Qui ne représente pas la source majeure d'exposition aux rayonnements dans la population générale

D

3. A la radiographie standard tous les signes suivants sont en faveur e arthrose , sauf : (RJ)

A) L'ostéocondensation sous chondrale

B) Le pincement articulaire

C) L'ostéophytose

D) Les géodes .

E) La déminéralisation péri – articulaire

E

Radiologie (2019)

1. Un hématome sous dural aigu est présente au scanner comme : (Cocher la réponse exacte)

A. Collection biconcave hyperdense

B. Collection biconcave hypodense

C. Collection en croissant hypodense

D. Collection en croissant hyperdense

E. Le plus souvent hypodense quand il arrive à sa phase chronique D

2. En IRM, quelle est la séquence la plus sensible dans la détection des AVC ischémique ?
(Cocher la réponse exacte)

A. Séquence en pondération 12

B. Séquence de Diffusion avec calcul de l'ADC

C. Séquence T1 avec injection de gadolinium

D. Séquence T2

E. Toutes les réponses sont justes B

3. En IRM cérébrale, quelle est la séquence la plus sensible dans la détection des intracrâniennes : (Cocher la réponse exacte)

A. Séquence T2

B. Séquence De Diffusion

C. Séquence en pondération T2 Flair

D. Séquence T1 avec saturation de la graisse

E. Séquence T1 avec injection de gadolinium A

4. Quelle est l'échelle utilisée pour grader une hémorragie méningée ? (Cocher la réponse exacte)

A. Échelle de NORTON

B. Échelle de LUDWING

C. Échelle de FICHER

D. Échelle de BRISTOLE

E. Toutes les réponses sont fausses C

5. Les signes précoces d'un AVC ischémique sur un scanner non injecté, sont : (Cocher la réponse fausse)

A. Effacement du noyau lenticulaire

B. Signe de Delta

C. Dédifférenciation substance blanche substance grise

D. Effacement du ruban insulaire

E. Hyperdensité spontanée d'un vaisseau intracrânien B

6. Chez un polytraumatisé, les signes du choc hypovolémique retrouvés au scanner abdomino- pelvien injecté, sont : (Cocher la réponse fausse)

- A. Petite aorte
- B. Spasme des artères viscérales
- C. Rehaussement accentué de la rate et des surrénales
- D. Dilatation de la veine cave inférieure
- E. Intestins de choc

C

Radiologie (2018)

1. Classer ces tissus selon leur densité en TDM par ordre décroissant : (RJ)

- 1- Air. 2- graisse. 3- eau. 4- Os. 5- hématome aigu. 6- muscle.
A. 1-3-6-5-2. B-4-2-3-5-6-1 C-2-1-3-6-4-5 D-3-1-2-4-5-6. E-4-5-6-3-2-1

E

2. A propos des indications de la TDM : (RJ)

- A. Du fait de sa rapidité d'exécution, la TMD est l'examen de choix en pédiatrie.
- B. L'examen de première ligne en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte est l'angio-TMD.
- C. La TMD est très performante en pathologie utérine et annexielle.
- D. La TMD n'est pas un examen d'urgence,
- E. Aucune de ces propositions n'est juste.

E

3. Quel (s) est (sont) le(s) signe(s) radiologique(s) que l'on peut retrouver dans l'invagination intestinale aiguë : (RJ)

- A. Image en cocarde à l'échographie.
- B. Paucité des gaz intestinaux.
- C. Vacuité de la fosse iliaque droite à l'ASP.
- D. ASP normal.
- E. Tous ces signes peuvent être retrouvés.

E

4. L'examen radiologique le plus sensible pour le dépistage du cancer du sein est : (RJ)

- A. La glactographie.
- B. La mammographie.
- C. L'échographie.
- D. L'IM.
- E. Le scanner.

B

5. Vous êtes appelé à effectuer une échographie abdominale aux urgences chez un patient victime d'un accident de circulation, vous consultez l'existence d'un aspect anéchogène entre le foie et le rein droit, et au niveau du cul de sac de Douglas ; votre diagnostic est : (RJ)

- A. Abscès inter hépato rénal.
- B. Hémopéritoine.
- C. Pneumopéritoine.
- D. A et B sont justes.
- E. Aucune réponse n'est juste.

B

6. Lequel de ces examens radiologiques est plus sensible pour rechercher une ascite cloisonnée : (RJ)

- A. Echographie abdominale.
- B. ASP.
- C. Scanner abdominal.
- D. B et C sont justes.
- E. Tous ces examens.

C

7. Si une opacité du médiastin supérieur a un bord externe effacé au-dessus de la clavicule ; c'est qu'elle est : (RJ)

- A. Antérieure.
- B. Postérieure.
- C. Le cliché de profil permet de préciser son siège.
- D. Toutes ces réponses sont justes.
- E. Aucune de ces réponses n'est juste.

A

8. Une patiente consulte pour névralgie cervico-bachiale gauche évoluant depuis 3 mois. L'examen retrouve des douleurs suivant le triceps gauche avec diminution du réflexe tricipital gauche et épreuve de Barré positive. Les Rx centrées sur le rachis cervical C7 montrent une image d'arthrose vertébral associée à un pincement vertébral - vous compétez les examens par : (RJ)

- A. Une IRM médullaire.
- B. Un scanner lombo-sacré.
- C. Des tomographies du rachis cervical.
- D. Des clichés « bouche ouverte ».
- E. Un angio-scanner vertébral.

A

Radiologie (2017)

1/ Vous êtes appelé à effectuer une échographie abdominale aux urgences chez un patient victime d'un accident de circulation, vous constatez l'existence d'un aspect anéchogène entre le foie et le rein droit, et au niveau du cul de sac de Douglas; votre diagnostic est: (1RJ)

- a- Abscès inter hépato rénal
- b- Hémopéritoine
- c- Pneumopéritoine
- d- A et B sont justes
- e- Aucune réponse

B

2/ Lequel de ces examens radiologiques est plus sensible pour rechercher une ascite cloisonnée: (1RJ)

- a- Echographie abdominale
- b- ASP
- c- Scanner abdominal
- d- b et c sont justes
- e- Tous ses examens

C

3/ Pour l'étude cinétique du thorax on pratique : (1RJ)

- a- Une radioscopie
- b- Une radiographie
- c- Une tomodensitométrie
- d- Échographie thoracique
- e- IRM thoracique

A

4/ Si une opacité du médiastin supérieur a un bord externe effacé au dessus de la clavicule ; c'est qu'elle est : (1RJ)

- a- Antérieure
- b- Postérieure
- c- Le cliché de profil permet de préciser son siège
- d- Toutes ces réponses
- e- Aucune de ces réponses

A

5/ Le signe de silhouette: (1RF)

- a- L'opacité médiastinale antérieure sur le cliché de face efface le bord du cœur situé dans le même plan
- b- L'opacité parenchymateuse postéro-basale droite efface le bord droit du coeur
- c- Deux opacités de même densité radiologique sont dans le même plan s'il n'existe pas de limite entre elles
- d- Deux opacités de même densité radiologique sont dans des plans différents si une limite est individualisable entre elles
- e- Il permet de préciser la topographie d'une opacité intra thoracique par rapport à une autre opacité de même tonalité

B

6/ L'unité de mesure de densité tissulaire en TDM est: (1RJ)

- a- Mhz
- b- UH
- c- Bit
- d- Pixel
- e- Rad

B

7/ Les contre indications absolues de l'examen IRM sont : (1RJ)

- a- Claustrophobie
- b- Le port d'un pacemaker ou pile cardiaque ou défibrillateur cardiaque
- c- Clips neurochirurgicaux
- d- Femme enceinte de plus de 4mois
- e- Stent artériel de moins de 6 semaines

A: a+b+c+e / B: b+c+d / C: b+c+e / D: b+e / E: a+b+c+d+e

C

8/ Le caractère hyperdense de l'hématome aigu est dû à : (1RJ)

- a- Sa concentration en hémoglobine
- b- Sa teneur en iode
- c- Sa teneur en protéines
- d- La vitesse de sa constitution
- e- Aucune réponse n'est correcte

A

9/ L'atélectasie est une opacité d'un territoire pulmonaire devenu plus petit que normal : (1RF)

- a- Déplacement de la scissure: convexe vers le parenchyme sain
- b- Déplacement vertical du hile et déviation du médiastin du côté atteint
- c- Ascension de la coupole diaphragmatique
- d- Pincement costal et rétraction de l'hémithorax (tardif)
- e- Hyperclarté du territoire pulmonaire sain par hyperaération compensatrice

A

Radiologie (2016)

1. L'unité de mesure de densité tissulaire en TDM est:

- A- Megahertz
- B- Unité Hounsfield
- C- Bit
- D- Pixel
- E- Rad

B

2. Sur un cliché de radiographie thoracique de face, une opacité para-cardiaque droite de forme triangulaire à sommet hilair bien limitée n'effaçant pas le bord du cœur, associée à une ascension de la coupole diaphragmatique homolatérale. Il s'agit de: (1RJ)

- A- Pneumopathie lobaire inférieure droite
- B- Atelectasie du lobe moyen
- C- Epanchement pleural scissural de la petite scissure
- D- Atelectasie du lobe inférieur droit
- E- Aucune proposition n'est juste

D

3. Un polytraumatisé de la voie publique âgé de 40 ans en état de choc présentant une TDM cérébrale réalisée en urgence objective une collection péri-cérébrale spontanément hyperdense, réalisant l'aspect de lentille biconvexe avec effet de masse sur le parenchyme cérébral. Quelle est l'association juste:

- 1) Il s'agit d'un hématome extra dural chronique
- 2) Il s'agit d'un hématome sous dural aigu
- 3) Il s'agit d'un hématome extra dural aigu
- 4) Le caractère bien limité de la collection par une suture confirme le diagnostic
- 5) Il s'agit d'une urgence neurochirurgicale.

A- 1+4 5 B-4+5 C-2+4+5 D-3+4+5 E-3+4

D

4. La perforation d'un organe creux se traduit sur un ASP par: (1RJ)

- A- Niveaux hydro-aériques
- B- Croissant gazeux sous phrénique en position couché.
- C- Croissant gazeux sous phrénique en position debout.
- D- Matité des 02 flancs.
- E- Aucune réponse

C

5. L'aspect d'une lithiase vésiculaire à l'échographie est : (1RJ)

- A- Image hyperechogène sans cône d'ombre postérieur.
- B- Image hypoechogène sans cône d'ombre postérieur
- C- Image hyperechogène avec cône d'ombre postérieur.
- D- Image anéchogène.
- E- Aucune réponse.

C

Radiologie (2015)

1. Le tube à rayons X comprend :

- 1) Une enceinte sous vide faite d'une ampoule en verre
- 2) Une source d'électrons constituée d'un filament porté cathode à l'incandescence qu'on appelle
- 3) Une anode constituée d'une pièce métallique de tungstène qui assure le freinage des électrons accélérés et produit les rayons X
- 4) Une ampoule en verre enfermée dans une gaine plombée avec seulement une fenêtre qui laisse passer le faisceau à rayons X
- 5) L'anode est associée à un dispositif de réchauffement.

Parmi les propositions suivantes, cocher la réponse EXACTE

- A- 1+2+3 B-1+2+3+4 C-2+3+4+5 D-1+2+3+4+5 E-1+3+4+5 B

2. Les rayons X ont pour propriétés :

- 1) de traverser le corps humain d'autant plus facilement qu'ils sont pénétrants (de haute tension)
- 2) au cours de cette traversée du corps humain le faisceau de rayons subit un certain affaiblissement qui est d'autant plus important que l'épaisseur et la densité du corps considéré sont plus élevées
- 3) ils produisent un rayonnement diffusé dans les corps qu'ils traversent qui est d'autant plus important que le volume irradié et le kilo voltage utilisés sont faibles
- 4) ils provoquent l'illumination de certains sels minéraux. Cette propriété est utilisée au niveau des écrans de radioscopie et des écrans renforceurs placés au contact du film
- 5) ils provoquent un noircissement des émulsions photographiques C

Parmi les propositions suivantes, cocher la réponse EXACTE

- A- 1+2+3+4 B-2+3+4+5 C-1+2+4+5 D-1+2+5 E-3+4+5

3. Les quatre densités fondamentales du corps humain en radiologie conventionnelle sont par ordre croissant comme suit: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Densité calcique, aérique, hydrique, grasseuse
- B- densité aérique, calcique, grasseuse, hydrique
- C- densité hydrique, aérique, grasseuse, calcique
- D- densité aérique, grasseuse, hydrique, calcique
- E- densité grasseuse, hydrique, aérique, calcique

D

4. L'atélectasie ou opacité pulmonaire rétractile se traduit en radiologie par :

- 1) une opacité d'un territoire pulmonaire devenu plus petit que normalement
- 2) un déplacement du hile
- 3) un déplacement du médiastin du côté de l'atélectasie
- 4) un abaissement de la coupole
- 5) une hyper clarté du territoire pulmonaire sain par hyper réaction compensatrice

Parmi les propositions suivantes, cocher la réponse EXACTE

A- 1+2+3+4 B-2+3+4+5 C-1+2+3+5 D-1+2+5 E-3+4+5 C

5. Le pneumothorax ou épanchement pleural aérien donne les signes radiologiques suivants :

- 1) une plage d'hyper transparence avec absence de vaisseaux en son sein
- 2) un poumon collabé autour du hile
- 3) une visibilité du feuillet viscéral de la plèvre sous forme d'un liseré net limitant le parenchyme pulmonaire
- 4) présence d'un niveau hydro-aérique quand un épanchement pleural liquidien associé
- 5) un déplacement des organes du médiastin vers le côté du pneumothorax

Parmi les propositions suivantes, cocher la réponse EXACTE

A- 1+2+3+4 B-2+3+4+5 C-1+2+3+5 D-1+2+5 E-3+4+5 C

6. Dans les appareillages d'échographie, un transducteur est un émetteur: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- d'ultrasons pulsés
- B- de rayons X
- C- d'ondes électromagnétiques
- D- de rayonnement alpha
- E- de rayonnement bêta A

7. Le flou cinétique: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Est produit par le mouvement du corps radiographié
- B- Pour le diminuer il faut faire les radiographies des régions mobiles avec un temps de pose court
- C- Au scanner le flou cinétique provoqué par un malade agité ou un enfant turbulent peut nécessiter l'injection de valium pour endormir ce type de patient
- D- Les réponses A, B et C sont justes
- E- Les réponses A, B et C sont fausses E

8: Le rayonnement diffusé: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Est plus important quand on radiographie des régions épaisses du corps humain
- B- C'est un rayonnement parasite qui altère la qualité de l'image
- C- Pour lutter contre ce type de rayonnement on doit utiliser une grille anti diffusante quand on radiographie des zones épaisses du corps humain
- D- Les réponses A, B et sont fausses
- E- Les réponses A, B et sont justes D

9. L'échographie est une technique d'imagerie médicale: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Qui utilise les ultrasons
- B- Qui n'est pas très chère et que l'on peut répéter sans danger
- C- Dont les indications sont larges
- D- Qui utilise la même sonde pour l'exploration de tous les organes D
- E- Qui utilise des sondes de fréquence différente pour les organes superficiels et profonds

10. La tomodensitométrie ou scannographie est une technique d'imagerie médicale :
(Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Irradiante
- B- Ou l'injection de produit de contraste est nécessaire dans certaines pathologies
- C- Qui permet la reconstruction d'images dans tous les plans de l'espace
- D- Qui peut donner des artéfacts liés au matériel métallique et aux mouvements du patient
- E- Non irradiante E

11. La petite scissure: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Sépare le lobe supérieur droit du lobe moyen droit
- B- Peut être visible sur le cliché du thorax en incidence de face
- C- Peut être visible sur le cliché du thorax en incidence de profil
- D- Est toujours visible sur l'incidence de face et de profil du thorax
- E- N'existe pas au niveau du poumon gauche D

12. Le pneumothorax: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Donne une plage d'hyper clarté avec absence de vaisseaux en son sein
- B- Donne un poumon collabé autour du hile
- C- Peut donner une visualisation du feuillet viscéral de la plèvre sous forme d'un liseré dense opaque
- D- Il est mieux visualisé sur le cliché en expiration quand il est de petite abondance
- E- Est toujours bien visualisé sur le cliché en inspiration même quand il est de petite abondance E

13. La technique d'imagerie médicale non irradiante, pas trop couteuse, la plus disponible qui permet de faire le diagnostic d'épanchement péritonéal liquidien et d'aider à son diagnostic étiologique est : (Cocher la réponse EXACTE)

- A- L'ASP
- B- L'échographie
- C- Le scanner
- D- L'imagerie par résonnance magnétique
- E- Le téléthorax B

14. La structure du corps humain qui absorbe le moins de rayons X est: (Cocher la réponse EXACTE)

- A- Les poumons
- B- La graisse
- C- Les muscles
- D- Les organes pleins (foie, reins, rate)
- Le squelette A